

Contribution de l'OMS à Djibouti

Rapport d'évaluation



Contribution de l'OMS à Djibouti: rapport d'évaluation [WHO contribution in Djibouti: evaluation report]

ISBN 978-92-4-012264-2 (version électronique)

ISBN 978-92-4-012265-9 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé 2026

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci-dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Contribution de l'OMS à Djibouti: rapport d'évaluation [WHO contribution in Djibouti: evaluation report]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2026. Licence : [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](#).

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Conformément à la [Politique d'évaluation de l'OMS de 2018](#) (EB143(9)), cette publication contient un rapport d'évaluation indépendant réalisé par le Bureau de l'évaluation de l'OMS. La présente publication ne reflète pas les opinions ou les politiques de l'OMS.

Légende de la photo en page de couverture : Deux agents de santé font du porte-à-porte dans la ville de Djibouti pour la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite menée par le Ministère de la santé de Djibouti, l'UNICEF et l'OMS en octobre 2022.

Crédit : OMS/Zeinab Ismail

Sommaire

Remerciements.....	iv
Abréviations.....	v
Résumé d'orientation	vi
1. Introduction	1
2. Méthodologie	7
3. Résultats de l'évaluation	15
4. Conclusions	56
5. Recommandations	58
6. Enseignements à prendre en compte pour d'autres pays à revenu faible ou intermédiaire	63

Liste des tableaux

Tableau 1. Progrès réalisés au regard des cibles de l'ODD 3.....	1
Tableau 2. Priorités de l'OMS à Djibouti dans le cadre du treizième PGT 2018-2023	3
Tableau 3. Informations sur le financement du bureau de pays de l'OMS	4
Tableau 4. Évolution des indicateurs de résultats en matière de santé à Djibouti et comparaison avec les valeurs moyennes régionales pour les piliers relatifs aux objectifs du triple milliard (2021).....	18
Tableau 5. Alignement des priorités de l'OMS à Djibouti sur les cadres stratégiques.....	26

Liste des figures

Figure 1. Diagramme de la théorie du changement élaborée au cours de la phase initiale	10
Figure 2. La stratégie de coopération avec le pays, un outil pour mettre en œuvre le treizième PGT et orienter la coopération stratégique de l'OMS	28
Figure 3. Principales interventions menées par l'OMS à Djibouti entre 2019 et 2023.....	36
Figure 4. Performances par objectif stratégique, selon les scores des indicateurs clés de performance, pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale, de 2019 à 2022	40
Figure 5. Tableau de bord technique des produits pour Djibouti en 2020	43
Figure 6. Dépenses en USD par objectif stratégique du Bureau de l'OMS à Djibouti au cours des deux derniers exercices biennaux.....	47
Figure 7. Évolution des budgets du bureau de l'OMS à Djibouti consacrés au personnel et aux activités sur la période 2018-2023 (en USD)	48
Figure 8. Pourcentage des dépenses directes de mise en œuvre et d'équipement pour des tiers par rapport aux dépenses totales des activités	49

Remerciements

L'équipe d'évaluation tient à remercier l'équipe du bureau de l'OMS à Djibouti pour ses contributions perspicaces et ouvertes. Elle remercie tout particulièrement la D^{re} Reinhilde Van De Weerdt, représentante de l'OMS à Djibouti, et Fara-Had Hassan Farah, Chargé des relations extérieures, pour leur soutien tout au long de l'évaluation. L'équipe d'évaluation a apprécié les conseils, le soutien et les services d'assurance qualité fournis par les responsables de l'évaluation de l'OMS au niveau régional et au Siège, ainsi que les contributions des membres du Groupe de référence pour l'évaluation. Elle tient également à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la présente évaluation en partageant leur point de vue, en particulier les membres du Ministère de la santé de Djibouti, l'équipe de pays des Nations Unies, d'autres partenaires de la santé et du développement et les acteurs de la société civile à Djibouti.

Équipe d'évaluation

Florianne Gaillardin, Cheffe de l'équipe d'évaluation

Hassan Gouda Said, Consultant national

Responsables de l'évaluation

Claudia Lo Forte, Responsable de l'évaluation, Bureau de l'évaluation de l'OMS

Calistus Masika Wanjala, Chargé de l'évaluation au niveau régional, Bureau régional de la Méditerranée orientale

Anand Sivasankara Kurup, Responsable de haut niveau chargé de l'évaluation, Bureau de l'évaluation de l'OMS

Groupe de référence pour l'évaluation

Le Groupe de référence pour l'évaluation réunissait des points focaux techniques et de hauts responsables de l'OMS à Djibouti et du Bureau régional de la Méditerranée orientale, ainsi que des hauts fonctionnaires du Ministère de la santé de la République de Djibouti, et des hauts responsables du Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies et de l'UNICEF.

Abréviations

AFD	Agence française de développement
AIEA	Agence internationale de l'énergie atomique
CAMME	Centrale d'achats de matériels et médicaments essentiels
CERF	Fonds central pour les interventions d'urgence des Nations Unies
CNSS	Caisse nationale de sécurité sociale
COVID-19	maladie à coronavirus 2019
CSU	couverture sanitaire universelle
DDI	Division Données, analyse et résultologie
DHIS2	système d'information sanitaire
DIS	Direction de l'information sanitaire
DTC3	troisième dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
GNUE	Groupe des Nations Unies pour l'évaluation
GPS	Groupe des partenaires santé
GSM	Système mondial de gestion
HCR	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
HEARTS	Guide technique pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans le cadre des soins de santé primaires
IBBS	enquête de surveillance bio-comportementale intégrée
IGAD	Autorité intergouvernementale pour le développement
IHP+	Partenariat international pour la santé
IMEP	Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite
INSPD	Institut national de santé publique de Djibouti
JPRM	mission conjointe gouvernement/OMS pour l'examen des programmes
MGF/E	mutilations génitales féminines et excision
mhGAP	Programme d'action Comblant les lacunes en santé mentale
MII	moustiquaire imprégnée d'insecticide
MNT	maladies non transmissibles
MTN	maladies tropicales négligées
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
ODD	objectif de développement durable
OIM	Organisation internationale pour les migrations
OIT	Organisation internationale du Travail
ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
PAM	Programme alimentaire mondial
PEV	Programme essentiel de vaccination
PGT	programme général de travail
PNDS	Plan national de développement de la santé
PNUAD	Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
RAM	résistance aux antimicrobiens
RSI	Règlement sanitaire international (2005)
SCAPE	plan stratégique de développement économique et social de Djibouti
sida	syndrome d'immunodéficience acquise
SRMNE	santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
USD	dollar des États-Unis
VIH	virus de l'immunodéficience humaine

Résumé d'orientation

Contexte

L'évaluation de la contribution de l'OMS à Djibouti a été demandée par le bureau de l'OMS à Djibouti et commandée conjointement par le Bureau de l'évaluation de l'OMS et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Cette évaluation a eu lieu à un moment où Djibouti était en pleine transition et entreprenait de nouveaux processus visant à appuyer le Ministère djiboutien de la santé. Compte tenu des progrès réalisés en matière de développement économique [\(1\)](#), Djibouti devrait bientôt rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Malgré une situation économique et des conditions de sécurité favorables, l'une des difficultés rencontrées par Djibouti, décrite dans sa Vision 2035, est de faire en sorte que la croissance économique se traduise par des bénéfices concrets pour toutes les catégories de la population. En dépit de ses avancées, Djibouti n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé. Par rapport aux autres pays de la région, Djibouti enregistre de moins bonnes performances pour les indicateurs liés à la bonne santé et au bien-être tels que le rapport de mortalité maternelle (244 décès pour 100 000 naissances vivantes à Djibouti en 2019 contre 179 dans l'ensemble des pays de Méditerranée orientale) ou le taux de mortalité infantile (46 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2021 contre 36 dans la région) [\(2\)](#).

Objectif et champ d'application

L'évaluation formative et sommative de la contribution de l'OMS à Djibouti a principalement pour objectif de rendre compte des résultats obtenus et de tirer des enseignements, le but étant d'éclairer les futures orientations stratégiques de l'OMS dans le pays et la région. Elle porte sur toutes les interventions humanitaires et de développement entreprises par les trois niveaux de l'OMS (bureau de pays, bureau régional et Siège) au cours des trois derniers exercices biennaux (2019-2023).

Objet

L'évaluation porte sur la contribution de l'OMS à Djibouti. Bien que l'OMS soit présente à Djibouti depuis 50 ans, le bureau de pays ne dispose actuellement d'aucune stratégie de coopération avec le pays, la dernière en date couvrant la période 2013-2016. L'OMS fait partie de l'équipe de pays des Nations Unies et mène ses activités conformément au Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2022-2024.

Le budget total alloué à Djibouti pour la période 2019-2023 s'élevait à 20 471 610 dollars des États-Unis (USD) au titre des activités et à 6 743 395 USD au titre du personnel, soit l'équivalent de huit postes à temps plein. Entre 2019 et 2023, les actions prioritaires visaient à donner à Djibouti les moyens d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de couverture sanitaire universelle (CSU) et de soins de santé primaires (SSP). Il s'agissait également de lui apporter un appui dans le contexte des interventions d'urgence. Un autre volet du travail de l'OMS au cours des quatre dernières années a consisté à répondre à la crise de la COVID-19 et à fournir un soutien aux systèmes de surveillance et de prévention des infections, ainsi qu'aux systèmes de riposte et de préparation aux infections.

Méthodes

L'équipe a utilisé une approche basée sur la théorie consistant à reconstituer une théorie du changement pour tester les hypothèses et les trajectoires menant aux résultats escomptés. La théorie du changement a été examinée avec l'équipe de l'OMS à Djibouti à la fin de la mission dans le pays, et une version révisée a été produite sur la base de cet examen. Tant dans sa démarche que dans son contenu, l'évaluation adopte une perspective d'égalité des genres et d'équité en santé, et prend en compte, dans la mesure du possible, les questions des droits humains et de l'inclusion du handicap. L'équipe d'évaluation a utilisé des méthodes mixtes pour répondre aux questions d'évaluation. Les données sont issues de l'examen de plus de 60 documents et bases de données quantitatives, d'entretiens individuels avec 67 répondants (42 hommes et 25 femmes) et de trois discussions de groupe avec sept représentants de l'équipe de pays des Nations Unies, 12 agentes de mobilisation et cinq membres d'une association de défense des droits des minorités. L'équipe d'évaluation a effectué une visite d'une semaine sur le terrain, à Djibouti. Elle s'est efforcée de consulter toutes les parties prenantes OMS concernées aux trois niveaux : le Gouvernement djiboutien, les Nations Unies et d'autres organismes multilatéraux et organismes de financement, ainsi que la société civile, les prestataires et les utilisateurs de services de santé. La plupart des personnes consultées vivaient à Djibouti, mais des entretiens ont également été réalisés à distance avec des acteurs à l'étranger.

Principales conclusions

Pertinence : Les objectifs et la conception des interventions de l'OMS permettent de répondre aux priorités de Djibouti en matière de santé ainsi qu'aux besoins sanitaires de la population d'après les indicateurs de résultats du système de santé.

L'OMS met l'accent sur l'équité en santé en s'attaquant aux obstacles géographiques aux soins de santé et en veillant à l'inclusion des populations migrantes et réfugiées dans les interventions sanitaires. Cependant, le genre, l'inclusion du handicap et les droits humains ne sont pas systématiquement pris en compte dans l'élaboration des interventions de l'OMS. Les interventions de l'OMS sont axées sur l'octroi d'une assistance technique et le renforcement des capacités dans des domaines d'activité spécifiques, tels que le programme essentiel de vaccination, la santé de la mère et du nouveau-né, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la tuberculose et le paludisme, les maladies non transmissibles et la santé mentale, alors que les enjeux au niveau du système de santé mériteraient un soutien accru. Il s'agirait notamment de renforcer le leadership et l'autorité du Ministère de la santé en matière de réglementation vis-à-vis de tous les acteurs du système de santé, d'assurer la disponibilité d'un ensemble de services essentiels au niveau des soins primaires, de contribuer à l'institutionnalisation d'un système d'agents de santé communautaires et de traiter les problèmes de santé dans la sous-région de la Corne de l'Afrique, par exemple en ce qui concerne les soins de santé pour les populations migrantes.

Cohérence : La cohérence interne et externe des interventions de l'OMS à Djibouti est inégale. La mission conjointe gouvernement/OMS pour l'examen des programmes (JPRM ou Joint Government/WHO Programme Review Mission), document biennal et principal outil de planification de l'OMS à Djibouti, a été établie à partir d'un processus rigoureux de consultation avec le Ministère de la santé. Elle est structurée de manière à correspondre au cadre de résultats du treizième programme général de travail (treizième PGT) de l'OMS et aux domaines prioritaires en matière de santé du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Toutefois, l'absence de stratégie valide de coopération avec le pays et de plan biennal d'appui au pays décrivant la contribution des trois niveaux de l'Organisation nuit à la cohérence interne et à la hiérarchisation efficace des activités de soutien de l'OMS à moyen et à long terme. L'absence de plans opérationnels et de budgets pour la mise en œuvre du Plan national de développement de la santé (PNDS), qui permettraient d'orienter le positionnement des partenaires quant aux priorités définies par le Ministère, constitue un obstacle à la coordination et à la cohérence externe entre les interventions de l'OMS et celles des partenaires du secteur de la santé. Ainsi, la coordination avec les partenaires du secteur de la santé en dehors du système des Nations Unies est médiocre. En outre, l'absence de plateforme de coordination fonctionnelle des organismes de santé pilotée par les pouvoirs publics limite la capacité de l'OMS et d'autres organismes à faire preuve de complémentarité dans le soutien apporté au Ministère de la santé. Malgré les efforts déployés par l'OMS, la participation de la société civile à la gouvernance de la santé est faible et l'Organisation n'échange pas de manière significative avec les réseaux d'utilisateurs des

services. La participation de l'OMS aux actions de santé publique multisectorielles, concernant par exemple les maladies non transmissibles (MNT) et la résistance aux antimicrobiens (RAM), est limitée.

Efficacité : L'efficacité des interventions de l'OMS au regard des résultats escomptés a évolué au fil de temps, et une nouvelle dynamique a été observée lors du dernier exercice biennal (2022-2023). Certains facteurs, tels que la pandémie de COVID-19, l'instabilité des relations avec le Ministère de la santé et le fait que le poste de représentant de l'OMS soit resté vacant pendant un certain temps, ont limité la capacité de l'Organisation à mener à bien les interventions prévues. Les interventions de l'OMS sont principalement axées sur les produits relatifs à l'amélioration de l'accès à des services de santé essentiels de qualité dans le cadre du pilier CSU, ainsi que sur la riposte aux situations d'urgence, telles que la pandémie de COVID-19, dans le cadre du pilier Urgences sanitaires. De manière générale, les produits correspondant au pilier Amélioration de la santé des populations n'ont pas été réalisés, en partie en raison du manque de capacités du Ministère de la santé pour la coordination des travaux multisectoriels sur les déterminants de la santé et les facteurs de risque des MNT. Compte tenu des difficultés de mise en œuvre, en particulier au cours des exercices biennaux 2018-2019 et 2020-2021, les progrès de l'OMS dans la réalisation des produits sont inégaux. La plupart des activités ayant été mises en œuvre depuis 2022, il est difficile d'évaluer la contribution de l'OMS à l'évolution des résultats du système de santé en raison de l'absence de données récentes en la matière. Il existe toutefois des preuves solides de la contribution de l'OMS aux résultats positifs concernant les services de santé reproductive et de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant (SRMNE), la couverture vaccinale contre la COVID-19 et l'exhaustivité des données de surveillance. La contribution de l'OMS à l'équité en santé concerne essentiellement l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations migrantes et la réduction des obstacles géographiques à l'accès aux soins par la promotion des services de santé communautaires dans les régions. L'OMS a notamment contribué au succès d'un projet intégré visant à proposer des services de proximité pour la vaccination, les soins prénatals et la nutrition, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Ministère de la santé. L'ampleur de ces interventions est toutefois limitée, et les autres interventions de l'OMS ne sont généralement pas axées sur la promotion de l'égalité des genres, de l'équité en santé et du droit à la santé pour les différents groupes marginalisés.

Efficience : La capacité de l'OMS à produire des résultats de manière économique et dans les délais impartis est inégale. L'OMS a pu réaffecter rapidement ses ressources pour répondre aux urgences sanitaires, telles que la pandémie de COVID-19. Cependant, les interventions de l'OMS n'ont pas toujours été efficientes. L'OMS a souvent participé au financement de la mise en œuvre directe des projets à Djibouti, en rupture avec son mandat habituel dans les contextes non urgents. Les efforts menés actuellement aux fins de recrutement du personnel au niveau national s'avèrent utiles pour faciliter les relations avec les interlocuteurs et ainsi faire progresser la mise en œuvre des interventions prévues par l'OMS. Toutefois, le recours excessif à des consultants a des répercussions sur l'efficacité de l'OMS, car cela nuit à la stabilité de l'assistance technique apportée au Ministère de la santé et au suivi des activités prévues. Le nouvel organigramme de l'OMS n'a pas encore été mis en œuvre, les recrutements ayant pris du retard en raison de la lenteur des processus internes de gestion des ressources humaines au niveau du bureau régional. En ce qui concerne les systèmes de gestion axée sur les résultats, le suivi des produits et des résultats de l'OMS à Djibouti est insuffisant. Peu d'informations sont notamment communiquées en lien avec le système de tableau de bord des produits institutionnels, qui repose sur une autoévaluation du bureau de pays de l'OMS. Si les indicateurs clés de performance du bureau régional fournissent plus de détails sur les programmes, ils sont axés davantage sur les domaines techniques et moins sur les domaines transversaux de renforcement du système de santé. L'utilisation de données de suivi permettant d'éclairer les décisions programmatiques est limitée. Même si les programmes sont bien intégrés au niveau du bureau de pays, le cloisonnement des programmes à l'échelle du bureau régional et les demandes émanant de celui-ci empêchent parfois le bureau de pays de mettre l'accent sur les priorités définies. Dans le soutien qu'il apporte, le Siège de l'OMS se borne à pallier le manque de capacités techniques en réponse aux demandes du bureau de pays, et ce type de problèmes ne se pose donc pas.

Durabilité : La contribution de l'OMS à la résilience du système de santé et à la capacité à réagir aux chocs extérieurs est limitée, ce qui nuit à la pérennité des efforts de l'Organisation en matière de renforcement du système de santé. Le système de santé reste fragile et fragmenté, car les grands prestataires de services parapublics ne relèvent pas du Ministère de la santé. Le secteur de la santé publique est fortement tributaire du financement des donateurs. Or, le financement des principaux donateurs devrait diminuer au cours des prochaines années. Les partenaires financiers et le Ministère de la santé espèrent que l'OMS mettra davantage l'accent sur le financement durable du secteur de la santé.

Conclusions

Conclusion 1

Pertinence : De manière générale, les interventions de l'OMS se révèlent très pertinentes au regard des besoins du pays en matière de santé. Cependant, les priorités ne sont pas toujours établies à partir de données probantes sur le système de santé et les résultats en matière de santé. Les interventions de l'OMS ne sont pas guidées par une analyse de la situation des groupes vulnérables dans le pays. L'Organisation mettant l'accent sur l'octroi d'une assistance technique aux programmes axés sur les maladies, au détriment d'une approche orientée sur les soins de santé primaires, elle n'est pas en mesure de réaliser le plein potentiel de sa contribution aux objectifs relatifs à la CSU. La période actuelle offre à l'OMS à Djibouti une occasion unique de redéfinir son rôle et de recentrer ses efforts de manière stratégique, compte tenu de l'ambition croissante affichée par Djibouti de rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure selon la classification de la Banque mondiale. Le bureau de pays a également la possibilité de renforcer son rôle au niveau régional et dans plusieurs processus de planification stratégique en cours dans le pays. L'évaluation a permis de recenser plusieurs domaines dans lesquels l'OMS peut apporter une valeur ajoutée et mettre son rôle à profit pour renforcer le système de santé.

Conclusion 2

Cohérence : L'OMS est en phase avec les autres partenaires de la santé à Djibouti et joue un rôle complémentaire du leur ; cependant, la cohérence interne et externe des activités de l'OMS est entravée par l'absence de stratégie valide de coopération avec le pays, de plans opérationnels et de budgets permettant de mettre en œuvre le PNDS, ainsi que par l'absence de plateforme de coordination pour les acteurs de la santé à Djibouti. L'absence de stratégie valide de coopération avec le pays et de plan biennal connexe d'appui au pays, dans lesquels serait décrite la contribution des trois niveaux de l'OMS, ne permet pas à l'Organisation de hiérarchiser efficacement ses interventions. La future stratégie de l'OMS doit impérativement s'attaquer aux freins qui entravent la mise en œuvre efficace du PNDS. Il existe des exemples de collaborations fructueuses pour l'OMS au sein de l'équipe de pays des Nations Unies ; toutefois, la coordination avec les principaux partenaires de la santé en dehors de l'équipe de pays est limitée, faute de plateforme fonctionnelle et officielle pilotée par le Ministère de la santé. Pour que l'OMS se positionne différemment sur ces questions, elle doit modifier le type d'activités mises en œuvre. En effet, l'Organisation ne remplit pas pleinement sa mission de chef de file et son rôle fédérateur, qui font partie de son mandat. Il faudrait également changer la perception que certains partenaires ont de l'OMS, celle d'un petit organisme donateur. Malgré ses efforts, l'OMS ne parvient pas à promouvoir une approche de la gouvernance du secteur de la santé mobilisant l'ensemble de la société et des pouvoirs publics ni à obtenir la participation de toutes les parties prenantes multisectorielles.

Conclusion 3

Efficacité : Si l'OMS a clairement contribué à améliorer les résultats du système de santé en matière de services de santé maternelle et néonatale, de traitement de la tuberculose et de disponibilité des informations sanitaires, dans l'ensemble, la mise en œuvre des interventions prévues s'avère insuffisante. Entre 2018 et 2021, les interventions prévues par l'OMS ont été retardées, car les ressources humaines et financières étaient pour l'essentiel réaffectées à la riposte aux situations d'urgence et aux flambées épidémiques. En outre, l'efficacité des contributions de l'OMS à Djibouti a été restreinte par le changement de représentants de l'OMS, ainsi que par l'instabilité de sa relation avec le Ministère de la santé. Néanmoins, l'OMS a apporté un soutien efficace à la riposte d'urgence des autorités publiques nationales à la COVID-19. Au regard de ce que prévoyait la JPRM, peu d'interventions ont porté sur la préparation aux situations d'urgence et sur le pilier Amélioration de la santé des populations. En dehors des interventions visant à pallier l'absence de services de santé communautaires pour réduire les obstacles à l'accès aux soins de santé, l'action menée par l'OMS à Djibouti n'intègre pas systématiquement l'analyse de l'égalité des genres et de l'équité en santé ou encore les droits des différents groupes marginalisés.

Conclusion 4

Efficience : Dans l'ensemble, une grande partie des ressources ont été consacrées à la mise en œuvre directe, ce qui ne constitue sans doute pas l'utilisation la plus efficiente des ressources dans le contexte de Djibouti. De plus, les ressources octroyées sont insuffisantes pour permettre à l'OMS d'atteindre ses objectifs. Si la capacité de l'OMS à répondre aux besoins du Ministère de la santé et aux différentes demandes s'avère satisfaisante, en particulier dans les situations d'urgence sanitaire, l'Organisation doit trouver l'équilibre entre la souplesse nécessaire et le maintien d'une position stratégique quant aux priorités définies. Compte tenu de la lenteur des processus de recrutement, les ressources humaines du bureau de pays ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Organisation de concrétiser ses ambitions. En augmentant ses effectifs, le bureau de pays pourrait assumer davantage de responsabilités, notamment remplir son rôle fédérateur et sa fonction de chef de file dans le secteur de la santé, renforcer le système de santé et participer aux initiatives régionales. À ce jour, les données de suivi ne permettent pas de rendre compte des activités menées par le bureau de pays et ne sont pas suffisamment utilisées pour orienter la programmation. Bien que crucial dans de nombreux domaines techniques, le soutien du bureau régional n'est pas toujours apporté en temps utile et ne correspond pas toujours aux priorités nationales.

Conclusion 5

Durabilité : La contribution de l'OMS à un système de santé plus résilient s'avère limitée et la préparation aux situations d'urgence reste insuffisante. Dans l'ensemble, l'investissement des pouvoirs publics dans le système de santé public est fragmenté entre différents mécanismes de prestation de services. Les programmes gérés par le Ministère de la santé ayant fait l'objet de peu d'investissements, ils sont particulièrement vulnérables en cas de réduction de l'aide extérieure. Il est donc nécessaire de mettre en place des réformes et d'adopter de nouvelles réglementations permettant de réduire la fragmentation, et de soutenir le financement pérenne du secteur de la santé, tout en préparant une transition vers une augmentation des financements nationaux et une meilleure appropriation nationale des programmes de santé.

Recommandations

Recommandation 1

Au cours des cinq prochaines années, le bureau de pays et le bureau régional de l'OMS doivent accorder la priorité aux interventions de renforcement du système de santé et élaborer une approche des soins de santé primaires servant de cadre général à la mise en œuvre des activités spécifiques aux programmes. Il convient pour cela de renforcer le système de santé, en mettant l'accent sur les domaines où les indicateurs de santé accusent un retard, en plaidant en faveur d'une réforme du secteur de la santé fondée sur l'harmonisation du système de santé, qui permettrait de fournir un ensemble de services essentiels, en appuyant l'institutionnalisation des services de santé communautaires et en veillant à l'analyse et à l'élimination des obstacles à l'accès aux soins de santé pour les différentes catégories de la population.

Recommandation 2

Les futures interventions de l'OMS doivent systématiquement s'attaquer aux obstacles à l'accès aux soins de santé et agir sur les déterminants de la santé. Il s'agit en particulier d'apporter un soutien au développement des services de santé communautaires et à l'élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgence détaillant les rôles et les responsabilités des différents acteurs de la santé publique et parapublique, de répertorier et d'analyser les différents facteurs ayant un impact sur les inégalités en santé, de renforcer la capacité du système de santé à les prendre en compte, et de consacrer davantage de ressources à la mise en œuvre des interventions relevant du pilier Amélioration de la santé des populations.

Recommandation 3

D'ici à mars 2024, il convient d'affiner la théorie du changement reconstituée, qui servira de base à l'élaboration d'une stratégie de coopération avec le pays et du plan connexe d'appui au pays fondés sur des données probantes. La théorie du changement doit rendre compte des priorités stratégiques concernant le renforcement du système de santé, l'approche des soins de santé primaires et l'élimination des obstacles aux soins de santé (voir la recommandation 2). La stratégie de coopération avec le pays doit être fondée sur une analyse contextuelle des obstacles et des résultats en matière de santé et traduire le cadre de résultats du treizième PGT en cibles spécifiques à Djibouti. Ces documents doivent être conformes au PNDS et doivent définir la contribution de l'OMS aux cibles nationales ainsi qu'aux objectifs communs des Nations Unies. La stratégie de coopération avec le pays doit être accompagnée d'un plan biennal d'appui au pays, qui viendra remplacer la JPRM, et qui décrira la contribution attendue des trois niveaux de l'Organisation à Djibouti.

Recommandation 4

Aux niveaux national et régional, l'OMS doit aider le Ministère de la santé à renforcer son rôle de leadership et de coordination. Il convient pour cela de fournir une assistance technique continue à la mise en œuvre du PNDS, de soutenir l'examen de ce plan et l'élaboration d'un nouveau plan, d'améliorer la coordination des acteurs du secteur de la santé en relançant les activités du Groupe des partenaires santé (GPS), et d'activer les mécanismes mondiaux existants de coordination des donateurs au niveau national.

Recommandation 5

L'OMS doit améliorer son efficacité en favorisant une approche mobilisant l'ensemble de la société et des pouvoirs publics. Pour cela, elle doit rechercher des moyens d'élargir la participation de la société civile et des acteurs communautaires au secteur de la santé et permettre au Ministère de la santé de coordonner les travaux multisectoriels dans les domaines nécessitant une collaboration entre différents ministères.

Recommandation 6

Il convient de renforcer l'efficacité de l'OMS en améliorant l'allocation des ressources financières, en renforçant les ressources humaines et en faisant progresser les systèmes de gestion. Il s'agit pour cela de mettre en œuvre rapidement un nouvel organigramme du bureau de pays permettant de combler les lacunes en matière de capacités administratives et techniques dans le but de soutenir les nouvelles ambitions de l'OMS à Djibouti. Au niveau régional, l'OMS doit soutenir le bureau de pays en adoptant une approche rationalisée et axée sur les pays.

Recommandation 7

Il convient de veiller à ce que la stratégie de coopération avec le pays soit accompagnée d'un cadre de suivi définissant des valeurs de référence et des valeurs cibles pour les indicateurs de Djibouti, conformément au cadre de résultats mondial et au cadre régional des indicateurs clés de performance. Il convient également d'améliorer la qualité de la communication des données et d'utiliser davantage les données de suivi pour le ciblage des interventions.

Recommandation 8

En collaboration avec d'autres partenaires de développement, l'OMS doit aider activement le Gouvernement à mener une réforme du secteur de la santé. Pour cela, elle doit renforcer le leadership, le rôle de coordination et le pouvoir réglementaire du Ministère de la santé vis-à-vis de tous les acteurs participant à la prestation de services de santé, et apporter un appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de financement du secteur de la santé.

1. Introduction

1.1 Cadre général et contexte

L'évaluation de la contribution de l'OMS à Djibouti a été demandée par le Bureau de l'Organisation à Djibouti et commandée conjointement par le Bureau de l'évaluation de l'OMS et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

L'évaluation s'est déroulée à un moment où le bureau de pays était en pleine transition, et mettait en route de nouveaux processus visant à aider le Ministère djiboutien de la santé. Plusieurs processus de planification étaient en cours, tels que l'examen et l'élaboration du Plan national de développement (2020-2024), la révision du Plan national de développement de la santé (PNDS) en vue de l'élaboration du plan suivant pour la période 2020-2024, ainsi que la révision et l'élaboration du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (2022-2024). L'un des principaux objectifs de l'évaluation était donc d'éclairer les futurs travaux de planification et d'orientation stratégique de l'OMS.

En 2023, la population de la République de Djibouti était estimée à 1,1 million d'habitants [\(3\)](#) répartis sur une superficie de 23 200 km, Djibouti étant le plus petit pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Depuis son indépendance, Djibouti est un pôle de stabilité dans la Corne de l'Afrique, les pays voisins étant confrontés à des problèmes d'insécurité et à d'instabilité politique. Le pays enregistre un fort taux de croissance, celui-ci ayant été estimé à 7 % par an entre 2015 et 2019. Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu des conséquences considérables sur l'économie, Djibouti devait renouer avec les taux de croissance pré-pandémie dès 2022.¹ Les revenus nationaux sont liés au développement des infrastructures portuaires et aux plateformes logistiques associées aux voies de trafic maritime passant par le golfe d'Aden, aux dividendes des cinq bases militaires étrangères situées sur le territoire et au secteur de la communication. Compte tenu de ses progrès économiques, Djibouti devrait bientôt rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Bien que la situation économique et les conditions de sécurité dans le pays soient favorables, plusieurs difficultés pèsent sur la santé et le bien-être de la population. Les changements climatiques engendrent une forte insécurité alimentaire et conduisent à l'extrême pauvreté des populations rurales et nomades des régions situées en dehors de la capitale. Le pays connaît un exode rural important vers la capitale et ses banlieues, qui abritent 70 % de la population.

Djibouti n'est pas en voie d'atteindre le troisième objectif de développement durable (ODD 3) relatif à la bonne santé et au bien-être. En effet, la plupart des indicateurs évalués montrent que les progrès sont insuffisants pour atteindre les cibles d'ici à 2030, comme on peut le voir dans le tableau 1 ci-dessous. Pour certains indicateurs, les résultats sont inférieurs à la moyenne régionale (taux de mortalité maternelle, taux de mortalité infantile, taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans), et pour d'autres, comme l'incidence du paludisme ou de la tuberculose, ils se dégradent.

Tableau 1. Progrès réalisés au regard des cibles de l'ODD 3

Cible de l'ODD	Djibouti	Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale
D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes	244 pour 100 000 (2019)	179 pour 100 000 (2019)
D'ici à 2030, ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus	45,85 pour 1 000 (2021)	36 pour 1 000 (2021)
D'ici à 2030, ramener la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus	54 pour 1 000 (2021)	45 pour 1 000 (2021)

¹ Analyse commune de pays [Common country analysis] [non publié] (2021)

D'ici à 2030, mettre fin à l'épidémie de sida, à la tuberculose et au paludisme	L'incidence du paludisme est passée de 19 pour 1 000 en 2017 à 70,5 pour 1 000 en 2021.	11,6 pour 1 000 (2021)
	La prévalence du VIH chez les adultes est passée de 1,2 % en 2018 à 0,7 % en 2021. ²	< 0,1 % (2021)
	La prévalence de la tuberculose est passée de 195 pour 100 000 en 2020 à 240 pour 100 000 en 2022.	112 pour 100 000 (2021)
D'ici à 2030, réduire d'un tiers le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être	La probabilité de mourir de l'une des quatre grandes MNT était estimée à 22 % en 2019, un chiffre resté plutôt stable (22,25 % en 2016).	24,5 % (2019)
Faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d'un coût abordable	L'indice de couverture des services en vue de la couverture sanitaire universelle est passé de 45 en 2017 à 44 en 2021. Cependant, l'évolution à long terme est positive avec un indice de couverture des services passé de 33 en 2000 à 44 en 2021.	57 (2021)

Source : *Observatoire mondial de la santé de l'OMS*

L'un des enjeux recensés dans la Vision Djibouti 2035³ est la nécessité de veiller à ce que la croissance économique du pays apporte des bénéfices concrets à toutes les catégories de la population et à ce que les inégalités dans le domaine de la santé soient réduites. À cet égard, la situation de différents groupes marginalisés et vulnérables de Djibouti doit être prise en compte. Situé au cœur d'une région marquée par l'instabilité politique, Djibouti accueille environ 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile (4) ainsi que des « populations flottantes », terme recouvrant notamment les populations déplacées et les migrants, dont le nombre est estimé à 150 000 (5), qui se rendent de l'Éthiopie vers l'Arabie saoudite à travers la région désertique d'Obock. Djibouti est une terre d'accueil pour les réfugiés et est signataire du cadre d'action global pour les réfugiés du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que du Pacte mondial sur les migrations des Nations Unies. Ces dernières années, le pays a également accueilli des réfugiés du Yémen et de la Somalie.

D'après l'analyse commune de pays menée par les Nations Unies en 2022, d'autres populations doivent également être prises en considération, conformément au principe « ne laisser personne de côté », à savoir :

- Les enfants en milieu rural, qui sont particulièrement touchés par des taux élevés de malnutrition : 42,3 % des enfants de moins de cinq ans en milieu rural présentent un retard de croissance (5).
- Les femmes et les filles : Les données relatives à l'activité économique des femmes montrent que la participation de celles-ci au marché du travail est très inférieure à celle des hommes (32 % contre 59 % pour les hommes), tout comme l'accès à l'enseignement formel (38,2 % contre 64,5 % pour les garçons), ce qui constitue un obstacle à leur intégration économique (6). Un accès restreint aux ressources économiques peut entraver l'accès aux services de santé, bien que les données ventilées par sexe ne soient pas disponibles en la matière. En outre, le ratio de mortalité maternelle de Djibouti est élevé (244 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2019), tout comme le taux de mutilations génitales féminines, qui s'élevait à 93,1 % en 2006 (2).
- Les personnes vivant avec un handicap : Il n'existe pas de données actualisées concernant les personnes vivant avec un handicap. L'analyse commune de pays recense des problèmes de discrimination et des obstacles à l'inclusion des personnes handicapées dans les domaines suivants : le système éducatif, l'accès à l'emploi et les processus de prise de décisions qui les concernent.
- Les personnes vivant avec le VIH : Selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) (7), 6 700 personnes environ vivaient avec le VIH à Djibouti en 2019, et moins de 30 % d'entre elles avaient accès à un traitement antirétroviral (TAR).

Le Gouvernement djiboutien encourage les efforts visant à renforcer le système de santé, l'accès à la sécurité sociale et les services de santé. Cependant, dans la Vision Djibouti 2035, les difficultés suivantes ont été recensées pour le secteur de la santé : infrastructures sanitaires peu opérationnelles ; manque d'équipements et d'ambulances ; faible approvisionnement en eau et en

² Données DHIS 2 citées dans le protocole de l'enquête de surveillance bio-comportementale intégrée (IBBS) 2023

³ Vision Djibouti 2035

électricité ; difficultés d'accès des populations rurales aux centres urbains en raison de l'insuffisance des infrastructures de transport. D'après l'analyse commune de pays, l'approvisionnement en médicaments est insuffisant, les stocks des pharmacies communautaires ne sont pas renouvelés régulièrement et il n'y a pas suffisamment de pharmacies privées dans les régions. L'absence de systèmes d'assainissement dans des villes importantes a également des répercussions sur la santé. Le financement public du système de santé est faible : il représentait 4,3 % des dépenses publiques en 2020.

Plusieurs obstacles politiques et institutionnels empêchent la réalisation de la CSU. Tout d'abord, le système de santé est fragmenté, car les services et les budgets de santé parapublics ne relèvent pas de la compétence du Ministère de la santé. Le Ministère du travail contrôle la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), tandis que le Ministère de l'intérieur chapeaute les prestataires de services parapublics qui prennent en charge le personnel de l'armée, de la gendarmerie, de la police et de la garde côtière ainsi que leur famille. Ensuite, le système de santé publique dépendant du Ministère de la santé est très centralisé et le pouvoir de décision au niveau régional est faible. Enfin, il n'existe aucun système de santé communautaire institutionnalisé associé à des établissements de soins de santé primaires.

1.2 Objet de l'évaluation

L'évaluation porte sur la contribution de l'OMS à Djibouti. Le bureau de pays ne dispose actuellement d'aucune stratégie de coopération avec le pays, la dernière en date remontant à la période 2013-2016. L'OMS fait partie de l'équipe de pays des Nations Unies et ses interventions relèvent des domaines « santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement » et « protection des groupes vulnérables » du Plan-cadre de coopération.

Entre 2019 et 2023, l'OMS a axé prioritairement son action sur le renforcement du système de santé, les interventions d'urgence et la promotion de la santé, notamment la riposte à la crise de la COVID-19, et sur le soutien aux systèmes de surveillance et de prévention des infections, ainsi qu'aux systèmes de riposte et de préparation aux infections. Les grandes priorités qui ont guidé les interventions de l'OMS pour la période 2018-2023 sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2. Priorités de l'OMS à Djibouti dans le cadre du treizième PGT 2018-2023

Pilier du treizième PGT	Interventions clés à Djibouti
CSU	- Renforcer le système de santé, notamment les programmes de lutte contre les maladies, en particulier le Programme essentiel de vaccination (PEV) et le programme de lutte contre le paludisme. - Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour la SRMNE ainsi que pour la santé des adolescents, notamment l'introduction de nouveaux vaccins. - Élaborer des stratégies et des plans d'action de soutien psychosocial en matière de MNT et de santé mentale. - Évaluer la charge des maladies tropicales négligées (MTN) et soutenir les interventions de lutte contre la leishmaniose. - Actualiser la liste nationale des médicaments essentiels.
Situations d'urgences sanitaires	- Soutenir l'élaboration d'une stratégie « Une seule santé », notamment pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). - Fournir une assistance technique et renforcer les capacités pour la riposte aux flambées de poliomyélite, en particulier concernant le renforcement de la surveillance et des campagnes. - Développer la prise en charge des cas de complications médicales de la malnutrition aiguë sévère et les systèmes de surveillance intégrée dans le cadre de la riposte à la crise de l'insécurité alimentaire/de la nutrition. - Pandémie de COVID-19 : renforcer la lutte anti-infectieuse ; les laboratoires et outils de diagnostic ; la prise en charge et les traitements ; la vaccination ; la communication sur les risques, la mobilisation communautaire et la gestion des données sanitaires ; la surveillance, les enquêtes sur les flambées épidémiques et la recherche des contacts ; et les services et les systèmes de santé essentiels.
Amélioration de la santé des populations	Soutenir le développement des soins d'urgence, notamment de la traumatologie, dans le cadre de l'élaboration d'une future politique de sécurité routière.

	- Élaborer le premier protocole pour la santé et la sécurité au travail, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail (OIT). - Mener des actions de promotion de la santé, notamment la campagne concernant la ville de Djibouti, et renforcer la Direction de promotion de la santé du Ministère de la santé.
Fonctions d'appui de l'OMS	Réaliser une évaluation complète des besoins en matière de système d'information sanitaire

Source : Mission conjointe pour l'examen des programmes de l'OMS à Djibouti

1.3 Budget

Le budget total alloué au bureau de pays pour la période 2018-2023 s'élevait à 20 471 610 dollars au titre des activités et à 6 743 395 dollars au titre du personnel, soit l'équivalent de huit postes à temps plein. Le tableau 3 ci-dessous présente la répartition du budget par exercice biennal et par catégorie d'interventions. La catégorie « budget de base » regroupe quatre domaines fondamentaux du mandat de l'OMS, à savoir : la CSU, les situations d'urgences sanitaires, l'amélioration de la santé des populations et les fonctions d'appui de l'OMS. Les situations d'urgences regroupent à la fois les urgences liées à la COVID-19 et les urgences non liées à la COVID-19. La catégorie « poliomyélite » comprend les fonds visant à soutenir les stratégies d'éradication de la poliomyélite. Au cours des exercices budgétaires 2020-2021 et 2022-2023, les principaux donateurs étaient les suivants : Alliance Gavi, Allemagne, Italie, Fonds central pour les interventions d'urgence des Nations Unies (CERF), Communauté de l'Afrique de l'Est, Fondation Bill et Melinda Gates, États-Unis d'Amérique, Azerbaïdjan, Rotary International, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et National Philanthropic Trust.

Tableau 3. Informations sur le financement du bureau de pays de l'OMS

Budget programme	2018-2019			2020-2021			2022-2023		
Catégorie	Dépenses prévues	Fonds reçus	Ressources utilisées	Dépenses prévues	Fonds reçus	Ressources utilisées	Dépenses prévues	Fonds reçus	Ressources utilisées
Budget de base	5 022 865	3 982 300	3 948 296	4 622 924	4 049 275	3 656 626	7 253 675	6 907 984	4 939 240
Situations d'urgence	850 533	850 533	821 457	5 297 075	5 140 755	4 344 473	3 500 933	3 413 543	3 223 244
Hors budget programme	337 000	287 000	189 286	180 000	180 000	178 977	150 000	150 000	28 016
Total	6 210 398	5 119 833	4 959 039	10 099 999	9 370 030	8 180 076	10 904 608	10 471 527	8 190 500

Source : Système mondial de gestion (GSM) de l'OMS⁴

1.4 Système de suivi et d'évaluation

Les résultats du bureau de pays concernant les produits du treizième PGT sont rapportés aux 12 résultats mondiaux grâce à un tableau de bord des produits [\[8\]](#).⁵ Le système de suivi axé sur les résultats à Djibouti est ainsi rattaché au cadre de résultats du

⁴Pour l'exercice biennal 2022-2023, les données relatives aux ressources utilisées correspondent à la période allant jusqu'au troisième trimestre 2023. Ces chiffres n'incluent pas le budget de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite.

⁵ Le tableau de bord des produits est une méthode permettant de mesurer les contributions du Secrétariat de l'OMS aux résultats et aux impacts. Les bureaux de pays présentent deux tableaux de bord, l'un sur les domaines techniques et l'autre sur les fonctions d'appui. Le tableau de bord sur les domaines techniques porte sur six dimensions : les biens de santé publique mondiaux, le leadership, la réalisation des résultats, l'appui technique, le genre, l'équité et les droits humains et l'optimisation des ressources. Le tableau de bord sur les fonctions d'appui porte sur six autres dimensions : l'orientation stratégique et le leadership, la réalisation des résultats, la responsabilisation, la prestation de services aux clients, le genre, l'équité et les droits humains et l'optimisation des ressources. Les produits sont évalués dans chacune de ces catégories grâce à une autoévaluation réalisée par le bureau de pays.

treizième PGT de l'OMS (2019-2023) [\[9\]](#) pour atteindre les cibles du triple milliard.⁶ En outre, le bureau de pays présente au bureau régional des rapports sur les indicateurs clés de performance pour chaque produit du treizième PGT considéré comme prioritaire dans le pays. Les indicateurs clés de performance sont notés suivant un système inspiré des feux de circulation, indiquant l'état d'avancement des indicateurs par rapport au niveau de référence de 2019. Chaque indicateur est accompagné d'une description des progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités de l'OMS, ainsi que des résultats, des défis et des prochaines étapes.

1.5 Utilisateurs de l'évaluation

Le présent rapport s'adresse principalement au Bureau de l'OMS à Djibouti et au Ministère djiboutien de la santé. Il s'adresse également à d'autres utilisateurs de l'OMS, parmi lesquels les points focaux et la direction du Bureau régional de la Méditerranée orientale, la direction du Siège de l'OMS et le Conseil exécutif de l'OMS. La deuxième catégorie d'utilisateurs comprend les partenaires d'exécution, les donateurs, d'autres parties prenantes gouvernementales, les membres de l'équipe de pays des Nations Unies à Djibouti et d'autres acteurs travaillant dans le secteur de la santé et du développement à Djibouti.

⁶ Comprend un sous-ensemble de 46 indicateurs de résultats : 39 indicateurs des ODD et sept indicateurs approuvés par les États membres couvrant une série de questions fondamentales liées à la santé.

1.6 But, objectif et portée de l'évaluation

La présente évaluation vise principalement à améliorer la responsabilisation à l'égard des résultats, notamment à cerner les changements stratégiques essentiels et l'orientation à donner au bureau de pays à l'avenir, ainsi qu'à renforcer l'apprentissage institutionnel en vue de garantir une prise de décisions éclairées et de permettre l'élaboration de documents stratégiques tels que le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et la nouvelle stratégie de coopération de l'OMS avec le pays. L'évaluation se veut à la fois sommative et formative. La dimension sommative vise à mieux comprendre les types de résultats et de réalisations, voulus ou non, qui découlent des interventions de l'OMS. La dimension formative de l'évaluation a permis de dégager des enseignements et des priorités qui serviront à éclairer la conception et la mise en œuvre des interventions de l'OMS et à renforcer la collaboration entre les trois niveaux de l'Organisation.



Crédit photo : OMS.

Le Dr Ahmed Al Mandhari, Directeur régional de l'OMS, en visite à Djibouti du 10 au 13 mars 2019.

Les objectifs de l'évaluation étaient les suivants :

- a. évaluer les réalisations au regard des objectifs formulés dans les instruments stratégiques au niveau du pays et les résultats escomptés correspondants définis dans les plans de travail biennaux du bureau de pays ;
- b. évaluer les succès et les difficultés rencontrés par le passé ainsi que les enseignements tirés des travaux de l'OMS ;
- c. définir les changements stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer le positionnement stratégique de l'OMS à l'avenir ;
- d. évaluer les stratégies de communication et de coordination entre les trois niveaux de l'Organisation et avec les parties prenantes dans le pays.

L'évaluation porte sur toutes les interventions humanitaires et de développement entreprises par l'OMS (bureau de pays, bureau régional et Siège) dans l'ensemble du pays, telles que définies dans les instruments stratégiques pertinents [par exemple, le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) et les politiques nationales pertinentes], menées au cours des trois derniers exercices biennaux (2019-2023). L'évaluation ne porte pas sur l'impact de la contribution de l'OMS sur les résultats en matière de santé, mais est axée sur les changements au niveau du système de santé.

2. Méthodologie

2.1 Critères et questions d'évaluation

Conformément aux critères révisés du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (voir les critères du Comité d'aide au développement de l'OCDE à l'adresse <https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf>), l'évaluation a été menée sur la base de cinq questions d'évaluation principales et 11 sous-questions connexes visant à évaluer la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité des interventions de l'OMS à Djibouti (voir l'annexe 5 pour plus d'informations). Les principales questions et sous-questions d'évaluation étaient les suivantes :

1. Pertinence : Dans quelle mesure les interventions et le positionnement de l'OMS sont-ils adaptés au contexte de Djibouti et à l'évolution des besoins et des droits en matière de santé de la population djiboutienne, ainsi qu'aux besoins, politiques et priorités des institutions et des partenaires nationaux et régionaux, et dans quelle mesure le restent-ils si les circonstances changent ?

- 1.1 Dans quelle mesure les objectifs et les interventions de l'OMS répondent-ils aux besoins et aux droits des bénéficiaires djiboutiens, notamment à ceux des populations les plus marginalisées ?
- 1.2 Alors que Djibouti a l'ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire, sur quoi le bureau de l'OMS à Djibouti devrait-il mettre l'accent dans les années à venir ?

2. Cohérence : Dans quelle mesure les interventions et le positionnement de l'OMS sont-ils cohérents et témoignent-ils de synergies et de cohésion les uns avec les autres ainsi qu'avec les interventions menées par d'autres partenaires et institutions à Djibouti ?

- 2.1 Dans quelle mesure les interventions sont-elles en phase avec les politiques et les priorités des institutions et des partenaires nationaux et régionaux, et avec le treizième programme général de travail de l'OMS et d'autres politiques sectorielles ?
- 2.2 Quels ont été les effets de la situation socioéconomique et politique de Djibouti sur le secteur de la santé, et comment cela a-t-il complété ou entravé le rôle de l'OMS, notamment en matière de collaboration avec les parties prenantes ? Quels ajustements, améliorations et réorientations stratégiques doivent être mis en œuvre pour améliorer le positionnement stratégique de l'OMS à l'avenir ?

3. Efficacité : Dans quelle mesure les résultats de l'OMS (notamment les contributions au niveau du système de santé et des résultats en matière de santé) ont-ils été atteints ou sont-ils susceptibles d'être atteints, et quels facteurs ont influencé (ou non) leur réalisation ?

- 3.1 Dans quelle mesure les produits du programme ont-ils été réalisés et ont-ils contribué : a) à la réalisation des résultats escomptés des programmes ; et b) à l'adoption et à la mise en œuvre, par le système national de santé, d'interventions, de programmes et de services visant à réduire les inégalités et l'exclusion liées aux déterminants socioéconomiques et environnementaux de la santé ?
- 3.2 Quels facteurs ont influencé la réalisation ou non des résultats, et dans quelle mesure l'OMS a-t-elle apporté une contribution raisonnable au système de santé ou aux résultats en matière de santé ?
- 3.3 Quelle est la valeur ajoutée des contributions du bureau régional et du Siège de l'OMS à l'obtention de résultats à Djibouti ?

4. Efficience : Dans quelle mesure les interventions de l'OMS ont-elles produit ou sont-elles susceptibles de produire des résultats de manière efficiente et rapide ?

- 4.1 Dans quelle mesure les interventions de l'OMS reflètent-elles une utilisation économique et opérationnelle efficiente des ressources, y compris pour répondre aux besoins de santé nouveaux et émergents qui nécessitent un ajustement ou une nouvelle hiérarchisation des interventions ?
- 4.2 Dans quelle mesure les systèmes de gestion axée sur les résultats sont-ils adéquats pour assurer une affectation efficiente et en temps opportun des ressources et une évaluation adéquate des résultats, y compris lorsque les circonstances évoluent ?

5. Durabilité : Dans quelle mesure l'OMS contribue-t-elle au renforcement des capacités et de l'appropriation nationales nécessaires pour répondre aux besoins et aux priorités sanitaires de Djibouti dans le cadre de l'aide humanitaire et du développement ?

- 5.1 Dans quelle mesure l'OMS contribue-t-elle à la réalisation des objectifs à long terme de Djibouti et à la mise en place d'un système de santé résilient et capable de réagir aux chocs, notamment en renforçant la capacité du pays à répondre aux besoins actuels et futurs en matière de santé ?
- 5.2 Dans quelle mesure les interventions de l'OMS favorisent-elles l'appropriation nationale des efforts de renforcement du système de santé, ainsi que la capacité du pays à obtenir les résultats prévus dans les politiques et stratégies nationales de santé pertinentes ? Existe-t-il des données montrant que les bénéfices perdureront ?

2.2 Cadre méthodologique : approche et méthodes

2.2.1 Approche

L'évaluation a été réalisée selon une approche basée sur la théorie. Au cours de la phase initiale, l'équipe d'évaluation a reconstitué un modèle de théorie du changement, qui a servi de référence pour l'évaluation de la contribution de l'OMS aux résultats escomptés présentés dans la question d'évaluation n° 3 ci-dessus relative aux critères d'efficacité. Ce modèle a été ajusté à la lumière des résultats de l'évaluation, de manière à établir une théorie du changement tournée vers l'avenir, qui pourra être développée plus avant afin d'éclairer la future stratégie de l'OMS à Djibouti. On trouvera à l'annexe 4 davantage d'explications concernant le processus d'élaboration de la théorie du changement révisée et les résultats de celle-ci.

L'assurance qualité externe a été assurée par le Chargé de l'évaluation au niveau régional du Bureau régional de la Méditerranée orientale et par le Bureau de l'évaluation de l'OMS. Le Groupe de référence pour l'évaluation a apporté un deuxième niveau d'assurance qualité externe, qui a permis de s'assurer de la qualité suffisante des produits de l'évaluation (rapport initial, projet de rapport et rapport final) afin que ceux-ci soient les plus utiles possibles au programme et à l'Organisation.

La théorie du changement, comprenant une partie graphique et une partie narrative, est présentée ci-dessous dans l'encadré 1.

Encadré 1. Théorie du changement

La théorie du changement considère que si l'OMS, aux trois niveaux, dispose de ressources humaines et financières suffisantes, tant sur le plan technique que sur le plan des capacités administratives/d'encadrement, et si elle est guidée par des plans et une stratégie adéquats et bien alignés, alors elle a la capacité de s'acquitter de son mandat, notamment de jouer un rôle de chef de file en matière de santé, d'assurer un plaidoyer auprès des partenaires de développement, de fournir une assistance technique, de mobiliser des ressources pour la santé et de surveiller et d'évaluer les tendances en matière de santé.

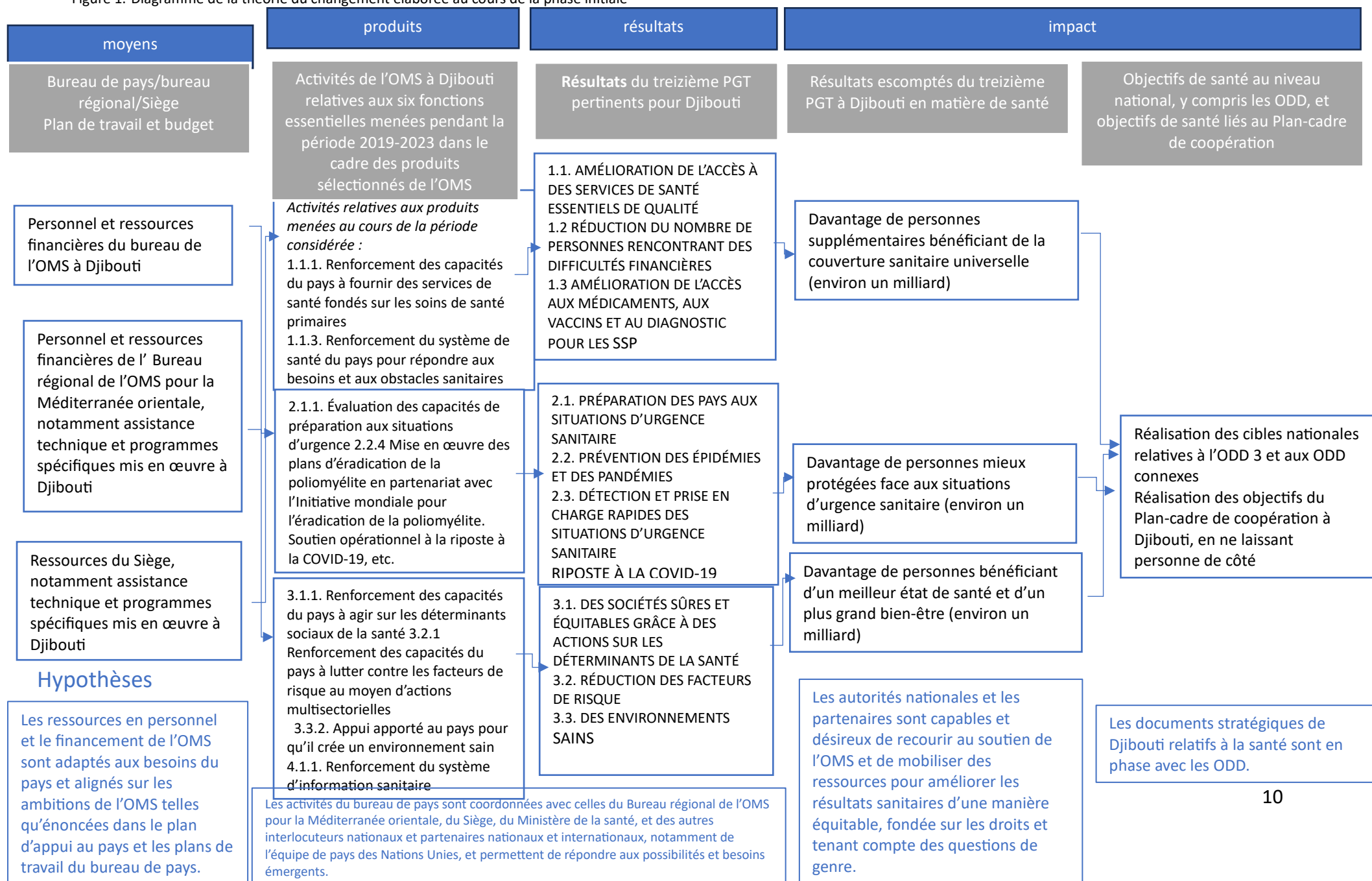
Si l'OMS peut s'acquitter de son mandat, alors elle sera en mesure d'obtenir une série de produits alignés sur les résultats escomptés dans l'immédiat ou au niveau des produits. Ces produits sont obtenus en partenariat avec les interlocuteurs du Ministère de la santé, les organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF et la FAO, ainsi qu'avec d'autres partenaires d'exécution (équipe de pays des Nations Unies, équipes « Une seule santé » et résistance aux antimicrobiens). Ces produits sont notamment les suivants : renforcement du cadre d'orientation général et des capacités institutionnelles du Ministère de la santé au moyen de l'appui à la réalisation d'un examen du secteur de la santé et à l'élaboration du PNDS ; élaboration d'une liste nationale des médicaments essentiels ainsi que de stratégies et programmes sectoriels (santé de la mère et du nouveau-né, nutrition, MTN, santé mentale et soutien psychosocial) ; appui à la préparation et à la riposte aux urgences sanitaires et mise en œuvre directe dans le cadre de la riposte à la COVID-19 ; contribution à la riposte à la poliomyélite ; soutien au renforcement des capacités en matière d'information sanitaire pour la préparation aux catastrophes. L'OMS a également joué un rôle de premier plan dans la coordination des interventions en matière de santé et de nutrition au sein de l'équipe de pays des Nations Unies.

Si l'OMS parvient à obtenir ces produits, alors elle sera en mesure de contribuer à des changements de plus haut niveau, tels que l'amélioration de la CSU, en mettant l'accent sur le renforcement des systèmes de santé, en particulier les soins de santé primaires et les systèmes de santé communautaires qui permettent d'atteindre les personnes les plus vulnérables ; par l'amélioration de la

préparation aux urgences sanitaires grâce à la détection rapide des épidémies et des pandémies et à la riposte à celles-ci ; par l'amélioration de la santé et du bien-être grâce à une action sur les déterminants de la santé ; par la réduction des facteurs de risque des MNT grâce à des ripostes multisectorielles ; et par la mise en œuvre de programmes de promotion de la santé. En outre, les capacités du secteur de la santé seront renforcées grâce à de meilleurs systèmes de surveillance et de gestion des données, à une meilleure gouvernance et à des ressources pour la santé. À travers ces résultats, l'OMS devrait contribuer à améliorer l'égalité des genres, à réduire les inégalités en matière de santé et à résoudre les problèmes concernant les droits humains dans le domaine de la santé.

Ces changements de haut niveau devraient se traduire par des gains en termes d'impact sur la santé qui se manifesteraient par une amélioration des résultats en matière de santé/des indicateurs des ODD et par une plus grande équité en santé, conformément aux objectifs du treizième PGT, aux objectifs nationaux de santé et aux objectifs de développement durable (voir figure 1 ci-dessous).

Figure 1. Diagramme de la théorie du changement élaborée au cours de la phase initiale



2.2.2 Collecte de données

L'évaluation s'est appuyée sur un échantillon de sources d'information provenant de divers groupes de parties prenantes et a suivi une approche méthodologique mixte visant à assurer la triangulation des données pour répondre aux questions d'évaluation.

Examen des documents. Dans le cadre de l'évaluation, plus de 60 documents et articles publiés ont été examinés, à savoir des documents stratégiques et des documents d'orientation de l'OMS, des documents de l'OMS au niveau national, des documents stratégiques et politiques nationaux, des rapports et des analyses établis par différents partenaires à Djibouti, des stratégies et des rapports de l'équipe de pays des Nations Unies ainsi que des articles publiés. Certains documents ont été élaborés par le bureau de pays et le bureau régional aux fins de l'évaluation, et des documents supplémentaires ont été fournis ou cités par les répondants au cours de l'évaluation. On trouvera à l'annexe 3 une liste complète des documents examinés.

Données quantitatives relatives aux indicateurs. Les données sur la santé et les indicateurs au niveau du système de santé ont été extraites de plusieurs bases de données, notamment l'Observatoire mondial de la santé de l'OMS, le portail de données des Nations Unies sur les objectifs de développement durable et AIDSInfo.

Entretiens avec les parties prenantes. L'échantillonnage était dirigé, et reposait sur une analyse des intérêts spécifiques des parties prenantes dans l'évaluation et sur leur participation aux interventions de l'OMS. Au total, 67 répondants ont participé à des entretiens individuels. La plupart des entretiens (86 %) ont eu lieu à Djibouti, les autres entretiens ayant été réalisés à distance avec le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et les organismes partenaires non basés à Djibouti. La majorité des répondants étaient des hommes (42 hommes et 25 femmes). Des entretiens individuels ont été menés auprès des répondants suivants :

- a. Vingt et un répondants de l'OMS aux trois niveaux de l'Organisation, notamment des membres du personnel chargés des domaines de la gestion, du suivi et de l'évaluation des programmes, de l'appui aux pays et de domaines techniques spécifiques tels que la poliomyélite, la vaccination et les soins de santé primaires, autant de secteurs correspondant aux travaux de l'OMS à Djibouti.
- b. Vingt-neuf fonctionnaires, principalement du Ministère de la Santé, mais aussi de la Centrale d'achats de matériels et médicaments essentiels (CAMME), de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de l'Institut national de santé publique de Djibouti (INSPD), ainsi que du Bureau du Secrétaire général et des directions de la santé concernées sous la supervision du Secrétaire général.
- c. Douze donateurs multilatéraux et donateurs actifs à Djibouti appartenant à des organismes des Nations Unies, du Fonds mondial et de l'Alliance Gavi.
- d. Outre les personnes susmentionnées, une personne dirigeant une organisation de la société civile fournissant des services aux enfants diabétiques a accepté de participer à un entretien individuel.
- e. Des prestataires de soins de santé publics, notamment des médecins-chefs (4) dans quatre régions, ont également accepté de participer à des entretiens individuels.

En plus des entretiens avec des informateurs clés, l'équipe d'évaluation a mené trois discussions de groupe :

Une discussion réunissant sept représentants d'organismes des Nations Unies travaillant à Djibouti, qui ont examiné la contribution de l'OMS aux résultats collectifs de l'équipe de pays des Nations Unies.

- a. Une discussion réunissant sept représentants d'organismes des Nations Unies travaillant à Djibouti, qui ont examiné la contribution de l'OMS aux résultats collectifs de l'équipe de pays des Nations Unies.
- b. Un groupe composé de douze agentes de mobilisation dans les zones métropolitaines de Djibouti, qui ont partagé leur expérience de la participation aux activités de proximité sur la survie de la mère et de l'enfant menées par l'OMS et ses partenaires. La discussion de groupe a porté sur le manque de services de santé communautaires institutionnalisés à Djibouti (voir Introduction).
- c. Cinq hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, membres de l'association « *Autres Regards* » de la ville de Djibouti, anciennement soutenue par l'ONUSIDA avant que l'agence ne quitte Djibouti en 2022 et ne transfère ses activités à l'OMS. Les participants ont partagé leur expérience de l'accès aux services de santé en tant que groupe marginalisé.

Mission dans le pays. Au cours d'une visite d'une semaine, en collaboration avec le Siège de l'OMS et les responsables de l'évaluation du Bureau régional, l'équipe d'évaluation (Cheffe d'équipe et Consultant national) a mené des entretiens en présentiel, organisé des groupes de discussion et visité un établissement de santé. Le dernier jour de la visite, une réunion de compte-rendu a

été organisée au bureau du Secrétaire général du Ministère de la santé pour partager les conclusions qui se dessinaient de la mission. Une réunion de compte-rendu a également été organisée avec l'équipe du bureau de pays, suivie d'une séance consacrée à la théorie du changement au cours de laquelle les évaluateurs ont expliqué leur perception de la contribution de l'OMS à Djibouti, en s'appuyant sur la théorie du changement présentée lors de la phase initiale, et quelques premiers ajustements ont été examinés concernant l'approche que le bureau de pays devait adopter à l'avenir. À la suite de la mission dans le pays, le Consultant national a continué de collecter des données dans le pays, en particulier avec d'autres parties prenantes renvoyées vers l'équipe d'évaluation par les répondants. À la suite de la mission dans le pays, le Consultant national a continué de collecter des données dans le pays, en particulier avec d'autres parties prenantes renvoyées vers l'équipe d'évaluation par les répondants.

2.2.3 Analyse des données

Des données secondaires issues de l'examen des documents ont été compilées dans une grille d'évaluation organisée par question d'évaluation. Les ressources relatives aux entretiens ont été analysées par catégorie de parties prenantes, par sexe et par catégorie de questions d'évaluation. Les données issues des entretiens et des groupes de discussion ont été analysées et regroupées en thèmes et sous-thèmes, ce qui a permis de repérer les divergences et les points communs entre les différents groupes de parties prenantes. L'analyse des données quantitatives a permis de dégager les tendances et de comparer ces données aux moyennes régionales. Des données ventilées ont été présentées lorsqu'elles étaient disponibles.

Les conclusions de l'évaluation ont été obtenues après triangulation de toutes les données obtenues pour chacune des questions d'évaluation. Le niveau de preuve a été évalué sur la base de la disponibilité de données quantitatives et qualitatives concordantes provenant de sources fiables et des catégories de répondants concernées. Ces informations sont présentées dans le rapport au titre de la question d'évaluation 3 sur les critères d'efficacité, concernant l'évaluation de la contribution de l'OMS aux résultats obtenus.

Sur la base des conclusions de l'évaluation recoupées, l'équipe a rédigé des réponses aux questions d'évaluation. Ces réponses ont permis de formuler les conclusions et les enseignements tirés de l'évaluation.

Des recommandations ont été émises en vue de futurs ajustements et mesures. Chaque recommandation s'appuie sur les réponses obtenues aux questions d'évaluation et sur les conclusions générales fondées sur les éléments probants présentés dans le rapport.

2.2.4 Validation et établissement de la version définitive du rapport

Avant l'établissement de la version définitive du rapport d'évaluation, plusieurs processus de validation ont été suivis.

- a. Un premier processus de validation a été mené à la fin de la visite sur le terrain, durant lequel les conclusions qui se dessinaient ont été communiquées et examinées avec l'équipe du bureau de pays et les interlocuteurs du Ministère de la santé.
- b. À la suite de l'établissement du projet de rapport d'évaluation, un atelier de validation a été organisé avec le Groupe de référence pour l'évaluation⁷ le 23 novembre 2023. Cet atelier virtuel a réuni des participants des trois niveaux de l'OMS ainsi que des parties prenantes externes, telles que le Ministère de la santé et le Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies, et a permis d'évaluer la validité et l'exactitude des conclusions de l'évaluation ainsi que leur pertinence par rapport au contexte et aux programmes de Djibouti. Les parties prenantes ont été invitées à aider les évaluateurs à déterminer, à formuler et à hiérarchiser les recommandations afin que l'évaluation soit aussi pertinente, utile et facile d'utilisation que possible. Les observations formulées sur le projet de rapport ont ensuite été consignées, y compris les points de vue divergents exprimés au sujet des résultats, afin qu'elles puissent éclairer l'élaboration du rapport final.

⁷ Le Groupe de référence pour l'évaluation a été créé pour garantir la pertinence, l'exactitude et l'utilité de l'évaluation au moyen d'un processus de consultation et de validation. Il est composé de membres du personnel du Bureau régional et du bureau de l'OMS à Djibouti, ainsi que de représentants du Gouvernement djiboutien et du Ministère de la santé, de partenaires d'exécution et d'organismes des Nations Unies à Djibouti. Le Groupe de référence pour l'évaluation est chargé d'examiner les principaux produits de l'évaluation (mandat, rapport initial, projet de rapport et rapport final), ainsi que de valider les conclusions techniques.

- c. Une fois le rapport final établi, la représentante de l'OMS sera chargée de préparer la réponse de la direction. Les recommandations finales et la marche à suivre pour les mettre en œuvre seront examinées lors d'une réunion de haut niveau des parties prenantes, à laquelle participeront des représentants du Gouvernement et d'autres parties prenantes, l'objectif étant que les conclusions soient confirmées et adoptées.

2.3 Genre, équité et droits humains

Tant dans sa démarche que dans son contenu, l'évaluation a adopté une perspective d'égalité des genres et d'équité en santé, et a intégré, dans la mesure du possible, les questions transversales de l'égalité des genres, de l'équité en santé, des droits humains et de l'inclusion du handicap. L'évaluation a respecté les politiques et les orientations du Groupe des Nations Unies pour l'évaluation (GNUE) et de l'OMS relatives au genre, à l'inclusion du handicap, à l'équité et aux droits humains, telles que les orientations du GNUE sur l'intégration des droits humains et de l'égalité des genres dans les évaluations [\(10\)](#), les orientations du GNUE sur l'intégration de l'inclusion du handicap dans les évaluations [\(11\)](#), la politique et la stratégie de l'OMS sur l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits humains 2023-2030, la politique de l'OMS sur le handicap [\(12\)](#) et la *Note d'orientation sur l'intégration de l'équité en santé, de l'égalité des genres, de l'inclusion du handicap et des droits humains dans les évaluations de l'OMS* [\(13\)](#). La prise en compte de ces éléments a été assurée de la manière suivante :

- a. Le cadre d'évaluation comprenait des questions spécifiques sur les populations marginalisées, l'équité en santé et les déterminants de la santé, tels que le genre, le handicap et d'autres facteurs d'exclusion (statut migratoire, zone rurale/urbaine, emplacement géographique).
- b. Les entrevues initiales et le premier examen des documents ont permis d'examiner l'évaluabilité des questions relatives au genre, à l'équité en santé et aux droits humains. Cette analyse préliminaire a permis de montrer un manque de données quantitatives ventilées sur les résultats sanitaires et les déterminants de la santé à Djibouti. Les conclusions concernant le genre, l'équité et les droits humains s'appuyaient principalement sur des données qualitatives recueillies au cours de l'évaluation ainsi que sur des sources secondaires, telles que des rapports d'évaluation établis par d'autres organisations.
- c. Dans le cadre de l'évaluation, l'accent a été mis sur la participation d'un large éventail de parties prenantes à la collecte de données, afin d'obtenir, dans la mesure du possible, différents points de vue sur les domaines d'intervention de l'OMS à Djibouti. Lors de la sélection des parties prenantes à interroger, une attention particulière a été portée au genre, à l'emplacement géographique et aux facteurs d'exclusion. Malgré les efforts déployés pour assurer la participation d'un maximum de femmes, les répondants étaient majoritairement des hommes : 63 % d'hommes et 37 % de femmes. Bien que la plupart des répondants consultés se trouvent dans la ville de Djibouti, des efforts ont été déployés pour s'adresser à des prestataires de santé dans les régions, et quatre médecins-chefs ont été interrogés dans quatre des cinq régions de Djibouti. Un entretien a été mené avec une personne représentant une organisation de la société civile fournissant des services aux enfants diabétiques avec le soutien de l'OMS. L'équipe d'évaluation a également rencontré un groupe d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, comme indiqué précédemment.
- d. L'équipe d'évaluation n'a pas été en mesure de rencontrer des répondants d'autres groupes d'utilisateurs des services de santé et de groupes marginalisés, tels que les femmes et les filles, les migrants et les personnes handicapées. La question des obstacles à l'accès aux soins pour les différentes catégories de population, en particulier pour les « populations flottantes », a été examinée, entre autres, avec les prestataires de santé dans les régions.
- e. Lorsqu'elles étaient disponibles, des données quantitatives et qualitatives sur l'égalité des genres, les inégalités en matière de santé et les obstacles à l'accès aux soins de santé pour les groupes marginalisés ont été analysées, et une attention particulière a été accordée à la manière dont l'OMS avait abordé ces questions aux étapes de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation.

2.4 Limites et stratégies d'atténuation

L'absence de stratégie de coopération avec le pays, définissant les priorités et les résultats escomptés pour l'OMS à Djibouti, a constitué un obstacle à l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité du travail de l'OMS. Pour pallier ce problème, d'autres cadres de résultats ont été utilisés, tels que l'exercice de hiérarchisation des résultats et des produits du treizième PGT et le cadre d'indicateurs clés de performance du bureau régional, qui ont permis d'élaborer une théorie du changement reconstituée pour le programme, sur laquelle a été fondée l'évaluation.

L'absence d'indicateurs de performance, de moyens de vérification et de cibles (y compris de valeurs de référence) concernant les résultats de l'OMS au niveau national a également constitué un obstacle. Si les budgets programmes de l'OMS contiennent des indicateurs de produits et de résultats mondiaux, peu de cibles sont fixées pour Djibouti. L'équipe d'évaluation s'est principalement appuyée sur le système de suivi des indicateurs clés de performance du bureau régional, ainsi que sur les données financières extraites du portail Web du budget programme de l'OMS et du Système mondial de gestion (GSM) pour obtenir des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et les résultats.

L'un des risques recensés dès la phase initiale concernait le fait que les évaluateurs ne seraient peut-être pas en mesure de consulter un éventail suffisamment large de parties prenantes pour obtenir un point de vue nuancé. Il a ainsi été noté que les possibilités d'obtenir des informations de première main auprès des divers groupes vulnérables et exclus pouvaient être limitées, étant donné que les organisations et les réseaux de la société civile n'étaient pas toujours présents pour offrir un canal permettant de mener ces consultations. Les évaluateurs ont tenté d'atténuer ce risque en mettant tout en œuvre pour assurer une large compréhension du processus d'évaluation et l'adhésion de toute une série d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, afin de pouvoir accéder aux organisations existantes grâce à un effet « boule de neige ». Toutefois, cette approche a produit des résultats mitigés, car seul un groupe d'utilisateurs de services a pu être consulté dans le cadre de l'évaluation.

2.5 Considérations d'ordre éthique

Toute la diligence requise a été exercée pour l'intégration efficace de bonnes pratiques éthiques et la prise en compte de considérations éthiques conformément au manuel de l'OMS sur les pratiques d'évaluation [\(14\)](#) et aux lignes directrices en matière d'éthique pour l'évaluation publiées par le GNUE [\(15\)](#). L'évaluation a été réalisée dans le respect des considérations éthiques, notamment la confidentialité et l'anonymat, l'approche consistant à ne pas nuire, l'application de protocoles éthiques appropriés et la prise en compte du genre et des droits humains dans la conduite des entretiens et des discussions de groupe avec les personnes interrogées. Lors des entretiens avec les informateurs clés, l'équipe d'évaluation a veillé à ce que les personnes interrogées se sentent à l'aise pour exprimer leur opinion. Elle a également expliqué aux participants le caractère confidentiel de leurs données et l'utilisation qui en serait faite, et traité les notes d'entretien en toute confidentialité. Au début de chaque entretien, le consentement éclairé verbal de la personne interrogée a été recueilli. Pour les discussions de groupe, les participants ont été sélectionnés par catégories : représentants de l'équipe de pays des Nations Unies, agents de mobilisation et utilisateurs de services appartenant à un groupe marginalisé. Le contexte, l'objectif et le processus de l'évaluation ont été clairement expliqués aux participants au début de chaque discussion, après quoi ils ont été invités à donner leur consentement verbal pour participer à l'entretien. Pour obtenir le consentement éclairé des participants, il leur a été expliqué que leurs contributions seraient anonymes et confidentielles, et qu'ils avaient le droit d'interrompre l'entretien à tout moment. Conformément à la politique du bureau de pays, les participants appartenant aux catégories des agents de mobilisation et des groupes d'utilisateurs ont bénéficié d'un remboursement des frais de transport. Ces personnes ont signé un document confirmant qu'elles avaient bien reçu le remboursement.

3. Résultats de l'évaluation

Pertinence : Dans quelle mesure les interventions et le positionnement de l'OMS sont-ils adaptés au contexte de Djibouti et à l'évolution des besoins et des droits en matière de santé de la population djiboutienne, et dans quelle mesure le restent-ils si les circonstances changent ?

Concernant la pertinence, l'évaluation a permis d'examiner dans quelle mesure les interventions et le positionnement stratégique de l'OMS étaient adaptés au contexte sanitaire de Djibouti, aux indicateurs sanitaires de la population nationale et aux besoins des populations les plus marginalisées. Elle a également porté sur la pertinence des interventions de l'OMS compte tenu de la situation politique et économique du pays, y compris l'ambition de Djibouti d'intégrer la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Cette partie évalue dans quelle mesure les considérations relatives au genre, à l'égalité et aux droits humains sont intégrées aux interventions de l'OMS.

Principales observations

Pertinence : Les objectifs et la conception des interventions de l'OMS permettent de répondre aux priorités de Djibouti en matière de santé ainsi qu'aux besoins sanitaires de la population d'après les indicateurs de résultats du système de santé.

Observation 1 : De manière générale, les interventions de l'OMS sont axées sur les domaines où les besoins sanitaires sont les plus importants, malgré le manque de données sanitaires produites par le pays. L'OMS soutient activement la vaccination systématique, la surveillance des flambées épidémiques de poliomyélite et de rougeole et la riposte à ces flambées, la prévention du paludisme, le renforcement des capacités des services de SRMNE, la riposte à la malnutrition aiguë sévère de l'enfant et la mise en place d'un programme pour la santé mentale. Toutefois, les interventions de l'OMS sont moins nombreuses dans certains domaines prioritaires, tels que la préparation aux situations d'urgence et les facteurs de risque des MNT.

Observation 2 : L'analyse et l'élimination des obstacles à l'accès aux services de santé ne se voient pas accorder une importance suffisante. Le genre, l'inclusion du handicap, l'équité en santé et les droits humains ne sont pas intégrés de manière transversale dans les interventions de l'OMS.

Observation 3 : L'Organisation privilégiant les programmes axés sur les maladies, au détriment d'une approche visant le renforcement du système de santé, elle ne réalise pas le plein potentiel de sa contribution dans le pays.

Observation 4 : À l'avenir, il serait possible de redéfinir le positionnement stratégique de l'OMS à Djibouti, compte tenu de l'ambition affichée par le pays de rejoindre la catégorie des pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale et de jouer un rôle accru au niveau régional.



Crédit photo : OMS/Zeinab Ismai. Livraison de cliniques mobiles financées par l'Italie au Ministère de la santé de Djibouti – mars 2023

3.1 Dans quelle mesure les objectifs et les interventions de l'OMS répondent-ils aux besoins et aux droits des bénéficiaires djiboutiens, notamment à ceux des populations les plus marginalisées ?

Le principal document de planification de l'OMS à Djibouti est un plan biennal élaboré par l'OMS et le Ministère de la santé, également appelé « mission conjointe pour l'examen des programmes » (JPRM ou Joint Government/WHO Programme Review Mission). Les principaux domaines d'intervention de l'OMS décrits dans la JPRM sont présentés dans le tableau 2 figurant dans l'Introduction.

Il est difficile d'évaluer la pertinence des interventions de l'OMS au regard des besoins et des droits de la population djiboutienne en matière de santé, notamment de ceux des populations les plus marginalisées, car l'OMS ne produit pas systématiquement d'analyses de situation comprenant des données ventilées ni d'études permettant d'appréhender la situation des groupes marginalisés. À cela vient s'ajouter l'absence de données sanitaires produites au niveau national.⁸ On constate également un manque de données ventilées et d'études spécifiques permettant d'appréhender la situation des groupes marginalisés.

En raison du recensement de la population en cours, les enquêtes sur la santé de la population ont été interrompues, ce qui explique la lenteur des progrès accomplis dans ce domaine. Afin de pallier l'absence de données administratives et systématiques récentes, l'équipe d'évaluation s'est appuyée sur une analyse des tendances et des chiffres des indicateurs de résultats en

⁸ La dernière enquête démographique et sanitaire menée à Djibouti date de 2013.

matière de santé pour Djibouti, sur la base des données de l'Observatoire mondial de la santé [\(2\)](#), ce qui a permis de recenser les domaines de santé nécessitant une plus grande attention de la part de l'OMS. Le tableau 4 ci-dessous présente une analyse descriptive des tendances des indicateurs de résultats en matière de santé à Djibouti par rapport à d'autres pays de la région (valeurs moyennes). D'après cette analyse, une attention particulière doit être accordée aux domaines suivants, dont les résultats sont inférieurs aux moyennes régionales ou sont en train de se détériorer : la couverture des services de santé (indice de couverture des services en vue de la CSU), la prévention du paludisme [utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)], la couverture vaccinale (DTC3, rougeole, poliomyélite), les capacités du système de santé et les capacités en matière de préparation aux situations d'urgence [indice du Règlement sanitaire international (RSI) comprenant 13 indicateurs] et la santé mentale (indicateur sur les tentatives de suicide). Les résultats obtenus sont inférieurs à la moyenne régionale dans d'autres domaines également, mais tendent à s'améliorer. Il s'agit notamment des domaines de la santé de la mère et du nouveau-né (indicateurs de planification familiale et de soins prénatals), de la couverture du traitement antirétroviral, de certains facteurs de risque des MNT tels que l'utilisation de combustibles ménagers propres et la consommation d'alcool, ainsi que de la mortalité due aux accidents de la route et de la malnutrition sévère de l'enfant (indicateurs relatifs à l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans). Dans certains domaines, les résultats sont supérieurs à la moyenne régionale, bien qu'ils tendent à se détériorer. C'est le cas notamment pour la densité de lits d'hôpitaux, les MNT et les indicateurs relatifs aux facteurs de risque des MNT tels que l'hypertension, le diabète, l'obésité (chez les adultes et les enfants) et la qualité de l'air ambiant. Il convient toutefois de noter que l'enquête STEPwise n'a pas encore été réalisée à Djibouti, de sorte que les données sur la prévalence des facteurs de risque de MNT ne sont que des estimations de tendances. Enfin, dans certains domaines, les résultats sont supérieurs à la moyenne régionale et s'améliorent. C'est par exemple le cas pour la prise en charge des enfants atteints de pneumonie, le traitement de la tuberculose et le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans.

Tableau 4. Évolution des indicateurs de résultats en matière de santé à Djibouti et comparaison avec les valeurs moyennes régionales pour les piliers relatifs aux objectifs du triple milliard (2021)

	La valeur la plus récente est inférieure à la moyenne régionale			La valeur la plus récente est supérieure à la moyenne régionale		
	Indicateur	Valeur du pays	Valeur régionale	Indicateur	Valeur du pays	Valeur régionale
Couverture sanitaire universelle (CSU)						
Tendance à la baisse ou stagnation	Indice de couverture des services en vue de la CSU	Passé de 45 à 44 entre 2017 et 2021. Cependant, l'évolution à long terme est positive avec un indice de couverture des services passé de 33 en 2000 à 44 en 2021.	57 (2021)	Densité de lits d'hôpitaux	La densité de lits d'hôpitaux est passée de 17,5 à 14 pour 10 000 habitants entre 2002 et 2017.	14 (2017)
	Utilisation de MII	La population ayant accès à une MII pour se protéger contre le paludisme (modélisation) est passée de 30,8 % en 2018 à 10,4 % en 2021.	30 % (2021)	Hypertension	La prévalence standardisée selon l'âge de l'hypertension chez les adultes âgés de 30 à 79 ans est passée de 26,8 % en 2015 à 34,2 % en 2019.	37,8 % (2019)
	Couverture vaccinale du DTC3	La proportion de la population couverte par tous les vaccins inclus dans les programmes nationaux (DTC3, MCV2, VPC3) est passée de 85 % en 2019 à 59 % en 2021.	84 % (2022)			
	Indice des principales capacités du RSI	Passé de 41 en 2021 à 40 en 2022	67 (2022)	Diabète	Hyperglycémie à jeun 8,1 % (2014), soit une légère augmentation par rapport à 2010 (8 %)	13,7 % (2014)
Tendance positive	Planification familiale (méthodes modernes)	Le pourcentage de personnes qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale est passé de 47,40 % en 2019 à 48,90 % en 2020.	62,25 % (2022)	Consultation pour pneumonie	Le pourcentage d'enfants présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë ayant eu recours aux soins est passé de 62 % en 2002 à 94,4 % en 2012.	s. o.
	Consultations pour des soins prénatals (quatre consultations au moins)	La proportion de femmes (de 15 à 49 ans) ayant reçu des soins prénatals (quatre consultations au moins) est passée de 7,1 % en 2002 à 25,7 % en 2012.	s. o.	Traitement de la tuberculose	80 %, stable sur la période 2019-2022. Le Fonds mondial a signalé une augmentation du nombre de personnes sous traitement, passé de 1 825 en 2019 à 2 151 en 2022.	58 % (2021)
	Traitement antirétroviral contre le VIH	Le pourcentage d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH qui reçoivent actuellement un traitement antirétroviral est stable (30 %).	55 % (2020)			
Protection face aux situations d'urgence sanitaire						

Tendance à la baisse ou stagnation	Préparation (RSI)	État de préparation (RSI 2010-2017) : passé de 26 en 2014 à 0 en 2017	67 (2017)			
	Rougeole	La couverture vaccinale de la deuxième dose de vaccin antirougeoleux (MCV2) à l'âge recommandé à l'échelle nationale est passée de 81 % en 2019 à 48 % en 2021.	77 % (2021)			
	Poliomyélite	La couverture vaccinale contre la poliomyélite (Pol3) chez les enfants de 1 an est passée de 85 % en 2019 à 59 % en 2021.	83 % (2021)			
Amélioration de la santé des populations						
Tendance à la baisse ou stagnation	Réduction du nombre de tentatives de suicide	Le taux de mortalité par suicide pour 100 000 habitants est passé de 9,3 en 2016 à 9,6 en 2019.	5,8 (2019)	Adultes non obèses	La prévalence standardisée selon l'âge de l'obésité chez les adultes est passée de 12,9 % en 2014 à 13,5 % en 2016.	20,8 % (2016)
				Enfants non obèses	La prévalence de l'obésité chez les enfants et les adolescents est passée de 3,9 % en 2014 à 4,3 % en 2016	8,2 % (2016)
				Qualité de l'air ambiant	Les concentrations moyennes annuelles de particules fines (PM _{2,5}) en milieu urbain (µg/m³) sont passées de 20 en 2014 à 20,7 en 2019.	48 (2019)
Tendance positive	Combustibles ménagers propres	La proportion de la population utilisant principalement des combustibles et des technologies propres est passée de 9 % en 2019 à 10 % en 2021.	74 % (2021)	Enfants ne présentant pas de retard de croissance	La prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est passée de 21,5 % en 2019 à 18,7 % en 2022.	25,1 % (2022)
	Services d'assainissement sûrs	La proportion de la population utilisant des services d'assainissement gérés en toute sécurité est passée de 38,6 % en 2018 à 39,6 % en 2022.	54,9 % (2022)			
	Sécurité routière	Le taux de mortalité lié aux accidents de la route (pour 100 000 habitants) est passé de 27,3 en 2015 à 23,5 en 2019.	17,8 (2019)			
	Réduction de la consommation d'alcool	La consommation totale d'alcool par habitant (personnes de 15 ans et plus) en litres d'alcool pur est passée de 0,65 L en 2015 à 0,4 L en 2019.	0,3 L (2019)			
	Enfants non émaciés	La prévalence de l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans est passée de 13,9 % en 2013 à 10,6 % en 2019.	6,9 % (2013-2022)			

Sauf indication contraire, les données proviennent de l'Observatoire mondial de la santé

(2)

De manière générale, les données disponibles concernant les interventions de l'OMS et les perceptions des répondants indiquent que l'OMS à Djibouti a su faire face aux problèmes de santé majeurs et émergents dans le cadre des piliers relatifs aux objectifs du triple milliard. Dans le cadre du pilier CSU, l'OMS a soutenu des campagnes de vaccination des enfants, la distribution de MII, l'élaboration d'une stratégie nationale décrivant un ensemble de services de SRMNE au niveau des soins primaires, et l'élaboration de stratégies nationales de santé mentale et de lutte contre les MNT. Dans le cadre du pilier Protection face aux situations d'urgence sanitaire, l'OMS a rapidement mobilisé et réorienté des ressources pour faire face aux flambées épidémiques de rougeole et de COVID-19. Dans le cadre du pilier Amélioration de la santé des populations, l'OMS a mis l'accent sur la mise en place de services de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère en complément des activités menées par d'autres organismes [UNICEF, FAO, Programme alimentaire mondial (PAM)] pour s'attaquer au grave problème de la malnutrition de l'enfant. De plus amples informations sur les interventions de l'OMS et leur contribution aux résultats sanitaires sont présentées dans la section correspondant à la question d'évaluation 3 concernant les critères d'efficacité. Les répondants ont souligné que l'OMS avait contribué à améliorer les services de santé à Djibouti et à répondre aux nouveaux besoins en matière de santé. Une personne membre du personnel de l'ONU a fait le commentaire suivant :

« L'OMS joue un rôle essentiel dans la tentative de maintien d'un niveau minimum de qualité des services fournis à la population, car, actuellement, les hôpitaux manquent de personnel, de compétences et de médicaments. L'OMS est très réactive face aux situations d'urgence et aux déplacements de réfugiés. L'OMS a une bonne visibilité auprès du Gouvernement ; elle est proche des centres de santé dans les régions, ce qui aide à mieux comprendre les besoins. »

Toutefois, certains domaines qui semblent très importants au vu des indicateurs sanitaires disponibles n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière dans les interventions de l'OMS. En particulier, les interventions prévues au titre de la composante Préparation du pilier Urgences sanitaires, telles que la réalisation d'une évaluation extérieure conjointe permettant de fournir des recommandations pour l'amélioration de l'état de préparation sanitaire du pays, n'ont pas été mises en œuvre. Djibouti obtient pourtant un mauvais score pour l'indice des principales capacités du Règlement sanitaire international (RSI) : 31 en 2019 contre une moyenne de 67 pour la Région de la Méditerranée orientale [\(2\)](#) [\(16\)](#). De même, la plupart des interventions prévues dans le domaine des facteurs de risque des MNT et de la santé environnementale dans le cadre du pilier Amélioration de la santé des populations n'ont pas été réalisées.

D'après l'analyse des documents biennaux de la JPRM et des données relatives à Djibouti extraites du GSM concernant les dépenses par produit, une grande partie des interventions de l'OMS a porté sur l'octroi d'une assistance technique aux programmes axés sur les maladies. Ces interventions ont consisté notamment à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de protocoles de traitement du paludisme, la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, le guide technique HEARTS pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans les soins de santé primaires, l'élaboration de la stratégie de lutte contre la RAM, la stratégie de santé mentale et de soutien psychosocial, la lutte contre la tuberculose, y compris la tuberculose multirésistante, et la stratégie relative au PEV. Les entretiens avec le personnel de l'OMS et les responsables du Ministère de la santé indiquent également que les efforts consentis par l'OMS en dehors des interventions d'urgence étaient axés sur l'octroi d'une assistance technique spécifique aux programmes.⁹ L'OMS a certes soutenu d'importantes interventions visant à améliorer la couverture des services de santé, mais celles-ci portaient uniquement sur des programmes spécifiques, tels que le PEV, plutôt que de s'inscrire dans le cadre d'une approche visant à renforcer les systèmes de santé pour appuyer les objectifs relatifs à la CSU. Une personne du Ministère de la santé a expliqué que les programmes des partenaires du secteur étaient structurés de manière verticale, de nombreux organismes orientant leurs efforts sur une maladie précise. Cela n'est toutefois pas le cas de l'OMS, qui s'est employée tout particulièrement à renforcer le système de santé. Ainsi, l'OMS a appuyé l'examen du secteur de la santé en organisant un symposium national de la santé. Elle a également fourni des orientations normatives concernant la révision de la liste des médicaments essentiels et a soutenu le renforcement du système de données et de surveillance avec la plateforme DHIS2. Cependant, ces interventions transversales ont été peu nombreuses au cours de la période considérée.

3.1.1 Pertinence des interventions de l'OMS par rapport aux besoins et aux droits des populations les plus marginalisées

⁹ Mise au point par l'Université d'Oslo, DHIS2 est une plateforme Web open-source utilisée le plus souvent comme système d'information sanitaire.

L'étude des documents de programme et des entretiens avec les répondants du bureau de pays révèle que l'intégration d'une analyse de l'égalité des genres et de l'équité en santé dans les interventions et les approches de l'OMS est limitée. L'évaluation n'a pas permis de recenser d'interventions fondées sur des analyses de données ventilées par sexe, handicap ou lieu (zone rurale/urbaine), ni l'utilisation de ces données aux fins de l'élaboration de politiques. L'évaluation n'a pas non plus permis de repérer d'efforts déployés pour analyser et traiter les problèmes spécifiques rencontrés par les filles, les femmes, les garçons, les hommes et les personnes ayant des identités de genre diverses. Les interventions visant à promouvoir l'accès aux services de santé pour les personnes présentant différents types de handicap, soit par l'intermédiaire de programmes spécifiques, soit en intégrant leurs besoins de manière transversale dans les programmes soutenus par l'OMS, ont également été limitées.

Les répondants de l'OMS ont fait valoir que les interventions visant à renforcer la prestation de soins de santé primaires pouvaient aider à combattre les inégalités en matière de santé en améliorant l'accès aux services de santé. C'est pourquoi **les interventions de l'OMS ciblent dans une certaine mesure les obstacles aux soins de santé et les besoins de certains groupes marginalisés**, mais elles doivent encore être renforcées.

L'un des principaux obstacles à l'accès aux soins de santé dans le pays est l'isolement géographique et la faible couverture des services de soins primaires en dehors de la ville de Djibouti. Dans certaines régions reculées, l'éloignement des établissements de santé vient s'ajouter aux difficultés topographiques, ce qui oblige certains membres des services de proximité à se déplacer à dos de chameau pour aller voir les patients. Les répondants du Ministère de la santé ont indiqué que dans la plupart des régions, plusieurs centres de santé n'étaient pas opérationnels en raison du manque de personnel. Jusqu'à présent, les interventions de l'OMS pour étendre la couverture des services de santé se sont concentrées sur la formulation de conseils techniques et l'élaboration de stratégies concernant par exemple la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant et le PEV, ce qui pourrait contribuer à améliorer la couverture géographique de certains programmes.

Les obstacles financiers sont plus importants dans les zones rurales, mais restent globalement moindres que dans le reste de la Région de la Méditerranée orientale. Le pourcentage de la population djiboutienne dont les dépenses domestiques en santé représentaient plus de 10 % des dépenses du ménage s'élevait à 1,47 %, et ce chiffre était plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines (1,65 % et 1,43 % respectivement). Bien que le Gouvernement djiboutien ait adopté une politique d'assurance maladie universelle en 2014, la proportion de la population bénéficiant d'au moins une prestation sociale n'était que de 12,3 % en 2019. **Aucune intervention significative de l'OMS concernant la mise en œuvre de la CSU par la réduction des obstacles financiers aux soins de santé à Djibouti n'a été recensée dans le cadre de l'évaluation.**

Les données de l'Observatoire mondial de la santé de l'OMS montrent que les femmes et les filles sont particulièrement touchées par les rapports élevés de mortalité maternelle, qui s'établissait à 234 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021, soit le rapport le plus élevé de la Région de la Méditerranée orientale. Bien que l'on ne dispose pas de données récentes pour l'ensemble de la population, le taux de mutilations génitales féminines et d'excision (MGF/E) était extrêmement élevé (93,1 %) lors de la dernière collecte de données en 2006. **L'OMS a appuyé le programme national relatif à la SRMNE ; toutefois, l'évaluation ne signale aucune activité particulière de l'OMS sur les MGF/E.** Bien que des données ventilées par sexe soient disponibles, par exemple dans les bulletins hebdomadaires publiés par l'INSPD sur 35 maladies prioritaires, elles ne sont pas analysées en tenant compte du genre. Il est probable que cela limite les capacités de l'OMS à aider les acteurs de la santé dans le recensement et le traitement des causes des disparités entre les genres dans les résultats sanitaires.

Selon les données du HCR [\(4\)](#), environ 35 000 réfugiés et demandeurs d'asile sont enregistrés à Djibouti, dont 68 % sont des femmes et des enfants [\(4\)](#). Le Gouvernement djiboutien indique que plus de 137 000 migrants ont transité par Djibouti en 2021, et que 150 000 personnes faisant partie des populations flottantes séjournent dans le pays pour une période prolongée [\(17\)](#).

Les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants ont accès à des services de santé gratuits au même titre que la population locale grâce à des conventions signées par le Gouvernement djiboutien avec le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cependant, selon plusieurs répondants de l'ONU et un rapport de 2022 sur les migrations sûres, ordonnées et régulières à Djibouti, les migrants restent très vulnérables, en particulier les personnes qui se trouvent en dehors des centres de l'OIM, les enfants non accompagnés et les victimes de la traite [\(17\)](#). **L'OMS s'efforce d'améliorer l'accès des migrants aux soins de santé, notamment en renforçant les capacités des hôpitaux régionaux situés sur les couloirs de migration et accueillant le plus grand nombre de migrants** (voir encadré 1 ci-dessous).

Encadré 1. Accès aux soins de santé pour les populations flottantes et autres groupes vulnérables dans les régions

Les hôpitaux régionaux se situent en première ligne de la prestation de soins aux réfugiés, aux migrants transitant par Djibouti pour rejoindre une autre destination finale et aux populations flottantes. Selon les médecins-chefs interrogés dans le cadre de l'évaluation, les réfugiés et les migrants bénéficient des mêmes droits aux soins de santé que la population locale et sont soignés gratuitement. Les populations transfrontalières d'Ali Sabieh ont accès aux soins gratuitement à l'hôpital régional. À Arta, il y a des réfugiés yéménites et des migrants éthiopiens. À Obock, le Centre médico-hospitalier dessert la population réfugiée vivant dans le camp de Markazi. L'hôpital régional de Tadjourah se trouve sur la voie migratoire vers les pays du golfe Persique et accueille un important flux de migrants. Les hôpitaux régionaux ont recours à des équipes mobiles pour atteindre les populations isolées lorsque des fonds sont disponibles. En collaboration avec le HCR, l'OIM apporte son soutien aux établissements de santé publique qui accueillent un flux important de migrants et aux centres de santé voisins des villages de réfugiés. De nombreux médecins-chefs ont toutefois souligné que la prise en charge des migrants et des populations flottantes constituait une charge pour leurs services et avait un impact financier sur l'hôpital régional.

Les médecins-chefs des quatre hôpitaux régionaux ont déclaré avoir reçu un soutien de l'OMS, au profit des populations locales, des réfugiés et des migrants. Ce soutien a notamment consisté à former les agents de santé au diagnostic de la diarrhée cholériforme aiguë et de la lèpre, à la vaccination, à la détection et à la surveillance de la COVID-19, à appuyer la vaccination systématique, y compris grâce à des équipes mobiles de proximité pour les ménages situés dans un rayon de cinq kilomètres autour des centres de santé, à mettre à disposition des fournitures, une chambre froide pour la vaccination contre la poliomyélite et des agents de mobilisation, et à louer moyens de transport pour les campagnes menées en collaboration avec l'UNICEF à Tadjourah. À Obock, l'OMS a fourni une ambulance au centre de santé. L'OMS avait également soutenu le programme de SRMNE à Obock en fournissant des kits pour les enfants souffrant de malnutrition et des kits pour les soins prénatals. À Ali Sabieh, l'OMS a axé ses efforts sur le programme de vaccination, et aucune autre aide sous forme de fournitures et d'équipements n'a été rapportée. L'OMS ne collabore pas directement avec les hôpitaux régionaux pour la planification et le renforcement des capacités, toutes les interactions étant centralisées par l'intermédiaire du Ministère de la santé. Il a été souligné que cela constituait un frein et ne permettait pas à l'OMS d'apporter un soutien en temps voulu et adapté à la situation particulière de chaque région.

On ne dispose que de peu d'informations sur les populations clés à Djibouti. Les données des organismes des Nations Unies recueillies en 2019 montraient un taux de positivité au test VIH de 9,3 % chez les travailleuses du sexe et de 14 % chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, contre 1,2 % pour la population générale. Aucune donnée n'est disponible sur la prévalence du VIH dans d'autres populations clés, telles que les personnes qui s'injectent des drogues, les personnes transgenres et les prisonniers. L'équipe d'évaluation a rencontré cinq hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qui ont accès aux services de prévention du VIH par l'intermédiaire de l'association « Autres Regards », soutenue par l'ONUSIDA avant que le Programme ne transfère ses activités à l'OMS en 2022. Ceux-ci ont déclaré avoir un accès régulier à l'information, aux préservatifs et aux lubrifiants grâce à un pair éducateur, et être orientés en cas de symptômes d'infections sexuellement transmissibles vers le centre Yonis Toussaint, où ils peuvent recevoir des services gratuits de diagnostic et de traitement. Ils ont toutefois expliqué que beaucoup de leurs pairs refusaient d'accéder aux services de santé par crainte d'être victimes de violence et de discrimination, et ont demandé que les services communautaires d'éducation par les pairs soient étendus pour inclure le dépistage du VIH dans la communauté, plutôt qu'au niveau des centres de santé uniquement. Le transfert de responsabilités exige de l'OMS qu'elle soutienne la poursuite des missions de l'ONUSIDA, notamment en ce qui concerne la promotion du droit à la santé des populations clés et leur accès aux services de prévention et de traitement du VIH.

Au moment de l'évaluation, les interventions de l'OMS relatives aux populations clés étaient limitées.

3.2 Alors que Djibouti a l'ambition de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, sur quoi le bureau de l'OMS à Djibouti devrait-il mettre l'accent dans les années à venir ?

La croissance économique de Djibouti est revenue aux niveaux d'avant la pandémie de COVID-19, ce qui a conduit le pays à demander le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Cela permettra d'accroître les investissements nationaux dans le domaine de la santé, en accordant la priorité à la réduction des inégalités en matière de santé et à l'amélioration de l'accès aux soins, ce que traduit le Plan national de développement (2020-2024) [\(18\)](#), qui appelle à la réalisation de la couverture sanitaire universelle et à l'amélioration des infrastructures de santé pour les soins de santé primaires et les services hospitaliers. D'autres éléments contextuels peuvent être mis à profit par l'OMS pour inscrire les questions liées à la santé et la couverture sanitaire universelle parmi les priorités, notamment la révision et l'élaboration du Plan national de développement, la révision de l'actuel PNDS en vue de l'élaboration du nouveau Plan, et la révision et le développement du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, ces trois documents arrivant à échéance en 2024.

Les efforts de l'OMS pourraient s'avérer plus pertinents si l'Organisation mettait davantage l'accent sur des interventions stratégiques visant à renforcer la couverture sanitaire universelle par l'adoption d'une approche fondée sur les soins de santé primaires. Comme indiqué précédemment, l'OMS s'est déjà repositionnée pour soutenir le renforcement et la couverture des systèmes de santé. À l'avenir, l'OMS pourrait s'attacher à résoudre les problèmes structurels du système de santé de Djibouti de manière globale afin d'augmenter la couverture des services en vue de la CSU. Ces problèmes sont notamment les suivants : La fragmentation du système de santé. Des systèmes parallèles de soins de santé coexistent, tels que les établissements gérés par la CNSS, le secteur privé à but lucratif et les prestataires parapublics (armée, gendarmerie, police et garde-côtes). Ceux-ci ne relèvent pas directement du Ministère de la santé et ne suivent pas ses normes, ses règlements et ses directives.

- a. La fragmentation du système de santé. Des systèmes parallèles de soins de santé coexistent, tels que les établissements gérés par la CNSS, le secteur privé à but lucratif et les prestataires parapublics (armée, gendarmerie, police et garde-côtes). Ceux-ci ne relèvent pas directement du Ministère de la santé et ne suivent pas ses normes, ses règlements et ses directives.
- b. Le processus incomplet de décentralisation du système de santé, prévu par la loi n° 48/AN/99/4ème L portant orientation de la politique de santé, celui-ci n'étant pas mis en œuvre à Djibouti. Il en résulte divers dysfonctionnements dans la gestion des établissements de santé.
- c. L'insuffisance des services fournis par des agents de santé communautaires. Les répondants des organismes des Nations Unies, de l'OMS et du Ministère de la santé ont indiqué que les activités de proximité étaient actuellement menées avec le soutien d'agents de mobilisation, mais que leur fonction était essentiellement axée sur la mise en œuvre de programmes précis, en particulier dans le cadre d'interventions d'urgence, et ne permettait pas d'établir un lien pérenne entre les communautés et les services de santé.

L'OMS pourrait également aider Djibouti à intégrer une perspective régionale de la santé. Compte tenu de la position stratégique occupée par Djibouti, situé à un carrefour économique, politique et migratoire régional important, le bureau de pays est bien placé pour collaborer avec les organismes transfrontaliers sur les questions de la gouvernance de la santé, de la mobilisation des ressources et de la collaboration transfrontalière en matière de santé des migrants. Jusqu'à présent, le bureau de pays n'a pas été mandaté pour collaborer avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) afin de promouvoir ses orientations normatives, de soutenir le renforcement des capacités et de mobiliser des ressources pour la protection sociale. Une personne de l'OMS au niveau régional a estimé que l'Union africaine pouvait également être un interlocuteur important, car celle-ci organisait un sommet annuel des chefs d'État abordant notamment les questions de santé. Les répondants de l'OMS ont estimé que ce rôle devait toutefois être formalisé et que le bureau de pays avait besoin de ressources humaines et d'un soutien supplémentaires de la part du Bureau régional de la Méditerranée orientale et du Bureau régional de l'Afrique.

Cohérence : Dans quelle mesure les interventions et le positionnement de l'OMS sont-ils cohérents et témoignent-ils de synergies avec les interventions menées par d'autres partenaires et institutions à Djibouti ?

Dans cette partie, on examine dans quelle mesure les interventions de l'OMS à Djibouti étaient en phase avec les politiques et les priorités des institutions et des partenaires nationaux et régionaux, et avec le treizième programme général de travail de l'OMS et d'autres politiques sectorielles. On examine ensuite les conséquences de la situation socioéconomique et politique de Djibouti sur le secteur de la santé, sur le rôle de l'OMS et sa collaboration avec d'autres partenaires de la santé, ainsi que sur le positionnement stratégique de l'OMS à Djibouti à l'avenir.

Principales observations

Cohérence : La cohérence interne et externe des interventions de l'OMS à Djibouti est inégale.

Observation 5 : Les résultats et les produits prioritaires de l'OMS, tels qu'ils sont décrits dans la JPRM, sont bien en phase avec le treizième PGT ainsi qu'avec le PNDS et le Plan-cadre de coopération.

Observation 6 : Bien que la JPRM soit un processus de planification bien établi qui suscite une forte adhésion du Ministère de la santé et d'autres acteurs, en l'absence de stratégie valide de coopération avec le pays et de plan biennal d'appui au pays, il est difficile d'assurer la hiérarchisation efficace des activités de soutien de l'OMS dans ses différentes fonctions.

Observation 7 : L'absence de plan opérationnel assorti d'un budget pour la mise en œuvre du PNDS est un facteur qui entrave l'alignement des interventions de l'OMS sur les priorités nationales.

Observation 8 : Au sein de l'équipe de pays des Nations Unies, le Groupe de travail sur les résultats en matière de santé, de nutrition, d'eau et d'assainissement, coprésidé par l'OMS et l'UNICEF, a bien fonctionné, et il existe des exemples de planification conjointe réussie. Il serait toutefois possible d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe de pays des Nations Unies en y incluant des organismes non résidents.

Observation 9 : En dehors du système des Nations Unies, la coordination entre l'OMS et les organismes de financement est inégale et repose sur des discussions bilatérales informelles, car l'instance officielle prévue à cet effet par le Ministère de la santé, à savoir le Groupe des partenaires santé, ne se réunit pas régulièrement.

Observation 10 : L'OMS dispose de plusieurs moyens pour soutenir le rôle de leadership et de coordination du Ministère de la santé. Toutefois, l'OMS mettant l'accent sur l'octroi d'une assistance technique et la mise en œuvre directe, elle n'est pas en mesure de jouer un rôle plus moteur et plus fédérateur, alors qu'il s'agit là de son avantage comparatif par rapport à d'autres organismes. Cela conduit certains partenaires à considérer l'OMS comme un petit organisme donateur, ce qui compromet encore davantage la capacité de l'Organisation à mener à bien la mission stratégique au cœur de son mandat.

3.3 Dans quelle mesure les interventions sont-elles en phase avec les politiques et les priorités des institutions et des partenaires nationaux et régionaux, et avec le treizième programme général de travail de l'OMS et d'autres politiques sectorielles ?

L'analyse de tous les documents et de tous les entretiens avec les répondants a montré qu'au cours de la période couverte par l'évaluation, **la JPRM de l'OMS était parfaitement en phase avec les priorités nationales en matière de santé énoncées dans le PNDS et le Plan-cadre de coopération.** La JPRM est le principal document opérationnel décrivant les résultats attendus de l'OMS à Djibouti et est le résultat d'un processus collaboratif d'établissement des priorités et de planification mené par le Secrétariat de l'OMS et le Ministère de la santé. Les répondants du Ministère de la santé ont estimé que les priorités décrites dans ce document avaient été définies avec leur concours et qu'elles correspondaient pleinement aux domaines prioritaires du pays. Les homologues du Ministère de la santé, l'équipe de pays des Nations Unies et d'autres partenaires du secteur de la santé se sont bien approprié la JPRM et la consultent largement.

Le bureau de l'OMS à Djibouti a défini des priorités permettant d'orienter ses travaux à l'issue d'un exercice de hiérarchisation des résultats tirés du treizième programme général de travail, exercice mené avec le soutien du Bureau régional de la Méditerranée orientale en 2018 et 2022. Cet exercice de hiérarchisation a permis au bureau de pays, en collaboration avec le Ministère de la santé, de définir les résultats attendus tels qu'ils figurent dans la JPRM, et de s'aligner sur le cadre de résultats

mondial de l'OMS. Le tableau 5 ci-dessous illustre l'alignement entre la JPRM de l'OMS, les priorités du pays et le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable.

En ce qui concerne le PNDS, dans le cadre du pilier CSU, les priorités du bureau de pays en matière de renforcement du système de santé (perfectionnement du personnel, financement de la santé et disponibilité des médicaments essentiels) correspondent parfaitement aux objectifs nationaux relatifs à l'offre équitable de soins et à la bonne gouvernance du secteur de la santé. Dans le cadre du pilier Préparation aux situations d'urgence, la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI) ainsi que les interventions en matière de surveillance des maladies infectieuses et des situations d'urgence, et de riposte à celles-ci, sont alignées sur les objectifs du PNDS en matière de renforcement des capacités du personnel. Dans le cadre du pilier Amélioration de la santé des populations, les résultats du bureau de pays concernant les déterminants de la santé, en particulier pour les MNT, sont en phase avec les activités de promotion de la mise en œuvre du plan stratégique de développement économique et social de Djibouti (SCAPE) et avec l'approche du Gouvernement djiboutien en matière de soins de santé primaires. Enfin, la JPRM et le PNDS reconnaissent tous deux l'importance de renforcer la gestion des systèmes d'information sanitaire (DHIS2).

En lien avec le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable [\(19\)](#), la JPRM de l'OMS s'intéresse aux domaines prioritaires relevant de l'effet 3 relatif à la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, à savoir : la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, le programme de vaccination, la COVID-19, le traitement du VIH, de la tuberculose et des maladies à transmission vectorielle et les systèmes de surveillance du plan. Le seul domaine sur lequel l'OMS ne met pas directement l'accent est celui de l'eau et de l'assainissement, qui relève de la responsabilité de l'UNICEF. Bien que la nutrition ne soit pas un thème prioritaire dans le Plan-cadre de coopération, aucun résultat escompté ou indicateur concernant la nutrition n'ayant été défini au titre de l'effet 3, cette question est bien prise en compte dans les interventions présentées chaque année par les organismes concernés [\(20\)](#). Le Plan-cadre de coopération étant très large, il ne définit pas de domaines d'intervention spécifiques dans le domaine de la santé et de la nutrition sur lesquels les différents organismes doivent collaborer. Cependant, de nombreux répondants de l'ONU ont indiqué que le Groupe de travail sur les résultats en matière de santé, de nutrition, d'eau et d'assainissement, coprésidé par l'OMS et l'UNICEF, avait bien fonctionné comme plateforme d'échange d'informations et qu'il avait permis d'aligner les activités figurant dans le mandat de chaque organisme. En outre, les sous-groupes de travail interinstitutions sur les résultats en matière de santé et de nutrition ont élaboré des plans de travail spécifiques pour coordonner les interventions et définir des initiatives conjointes. L'organigramme présenté dans le PNUAD 2018-2022 mentionne également l'existence d'un sous-groupe VIH/sida, mais après le départ de l'ONUSIDA de Djibouti en 2022, il semble que celui-ci n'ait pas été actif.

Tableau 5. Alignement des priorités de l'OMS à Djibouti sur les cadres stratégiques

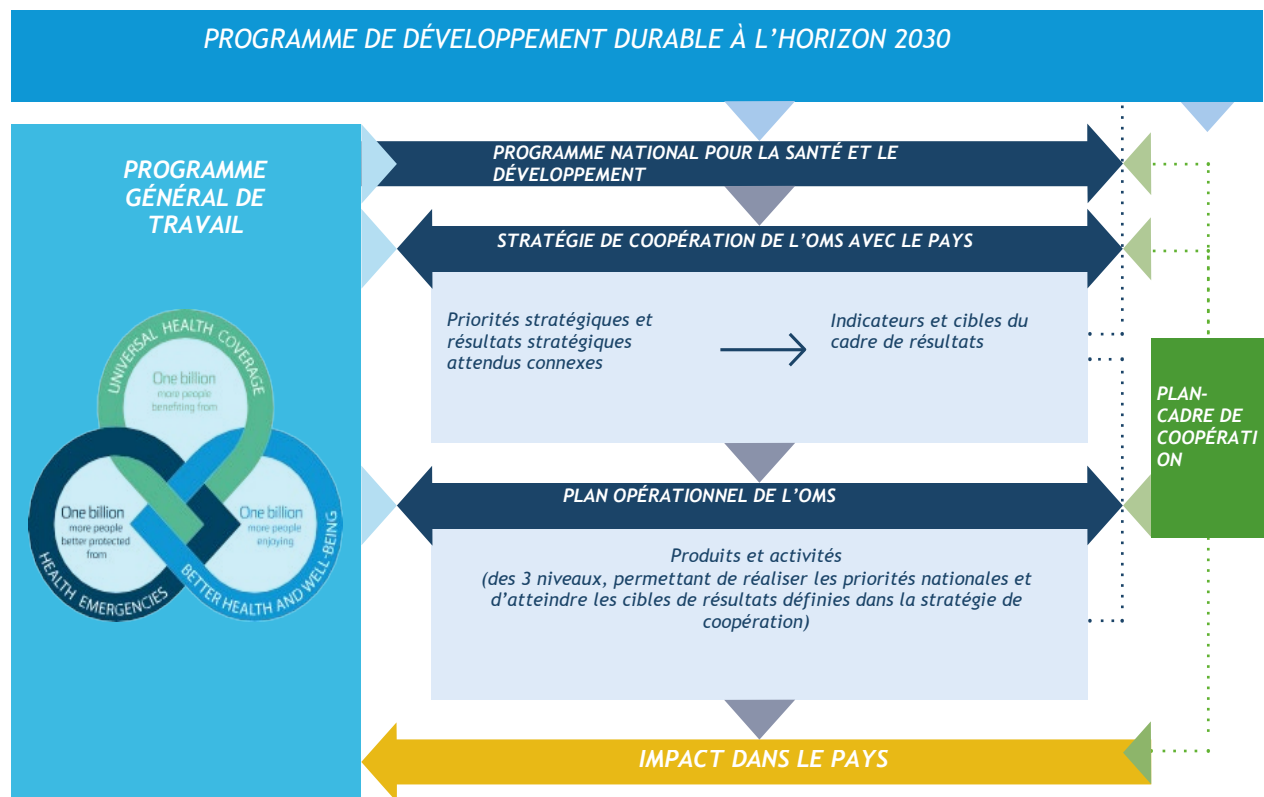
Priorités du bureau de l'OMS à Djibouti (2022-2023)	PNDS	Effet 3 du Plan-cadre de coopération
Résultat 1.1. Amélioration de l'accès à des services de santé essentiels de qualité - Renforcement du cadre de planification opérationnelle du plan national pour le secteur de la santé 2018-2022 - Renforcement de la gestion des ressources humaines pour la santé - Renforcement de l'accès à la santé pour les populations rencontrant des obstacles financiers Résultat 1.3. Amélioration de l'accès aux médicaments, vaccins, produits de diagnostic et dispositifs essentiels pour les soins de santé primaires - Mise à jour de la liste nationale des médicaments et équipements essentiels - Renforcement de la gestion des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires	Prestation équitable de soins de qualité , avec des ressources humaines qualifiées, une plateforme technique adéquate et des médicaments essentiels de qualité disponibles en permanence. Bonne gouvernance de la gestion des services de santé. Renforcement de la gouvernance grâce à une responsabilisation accrue des acteurs vis-à-vis des résultats du PNDS.	Les capacités nationales pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile et pour augmenter la vaccination sont renforcées.
Résultat 1.2. Réduction du nombre de personnes confrontées à des difficultés financières - Renforcement du financement de la santé en faveur de la CSU	Mobilisation de financements adéquats et durables pour la CSU et la protection sociale.	
Résultat 2.1. Préparation du pays aux urgences sanitaires - Renforcement de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international - Élaboration du plan national de préparation et de riposte Résultat 2.2. Prévention de l'émergence de risques infectieux majeurs - Renforcement des capacités nationales de surveillance - Renforcement des capacités nationales de riposte aux épidémies Résultat 2.3. Détection et prise en charge rapides des situations d'urgence sanitaire - Renforcement des capacités nationales de surveillance - Renforcement des capacités nationales de riposte aux épidémies	Prestation équitable de soins de qualité , avec des ressources humaines qualifiées, une plateforme technique adéquate et des médicaments essentiels de qualité disponibles en permanence.	Les capacités des services publics et communautaires sont renforcées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et pour assurer l'accès des populations clés aux soins de prévention et de traitement pour le VIH, la tuberculose et les maladies à transmission vectorielle.
Résultat 3.1. Mesures prises en vue d'agir sur les déterminants de la santé - Élaboration d'un plan stratégique pour la réduction des facteurs de risque des MNT - Mise en œuvre d'un mécanisme national de coordination multisectorielle Résultat 3.3. Prise en compte de la santé dans toutes les politiques et interventions pour des environnements sains Activités de promotion dans le cadre de l'élaboration du SCAPE	Des services de promotion, de prévention et de soins curatifs de qualité, axés sur une approche des soins de santé primaires et adaptés au contexte épidémiologique et socioculturel, sont disponibles de manière équitable sur l'ensemble du territoire.	Accès abordable à des installations sûres d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement.
Résultat 4.1. Renforcement des capacités du pays en matière de données et d'innovation - Renforcement des capacités des agents de santé en matière de données sanitaires - Renforcement des capacités d'utilisation des informations sanitaires	Le système d'information sanitaire est renforcé pour assurer la disponibilité permanente de données de qualité pouvant être utilisées aux niveaux opérationnel et stratégique.	Les capacités de planification, de suivi, de surveillance et d'évaluation dans le secteur de la santé sont renforcées.

- Renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre de la plateforme
DHIS2

*Sources : JPRM de l'OMS, PNDS (2020-2024) et Plan-cadre de coopération (addendum
2022-2024)*

Si la JPRM est utile pour définir la contribution de l'OMS à Djibouti au cadre de résultats mondial, elle n'est pas suffisante pour fournir une orientation stratégique à long terme à l'OMS à Djibouti du fait de l'absence de stratégie de coopération avec le pays depuis 2016 et de plan d'appui au pays permettant de la mettre en œuvre. Un plan d'appui au pays permettrait de décrire la contribution des trois niveaux de l'Organisation sur une base biennale. À l'heure actuelle, le Ministère de la santé formule des demandes d'assistance technique à l'OMS, adressées soit au bureau de pays, soit au bureau régional, qui sont parfois renvoyées au Siège de l'OMS, mais il n'existe pas de plan unique détaillant la contribution du Siège de l'OMS, du bureau régional et du bureau de pays à Djibouti. L'articulation de ces différents éléments est décrite dans le guide de l'OMS sur les stratégies de coopération avec les pays (2023), comme le montre la figure 2. Ce cadre permet de fonder clairement les stratégies de l'OMS pour les pays sur l'analyse des résultats sanitaires, et ainsi de privilégier les interventions dans les domaines où des lacunes ont été constatées. Un plan opérationnel de l'OMS pour la stratégie de coopération avec Djibouti permettrait donc de mobiliser l'ensemble des fonctions de l'OMS (leadership et capacité à fédérer, travail normatif, assistance technique, promotion de politiques de santé fondées sur des données probantes et appui au suivi des tendances en matière de santé) et de définir clairement les contributions du bureau régional et du Siège de l'OMS.

Figure 2. La stratégie de coopération avec le pays, un outil pour mettre en œuvre le treizième PGT et orienter la coopération stratégique de l'OMS



Source : Guide de l'OMS sur les stratégies de coopération avec les pays (2023), OMS.

3.4. Quels ont été les effets de la situation socioéconomique et politique de Djibouti sur le secteur de la santé, et comment cela a-t-il complété ou entravé le rôle de l'OMS, notamment en matière de collaboration avec les parties prenantes ? Quels ajustements, améliorations et réorientations stratégiques doivent être mis en œuvre pour améliorer le positionnement stratégique de l'OMS à l'avenir ?

3.4.1 Facteurs influençant le rôle de l'OMS et la collaboration de l'OMS avec d'autres acteurs de la santé

La coordination des acteurs du secteur de la santé à Djibouti a été freinée par l'absence d'activité du mécanisme officiel de coordination dirigé par le gouvernement, l'absence de diagnostic et de cartographie des partenaires de la santé, notamment en ce qui concerne le financement du système de santé, l'absence de PNDS opérationnel et le manque de coordination et de partage de données entre les partenaires, qui auraient notamment été permis par un leadership plus stable de la part de l'OMS.

Les partenaires du secteur de la santé et les acteurs du Ministère de la santé s'accordent à dire que le Ministère dispose de capacités de coordination insuffisantes et exerce peu de leadership auprès des partenaires de la santé. Du côté des partenaires internationaux du secteur de la santé, il existe de multiples initiatives fondées sur des projets, menées dans le cadre de cycles et de processus parallèles de planification, de budgétisation et d'établissement de rapports, ce qui a parfois entraîné des pertes d'efficacité, des lacunes et des doublons dans les interventions sanitaires.

Le PNDS n'ayant pas été mis en œuvre, les partenaires du secteur de la santé ont eu du mal à harmoniser et à coordonner leurs activités. L'absence de plan opérationnel assorti d'un budget pour la mise en œuvre du PNDS est un problème récurrent depuis au moins 2012. Un atelier organisé par l'OMS en 2012 sur la mise en œuvre du PNDS avait conclu que le PNDS 2008-2012 était trop peu utilisé, que son contenu était trop détaillé et qu'il ne comportait pas de priorités claires, de plan de mise en œuvre opérationnel ou de mécanisme de suivi. Il avait ainsi été recommandé de mettre en place un processus d'examen et de développement simplifié pour le cycle suivant et pour la mise en œuvre, et ces mêmes recommandations ont été formulées à la fin de la période couverte par l'actuel PNDS. Lors des entretiens, une personne du Gouvernement a ainsi affirmé, à propos de l'actuel PNDS, que l'OMS devait appuyer la réforme du Ministère pour que celui-ci dispose d'un cadre annuel de planification et d'un budget clair. L'un des principaux facteurs expliquant que le PNDS ne soit toujours pas mis en œuvre semble être le manque d'investissement du gouvernement dans le secteur de la santé publique, la part des dépenses publiques de santé étant passée de 8,5 % en 2011 à 4,3 % en 2020 [\(2\)](#).

Les partenaires de la santé manquent de visibilité concernant les priorités des pouvoirs publics, ce qui peut donner lieu à des doublons dans l'allocation des ressources, au détriment d'autres priorités qui ne sont pas prises en compte. Les partenaires de la santé peuvent également entrer en concurrence les uns avec les autres lorsque les mandats ne sont pas clairement compris ni définis par les parties prenantes. Ainsi, une personne appartenant à un organisme des Nations Unies à Djibouti a indiqué que, compte tenu de la multiplicité des initiatives publiques et privées des partenaires étrangers investissant dans le secteur de la santé, il était nécessaire de mettre en place un cadre stratégique pour réaliser la couverture sanitaire universelle, cadre stratégique qui n'existe pas actuellement. Faisant écho à ce propos, une personne du Ministère de la santé a noté que l'OMS pouvait aider le Gouvernement à jouer un rôle de chef de file et à coordonner les partenaires du secteur de la santé. Elle a indiqué que l'OMS était le principal acteur dans le domaine de la santé, que les partenaires devaient la suivre, mais que ce n'était pas le cas, et que les différents acteurs semblaient plutôt se faire concurrence. De manière générale, les répondants estimaient que l'OMS était bien placée pour réunir les acteurs du secteur de la santé.

Outre la coordination des ressources, la coordination et le partage des données restent difficiles. Bien que l'équipe de pays des Nations Unies organise des réunions mensuelles au cours desquelles les organismes échangent des données, aucune

coordination entre les partenaires ne permet d'appuyer la surveillance et le suivi efficaces des services de santé. Les répondants du Ministère de la santé ont indiqué que les partenaires avaient tendance à mettre l'accent sur la collecte et la communication de données concernant les maladies sur lesquelles portaient leurs activités. En outre, les partenaires de financement exigent parfois que les indicateurs présentant un intérêt pour eux soient inclus dans le DHIS2, ce qui a pour effet d'alourdir le système de données sur la santé, déjà fragile.

Le Groupe des partenaires santé (GPS) est le principal mécanisme de coordination sanitaire à Djibouti. Il est dirigé par le Ministère de la santé et présidé par le bureau du Premier ministre. Il est censé se réunir tous les six mois. Malgré les efforts du bureau de pays en ce sens, ce mécanisme ne s'est pas réuni ces dernières années. Par conséquent, aucun inventaire recensant l'ensemble des interventions des partenaires n'a été réalisé, et aucun échange d'information formel n'a eu lieu entre ceux-ci et le Ministère de la santé. Une personne d'un organisme donateur a indiqué :

Nous aimerions qu'il y ait davantage de coordination sectorielle et de gestion conjointe de la coordination entre le Ministère et l'OMS. Nous n'avons aucune visibilité sur ce que font les autres. Avec tous les fonds que les donateurs ont investis, on pourrait avoir un véritable impact à Djibouti si l'on mettait en place une coordination sectorielle.

3.4.2 Cohérence des interventions de l'OMS avec les activités des membres de l'équipe de pays des Nations Unies

L'équipe de pays des Nations Unies constitue une plateforme utile, qui permet à l'OMS de tenter de remédier au manque de coordination entre les organismes des Nations Unies dans le secteur de la santé. Le Groupe de travail sur les résultats en matière de santé, de nutrition, d'eau et d'assainissement, coprésidé par l'OMS et l'UNICEF, se réunit tous les mois pour favoriser l'échange d'informations, mais il ne sert pas de catalyseur pour l'élaboration et le financement de projets communs. Les personnes appartenant aux organismes des Nations Unies ont cité plusieurs exemples de collaboration bilatérale fructueuse entre l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies, par exemple des campagnes de vaccination et de prise en charge des cas de malnutrition sévère en collaboration avec l'UNICEF, la prestation de soins de santé maternelle, néonatale et infantile aux migrants en collaboration avec l'OIM, ou l'élaboration d'une approche « Une seule santé » pour les zoonoses en collaboration avec la FAO. Il existe des exemples de collaboration entre l'OMS et des organismes non résidents des Nations Unies dans le domaine de la santé. Ainsi, une collaboration a été mise en place avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les normes relatives à la santé sur le lieu de travail, et des discussions sont en cours avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur le traitement du cancer. L'ONUSIDA a quitté Djibouti en 2022, et il est difficile de savoir si les travaux du Programme pourront se poursuivre à distance par l'intermédiaire de l'OMS. D'une manière générale, l'OMS semble jouer un rôle de relais pour permettre à d'autres organisations de prendre part aux discussions et faciliter leur contribution aux questions de santé.

Dans certains cas, la coordination n'a pas abouti, et des organismes ont réalisé des activités qui relèvent habituellement du mandat de l'OMS. Ainsi, le sous-groupe chargé des questions de nutrition, coprésidé par l'UNICEF et le PAM, et auquel participe l'OMS, a mis en place un mécanisme de planification annuelle conjointe fondé sur les résultats des enquêtes annuelles sur la sécurité alimentaire menées par le PAM et le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire dirigé par la FAO. Cela permet aux organismes de connaître les ressources dont disposent les autres en matière de nutrition et de mettre en commun leurs moyens pour mener à bien certaines activités. Des organismes ont ainsi mis en commun leurs ressources pour compléter le financement du PAM et mener une enquête de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition [\(21\)](#).

3.4.3 Cohérence des interventions de l'OMS avec les activités des autres partenaires de la santé

En dehors de l'équipe de pays des Nations Unies, la coordination entre l'OMS et les acteurs du financement de la santé tels que le Fonds mondial, l'Alliance Gavi, la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD) **est inégale**. Les répondants de l'OMS à Djibouti et des donateurs bilatéraux interrogés ont indiqué qu'en l'absence de plateforme officielle conçue à cet effet, il avait été difficile d'aligner leurs activités, d'élaborer des projets collaboratifs ou de mener un programme commun de plaidoyer. L'OMS a toutefois déjà établi des collaborations bilatérales avec des institutions n'appartenant pas au

système des Nations Unies. Par exemple, l'OMS est présente au sein de l'instance de coordination nationale du Fonds mondial, a aidé le Gouvernement djiboutien à élaborer sa proposition au Fonds mondial et participe également aux efforts visant à réorienter le financement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vers le Ministère de la santé, qui en deviendra le principal bénéficiaire. D'autres donateurs tels que l'Alliance Gavi, l'AFD et la Banque mondiale cherchent de plus en plus à harmoniser leurs procédures et à coordonner leurs financements pour soutenir les objectifs de santé nationaux.

3.4.4 Démarche faisant intervenir l'ensemble des pouvoirs publics et de la société

L'OMS rencontre des difficultés pour favoriser des interventions multisectorielles à Djibouti, en particulier pour collaborer avec les pouvoirs publics en dehors du Ministère de la santé. Il y a toutefois eu quelques exemples de succès. Par exemple, l'OMS collabore avec la FAO et les Ministères de l'agriculture et de l'environnement dans le cadre de l'approche « Une seule santé » sur les zoonoses et la RAM, ainsi qu'avec la municipalité de Djibouti sur la lutte contre les facteurs de risque des MNT. L'OMS peut jouer un rôle crucial dans la promotion du secteur de la santé auprès des pouvoirs publics djiboutiens, ce qui permettrait de renforcer la coordination entre les partenaires, les allocations budgétaires et l'élaboration de politiques multisectorielles. Une personne membre du personnel de l'ONU a fait le commentaire suivant :

La valeur ajoutée de l'OMS réside dans le renforcement du Ministère de la santé. Le partenariat entre l'OMS et le Ministère peut grandement contribuer à renforcer le rôle de celui-ci au sein du Gouvernement. À Djibouti, on met beaucoup l'accent sur le port, les relations économiques avec l'Éthiopie et les bases militaires, mais la santé n'est pas considérée comme une priorité absolue. Le partenariat avec l'OMS permet de donner plus de visibilité à ce secteur.

Avec le soutien du Programme spécial sur les soins de santé primaires au niveau du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux, l'OMS a pu réunir un plus large éventail de parties prenantes dans le domaine de la gouvernance de la santé, de la mobilisation communautaire et de la prestation de services en organisant un symposium national de la santé en 2022. Son objectif était de faire émerger, grâce à un débat démocratique entre les différentes forces vives de la nation, les réformes à entreprendre dans le domaine de la santé pour accélérer la réalisation de la couverture sanitaire universelle à Djibouti à l'horizon 2030. Le symposium a permis de mener une analyse des différentes composantes du système de santé, effectuée par des groupes de travail sur la prestation des services de santé, les médicaments, les ressources humaines, le financement, le leadership et la gouvernance, et les systèmes d'information sanitaire. Les résultats attendus étaient les suivants :¹⁰

Les recommandations issues des États généraux seront regroupées sous la forme d'un plan d'action opérationnel chiffré, qui servira à orienter les travaux et les interventions de tous les acteurs participant à la réforme du système de santé. Sur cette base, une nouvelle politique de santé pourra être élaborée et promulguée. À ce stade, il peut être envisagé d'organiser une réunion des donateurs pour mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des conclusions des États généraux sous la direction du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Un large éventail d'acteurs ont participé au symposium, et des débats ont été organisés à Djibouti ainsi que dans les cinq régions. La démarche était inédite à Djibouti, de nombreux acteurs participant pour la première fois à des discussions sur la gouvernance de la santé. Les discussions se sont déroulées dans les langues locales, avec la participation notamment de dirigeants communautaires et d'acteurs de la société civile. Cette initiative a permis de faire intervenir de nouveaux acteurs dans les discussions et de sensibiliser les responsables du Ministère à la nécessité de recourir à des mécanismes participatifs pour recueillir des informations sur le système de santé. Cependant, l'ouverture d'un débat sur la santé a également suscité des réticences et une certaine résistance de la part des pouvoirs publics. Les résultats de ces travaux n'ont pas été rendus publics ; par conséquent, les recommandations n'ont pas entraîné de changement concret. En outre, l'AFD a mené un examen en parallèle, qui a donné lieu à la mise en place d'un nouvel organigramme du Ministère de la santé, sans que les recommandations du symposium soient mentionnées. Malgré les difficultés rencontrées en matière d'adhésion et de suivi, le symposium a été une importante occasion d'élargir la participation à la réforme du secteur de la santé à différents groupes. D'autres actions ont été réalisées par l'OMS en lien avec la mobilisation de la société civile et des communautés, par exemple les campagnes de vaccination menées dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et du PEV soutenues par le bureau régional. Ces campagnes ont

¹⁰Rapport National du Symposium National de la Santé « vers la couverture sanitaire universelle », Ministère de la santé de la République de Djibouti [non publié] ; 2022

été l'occasion de mener une microplanification mobilisant les communautés et acteurs locaux, ce qui constitue une approche inédite à Djibouti, d'après les répondants de l'OMS.

3.4.5 Ajustements et changements stratégiques nécessaires pour améliorer le positionnement stratégique de l'OMS

Les répondants de l'OMS et des partenaires de la santé ont souligné qu'un nouveau positionnement de l'OMS nécessiterait un changement stratégique dans le type de travail mené jusqu'à présent. Les membres de l'équipe de pays des Nations Unies et d'autres partenaires du secteur de la santé ont convenu que **l'OMS avait largement limité ses activités à l'octroi d'une assistance technique et d'un appui direct à la prestation de services, ce qui n'avait pas permis à l'OMS de tirer pleinement parti de son pouvoir fédérateur, qui représente pourtant son avantage comparatif par rapport à d'autres organismes**. L'OMS a rencontré des difficultés du fait qu'elle a souvent dû fonctionner en « réaction » aux demandes du Ministère de la santé. Ainsi, un organisme de financement a indiqué que l'OMS fournissait à Djibouti un soutien opérationnel concernant, par exemple, l'achat de moustiquaires. Si cela ne fait pas double emploi avec les efforts de cet organisme, celui-ci est obligé de coordonner son action avec un acteur de plus. Ce type d'action de l'OMS à Djibouti a entraîné une certaine confusion quant au rôle de l'Organisation, certains la considérant comme un « petit donateur » ou comparant son travail à celui d'une organisation non gouvernementale. Un autre organisme de financement a estimé que l'OMS agissait comme un donateur, plutôt que comme un leader, et que les financements octroyés par l'OMS étaient faibles.

Ainsi, **l'OMS éprouve parfois des difficultés à jouer un rôle fédérateur, car elle se retrouve en concurrence avec d'autres acteurs**. Une personne membre de l'équipe de pays des Nations Unies a ainsi fait remarquer qu'il existait une certaine tension entre la coordination et la mise en œuvre avec d'autres acteurs, une tension qu'il convient de prendre en charge. Les répondants de l'OMS ont indiqué qu'il était nécessaire de faire évoluer le discours concernant le rôle de l'Organisation, en tirant parti de son pouvoir fédérateur et de la reconnaissance unique dont elle bénéficie parmi les partenaires du secteur de la santé. Une personne du Ministère de la santé a également appelé l'OMS à exercer son mandat dans son intégralité à Djibouti, en jouant un rôle plus stratégique et en s'imposant comme le chef de file des partenaires de la santé : « Nous savons que l'OMS n'est pas un donateur. Elle doit collaborer plus étroitement avec le Ministère, jouer un rôle de coordination et d'expertise technique, mais l'accent doit être mis sur son rôle de catalyseur. L'OMS doit assumer un rôle de chef de file en matière de santé auprès des autres partenaires ».

Efficacité : Dans quelle mesure les résultats de l'OMS ont-ils été atteints ou sont-ils susceptibles d'être atteints, et quels facteurs ont influencé leur réalisation ?

La présente partie examine dans quelle mesure les produits des programmes de l'OMS ont été réalisés. Elle examine ensuite dans quelle mesure ces produits contribuent aux progrès vers la réalisation des résultats au niveau du système de santé et, en particulier, à l'adoption et à la mise en œuvre, par le système national de santé, d'interventions, de programmes et de services visant à réduire les inégalités et l'exclusion liées aux déterminants socioéconomiques et environnementaux de la santé. Elle présente également les principaux facteurs influençant les réalisations de l'OMS. Enfin, cette partie examine la valeur ajoutée des contributions du bureau régional et du Siège de l'OMS à l'obtention de résultats à Djibouti.

Principales observations

Efficacité : L'efficacité des interventions de l'OMS au regard des résultats escomptés a évolué au fil de temps, et une nouvelle dynamique est observée dans l'exercice biennal en cours (2022-2023).

Observation 11 : L'OMS n'a pas toujours été en mesure de mener à bien les interventions prévues. Après une période où les activités ont été limitées, en raison notamment des difficultés de collaboration entre l'OMS et le Ministère de la santé, la pandémie de COVID-19 a donné un nouvel élan aux travaux de l'OMS à Djibouti. Une nouvelle dynamique est observée au cours de l'exercice biennal actuel, de nombreuses interventions et collaborations actives ayant été recensées. Dans l'ensemble, cependant, la mise en œuvre des interventions prévues progresse lentement.

Observation 12 : Les interventions de l'OMS à Djibouti mettent essentiellement l'accent sur les résultats concernant l'amélioration de l'accès à des services de santé essentiels de qualité et, dans une moindre mesure, sur l'amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires dans le cadre du pilier CSU, une attention moindre étant accordée aux questions des difficultés financières et du financement de la santé. Dans le cadre du pilier Urgence sanitaire, les travaux portent principalement sur les composantes Prévention et Détection et riposte, une priorité moindre étant accordée à la composante Préparation. Peu d'interventions sont menées dans le cadre du pilier Amélioration de la santé des populations. Dans le cadre du pilier Une OMS plus efficace et efficiente, l'accent est mis sur le renforcement des capacités du pays en matière de données et de systèmes d'information sanitaires, en particulier sur la mise en œuvre de la plateforme DHIS2.

Observation 13 : L'absence de données réelles récentes sur les résultats nationaux en matière de santé ne permet pas d'analyser entièrement la contribution de l'OMS à la réalisation de ces résultats ; toutefois, il existe des données probantes sur certains indicateurs. Ainsi, dans le cadre de cette évaluation, aucun élément probant n'a été recueilli concernant la contribution de l'OMS à l'amélioration des indicateurs liés à la couverture vaccinale, qui se sont dégradés, ou des indicateurs concernant les MNT et les facteurs de risque connexes, dont certains se sont améliorés. Il existe peu d'éléments probants sur la contribution de l'OMS à l'amélioration des résultats au niveau du système de santé pour ce qui concerne la couverture des traitements contre le paludisme et le VIH. On dispose toutefois des preuves solides de la contribution de l'OMS aux résultats positifs concernant les services de SRMNE, la couverture vaccinale contre la COVID-19, la couverture du traitement de la tuberculose et l'exhaustivité des données de surveillance.

Observation 14 : Afin de relever le défi de la couverture des services de santé dans les zones rurales, l'OMS collabore avec l'UNICEF et l'Alliance Gavi pour soutenir un modèle novateur de prestation de soins de proximité à Djibouti, faisant appel à des agents de mobilisation fournissant un ensemble intégré de services de vaccination, de soins prénatals et de nutrition. Ce modèle permet d'améliorer l'accès aux services de santé dans les zones où il est mis en œuvre, et on pourrait envisager de le reproduire à plus grande échelle.

Observation 15 : La contribution de l'OMS à la lutte contre les inégalités en matière de santé était axée sur la prise en compte des populations flottantes, y compris dans les interventions d'urgence et la riposte aux épidémies, ainsi que sur la participation à des activités de proximité novatrices visant à réduire les inégalités géographiques en matière d'accès aux soins de santé.

Observation 16 : L'assistance technique fournie par le Siège de l'OMS et le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est avérée essentielle pour répondre aux demandes du Ministère de la santé. Toutefois, le fait que le bureau régional ait demandé au bureau de pays de participer à des activités régionales a parfois entravé la mise en œuvre efficace des activités prévues à Djibouti.

Bien que la JPRM soit organisée de manière à correspondre au cadre de résultats du treizième PGT, l'absence de cibles précises et de données de référence relatives aux indicateurs de produits et de résultats pour le pays ne permet pas d'évaluer clairement l'efficacité des interventions de l'OMS. Dans la présente section, nous nous appuyons sur la théorie du changement reconstituée pour évaluer la contribution possible de l'OMS à l'amélioration des résultats en matière de santé à Djibouti. Par conséquent, cette partie est organisée en suivant les diverses trajectoires de la théorie du changement, des interventions de l'OMS aux changements au niveau des produits (par exemple, « élaboration de nouvelles stratégies sanitaires sectorielles », « mise en place de nouvelles directives techniques ») et des résultats obtenus en matière d'évolution du système de santé et d'accès aux services de santé. Aucune analyse de l'impact sur la santé n'a été effectuée dans le cadre de cette évaluation en raison du manque de données disponibles et du champ d'application de cet exercice. Les données secondaires sur les interventions de l'OMS et leur contribution aux résultats provenaient principalement de deux sources : i) le système d'établissement de rapports institutionnels, à savoir le tableau de bord des produits, qui fournit peu de détails sur les interventions et leur efficacité ; et ii) le système de suivi des indicateurs clés de performance du Bureau régional de la Méditerranée orientale, qui fournit une description utile des progrès réalisés concernant les indicateurs établis au niveau régional pour suivre les produits du treizième PGT. Les deux systèmes sont présentés dans l'introduction du présent rapport d'évaluation. Les données sur les résultats sont principalement issues de l'Observatoire mondial de la santé, et le modèle de la théorie du changement a été utilisé pour déterminer la contribution possible de l'OMS à ces données.



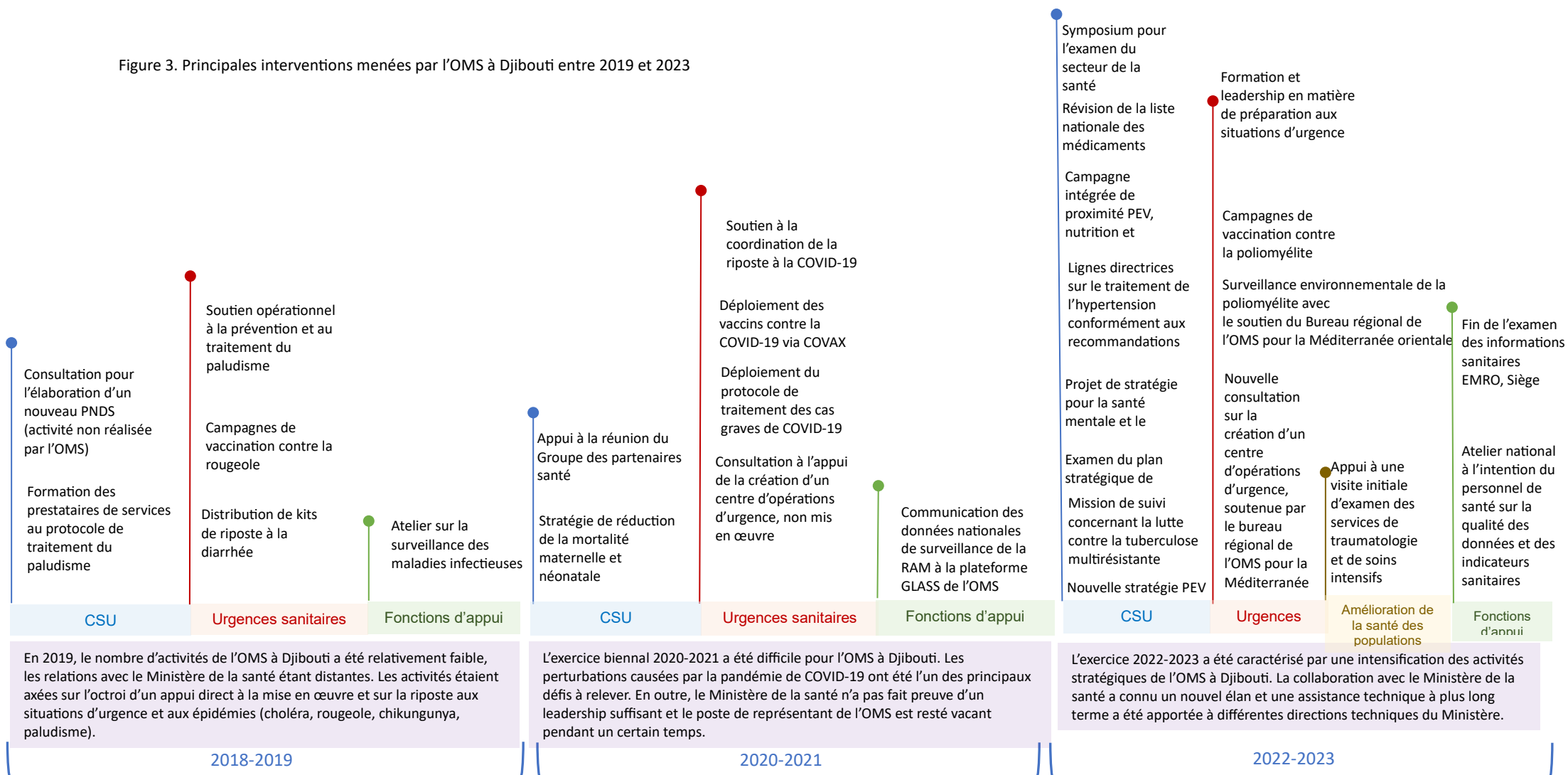
Crédit photo : OMS ; Djibouti/Surveillance environnementale, 1^{er} août 2021

3.5 Dans quelle mesure les produits du programme ont-ils été réalisés et ont-ils contribué : a) à la réalisation des résultats escomptés des programmes ; et b) à l'adoption et à la mise en œuvre, par le système national de santé, d'interventions, de programmes et de services visant à réduire les inégalités et l'exclusion liées aux déterminants socioéconomiques et environnementaux de la santé ?

3.5.1 Mise en œuvre des interventions de l'OMS sur la période 2019-2023

La capacité de l'OMS à mener à bien les interventions planifiées a évolué au fil du temps et en fonction des piliers, comme le montre la figure 3. Les répondants du bureau de pays et les responsables du Ministère de la santé ont décrit avec précision l'évolution des interventions de l'OMS. Au cours des entretiens, ils ont souvent indiqué que la période antérieure à 2016 avait été marquée par une collaboration et un partenariat plus étroits avec l'OMS à Djibouti. Ainsi, une personne du Ministère de la santé a estimé que depuis 2016, il y avait eu beaucoup de bouleversements et que, depuis, la JPRM n'était plus la même. D'après les documents examinés, la contribution de l'OMS à Djibouti au cours de l'exercice biennal 2018-2019 a consisté à mener des activités à petite échelle, souvent sous la forme d'un soutien direct à la mise en œuvre d'interventions dans le cadre de flambées épidémiques et de situations d'urgence. Au cours de la période biennale 2020-2021, l'OMS a également rencontré des difficultés dans la conduite des activités prévues, en raison notamment de la priorité accordée à la riposte à la COVID-19. Toutefois, les partenaires du Ministère de la santé et de l'équipe de pays des Nations Unies ont unanimement salué cette riposte. **Au cours de l'exercice biennal 2022-2023, on constate une mobilisation renouvelée de l'OMS dans des domaines thématiques clés, en particulier dans le cadre du pilier CSU** concernant l'amélioration de la mise en œuvre du PEV, les efforts visant l'éradication de la poliomyélite, la formulation d'orientations normatives et techniques sur le VIH, le paludisme et la tuberculose, l'appui à la mise en œuvre de la stratégie relative à la SRMNE, et l'appui soutenu à l'élaboration des programmes de santé mentale et de lutte contre les MNT du Ministère de la santé. L'OMS soutient également activement le renforcement du système de surveillance, en particulier la mise en œuvre de la plateforme DHIS2.

Figure 3. Principales interventions menées par l'OMS à Djibouti entre 2019 et 2023



Source : Mission conjointe pour l'examen des programmes de l'OMS à Djibouti

3.5.2 Résultats au niveau des produits pour la période 2019-2023

La contribution de l'OMS aux produits du treizième PGT est différente en fonction des piliers. La plupart des efforts ont été déployés dans le pilier CSU et ont porté sur l'élaboration de plusieurs nouvelles stratégies nationales et sur le renforcement des capacités techniques à différents niveaux de personnel du système de santé. **Les efforts menés dans le cadre du pilier Urgences sanitaires ont donné de bons résultats**, en particulier en ce qui concerne la détection de la poliomyélite, les flambées épidémiques de maladies transmissibles et la riposte à la COVID-19. **Dans le cadre du pilier Amélioration de la santé des populations, les efforts visant à agir sur les déterminants de la santé se sont révélés plus limités.** Une place importante a été accordée à la rationalisation des systèmes nationaux de surveillance et d'information sanitaire.

Pilier CSU

Outre l'élaboration de stratégies axées sur les soins de santé primaires et sur un ensemble complet de services essentiels (produit 1.1.1), l'OMS a largement mis l'accent sur le renforcement du système de santé pour l'obtention de résultats concernant la couverture de services spécifiques à certaines affections ou maladies (produit 1.1.2), en particulier les services de lutte contre les MNT, de santé mentale et de soutien psychosocial, ainsi que de prise en charge du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme. Les réalisations ont porté notamment sur l'élaboration de programmes sur les MNT et la santé mentale, grâce à la formulation d'orientations normatives et à l'octroi d'un appui technique à l'adaptation et à la mise en œuvre du guide technique HEARTS et du guide d'intervention du Programme d'action Comblant les lacunes en santé mentale (mhGAP), ainsi que sur la conception de plans stratégiques nationaux concernant les MNT, la santé mentale et le soutien psychosocial et sur la formation du personnel de santé correspondant. En complément des travaux du Fonds mondial et en collaboration avec l'UNICEF et l'OIM, l'OMS a également soutenu l'élaboration d'une nouvelle stratégie de lutte contre le VIH, l'hépatite et les infections sexuellement transmissibles (IST) pour la période 2023-2027, l'examen à mi-parcours du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose, le renforcement des capacités des prestataires de soins concernant les nouvelles recommandations en matière de traitement et la capacité de diagnostic des laboratoires. De même, l'OMS a apporté son soutien à l'examen du plan stratégique national de lutte contre le paludisme en 2022, à la réalisation d'une étude sur l'efficacité thérapeutique des médicaments antipaludiques ainsi qu'au diagnostic et au traitement du paludisme chez les migrants, le but étant de faire en sorte que le nombre de cas de paludisme continue de baisser. L'OMS a également recommandé aux pouvoirs publics de mettre en œuvre des recommandations à fort impact pour réduire l'incidence de la maladie.

En ce qui concerne la réforme du financement du système de santé (produit 1.2.1) et l'amélioration de l'analyse des informations sur la protection financière et les dépenses de santé (produit 1.2.2), les progrès ont été limités. La stratégie de financement de la santé en faveur de la couverture sanitaire universelle, que l'OMS a encouragée, n'a pas encore été élaborée, et aucun soutien n'a été apporté à l'établissement des comptes nationaux de la santé depuis 2016.

En ce qui concerne la mise à disposition d'orientations et de normes faisant autorité sur la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits de santé, des médicaments et des produits de diagnostic essentiels figurant sur des listes (produit 1.3.1), l'OMS a révisé la liste nationale des médicaments essentiels et a continué de collaborer avec le Ministère de la santé pour étendre ces travaux aux équipements de diagnostic et de traitement essentiels. Bien que cela ne figure pas dans la JPRM, qui ne décrit que les activités menées avec le Ministère, l'OMS a également apporté une assistance technique à la Centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels (CAMME), chargée du stockage et de la distribution des fournitures médicales et des médicaments dans le pays, afin d'améliorer la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Les hôpitaux régionaux sont constamment à court de médicaments essentiels et la CAMME envisage désormais d'établir des stocks régionaux pour faciliter la distribution au niveau local.

Pilier Urgences sanitaires

En ce qui concerne les produits liés à la préparation aux situations d'urgence (2.1.1 et 2.1.2), plusieurs activités prévues n'ont pas encore été menées, comme la réalisation d'une évaluation extérieure conjointe permettant de prévenir et repérer les situations d'urgence et d'y faire face, ou la cartographie des risques et des vulnérabilités. L'OMS s'est toutefois employée à contribuer aux produits liés à la prévention, notamment à la mise en œuvre de plans d'éradication de la poliomyélite dans le cadre de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP) (produit 2.2.4). L'OMS a apporté son soutien à la surveillance du virus de la poliomyélite dans l'environnement et aux enquêtes en la matière en créant deux sites de surveillance sentinelle, à Arhiba et dans la station d'épuration de Douda, ce qui a permis de repérer la circulation d'un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale.

La composante Détection et riposte, en particulier le produit lié à la riposte aux urgences sanitaires (produit 2.3.2), a été au centre des travaux de l'OMS au cours de la période considérée. L'OMS a aidé le pays à détecter et à combattre plusieurs flambées épidémiques, notamment de diarrhée aqueuse cholériforme, de chikungunya, de rougeole, de paludisme et de COVID-19. L'OMS a non seulement apporté un soutien direct à la mise en œuvre et acheminé des fournitures, mais elle a aussi renforcé les capacités du pays à détecter les situations d'urgence et à y répondre de manière efficace. L'OMS a également joué un rôle de premier plan dans tous les aspects de la riposte à la COVID-19 à Djibouti : soutien à la coordination de la riposte ; services de conseil concernant la communication sur les risques et la mobilisation communautaire ; formation et appui opérationnel aux épidémiologistes de terrain ainsi qu'à leurs superviseurs ; mise à disposition de protocoles et de modes opératoires normalisés pour les voyages et les points d'entrée ; distribution de réactifs destinés aux tests de diagnostic ; acquisition d'unités d'isolement et d'autres équipements hospitaliers ; diffusion des protocoles thérapeutiques nationaux relatifs à la COVID-19 ; distribution de matériel destiné aux services de santé essentiels ayant souffert de la pandémie de COVID-19, en particulier la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) et les services de lutte contre les MNT et le paludisme ; et soutien aux campagnes de vaccination grâce à l'acheminement de vaccins par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX. L'OMS a également participé à la lutte contre le paludisme en fournissant une assistance technique spécifique, notamment en réalisant une étude sur l'efficacité thérapeutique de médicaments antipaludiques, en formant des épidémiologistes de terrain et en contribuant à des opérations directes d'approvisionnement en médicaments antipaludiques et en fournitures essentielles.

Pilier Amélioration de la santé des populations

En ce qui concerne le renforcement de la capacité du pays à agir sur les déterminants sociaux de la santé (produit 3.2.1), l'OMS prévoyait de soutenir le développement des soins d'urgence et de traumatologie en général, et la prise en charge des victimes d'accidents de voiture en particulier. Toutefois, les progrès ont été limités dans ce domaine. En ce qui concerne la lutte contre les facteurs de risque au moyen d'actions multisectorielles (produit 3.3.1), les travaux prévus comprenaient la mise en œuvre de l'enquête STEPwise sur les MNT, qui a été reportée en attendant que le recensement national soit achevé.

Pilier Fonctions d'appui pour une OMS plus efficace et efficiente

L'OMS a œuvré au renforcement des capacités du pays en matière de données et d'innovation, en mettant l'accent sur l'amélioration des données, des analyses et des systèmes d'information sanitaire pour étayer les politiques et produire un impact (produit 4.1.1). À Djibouti, deux systèmes de surveillance coexistent : l'un, géré par l'INSPD, axé sur les maladies à déclaration obligatoire et les maladies tropicales négligées, qui effectue un suivi hebdomadaire de 35 maladies dans le cadre d'un système d'alerte précoce ; l'autre, la plateforme DHIS2, gérée par la Direction de l'information sanitaire (DIS). L'OMS fournit un appui à la validation et au rapprochement des données entre les deux systèmes en assurant la migration des données de suivi hebdomadaires vers la plateforme DHIS2, conformément aux directives normatives régionales. L'OMS s'emploie également à renforcer la mise en œuvre de la plateforme DHIS2. En 2022, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé un atelier régional de renforcement des capacités, auquel ont participé trois membres du personnel du Ministère de la santé. L'OMS

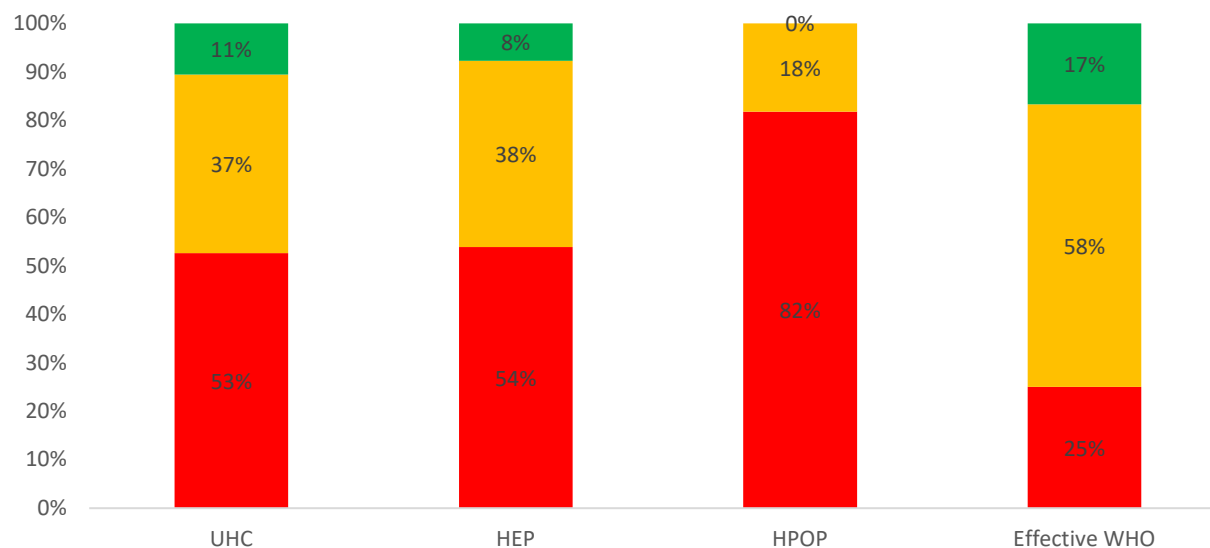
a également poursuivi les efforts entrepris par le Fonds mondial pour former le personnel à communiquer des données au niveau des hôpitaux régionaux, en veillant à ce que celles-ci puissent être analysées pour éclairer la prise de décision en matière de gestion de la santé et améliorer la détection rapide des épidémies. Plusieurs enquêtes sur la santé, comme l'enquête démographique et sanitaire et l'enquête SARA d'évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services, ont également été retardées en raison du recensement national de la population, qui a mobilisé toute l'attention des effectifs limités.

3.5.3 Réalisation des produits escomptés

Les rapports de pays présentés chaque année au bureau régional montrent dans quelle mesure l'OMS contribue à la réalisation des produits du treizième PGT au moyen d'indicateurs clés de performance au niveau régional. Le bureau de pays sélectionne les indicateurs clés de performance qui correspondent le mieux à ses priorités dans une liste d'indicateurs régionaux. Une note est attribuée à chaque indicateur selon un système inspiré des feux de circulation, les trois couleurs correspondant à des seuils prédéfinis au niveau régional : « vert » signifie que la cible de l'indicateur a été atteinte, « jaune » indique un seuil moyen et « rouge » signifie que la cible de l'indicateur n'a pas été atteinte ou qu'elle ne l'a été que de façon limitée. Par exemple, pour l'indicateur « Pourcentage de centres de santé ayant mis en œuvre l'ensemble de services essentiels de la CSU », la cible à atteindre pour obtenir le score « vert » était la suivante : au moins 40 % des centres de santé ont mis en œuvre l'ensemble de services essentiels de la CSU dans le pays. On trouvera davantage de précisions sur ces indicateurs à l'annexe 6.

La figure 4 montre que, **dans les trois piliers (CSU, Urgences sanitaires et Amélioration de la santé des populations), la plupart des indicateurs obtiennent la note « rouge » et la note « vert » a été attribuée à une minorité d'indicateurs. Ces données confirment que l'OMS n'est pas en mesure de mettre en œuvre des interventions lui permettant de contribuer efficacement à la réalisation de certains produits au cours de la période considérée.** La contribution de l'OMS aux produits du treizième PGT à Djibouti est différente en fonction des piliers. Parmi les piliers relatifs aux objectifs du triple milliard, le pilier CSU est celui où les progrès ont été les plus importants, puisque c'est celui dans lequel on constate la plus faible proportion de notes « rouge » (53 %), une proportion moyenne de résultats « jaune » (37 %) et la plus forte proportion de résultats « vert » (11 %). Le pilier Urgences sanitaires présente des résultats similaires, mais des scores légèrement inférieurs, avec 54 % de résultats « rouge », 38 % de « jaune » et 8 % de « vert ». En revanche, les interventions du pilier Amélioration de la santé des populations ont peu progressé au cours de la période considérée, 82 % des indicateurs étant classés « rouge », 18 % de « jaune » et 0 % de « vert ». Dans le quatrième pilier stratégique, Une OMS plus efficace et efficiente, qui concerne les fonctions d'appui de l'OMS, les résultats obtenus sont meilleurs que dans les piliers programmatiques, avec 25 % de résultats « rouge », 58 % de « jaune » et 17 % de « vert ».

Figure 4. Performances par objectif stratégique, selon les scores des indicateurs clés de performance, pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale, de 2019 à 2022



Source : Rapports sur les indicateurs clés de performance du Bureau régional de la Méditerranée orientale 2020-2022 (la couleur, rouge, jaune ou verte, indique dans quelle mesure la cible de l'indicateur a été atteinte).

3.6. Quels facteurs ont influencé la réalisation ou non des résultats, et dans quelle mesure l'OMS a-t-elle apporté une contribution raisonnable au système de santé ou aux résultats en matière de santé ?

À l'aide du modèle de la théorie du changement reconstituée (voir annexe 4), il a été possible d'établir les contributions de l'OMS aux évolutions observées au niveau des résultats. L'annexe 7 résume les données disponibles sur la contribution de l'OMS aux résultats du système de santé.¹¹ Le niveau de preuve a été évalué sur la base de différents éléments, tels que l'intensité et l'ampleur des interventions de l'OMS, la présence d'autres facteurs explicatifs, l'évolution des indicateurs du système de santé et le regard porté par les informateurs sur le rôle de l'OMS dans les changements documentés. Ainsi, si un indicateur affichait une évolution positive au cours de la période, mais que l'OMS n'a pas mené d'intervention majeure dans ce domaine, le niveau de preuve a été jugé faible (c'est le cas, par exemple, des résultats concernant les MNT). À l'inverse, si des améliorations dans les services de santé ont été constatées à la suite d'interventions massives de l'OMS et que les répondants externes ont souligné des liens de cause à effet entre les deux, le niveau de preuve a été considéré comme élevé. C'est le cas notamment pour le traitement de la tuberculose et la disponibilité des services de santé maternelle et néonatale. Bien que l'OMS soit intervenue tout au long de la période considérée, une grande partie des activités prévues ont été menées pendant l'exercice biennal en cours (voir figure 4 ci-dessus). **Dans de nombreux domaines, la contribution aux résultats est encore récente, et les efforts ont généralement été entrepris après que les données les plus récentes ont été recueillies.** Il se peut donc que les indicateurs disponibles ne rendent pas compte de la contribution de l'OMS au moment de l'évaluation.

Les efforts soutenus déployés par l'OMS au cours des deux derniers exercices biennaux ont probablement contribué à améliorer les résultats au niveau du système de santé dans les domaines de la SRMNE, du traitement de la tuberculose, de la riposte à la COVID-19 et de la disponibilité des données sanitaires. En ce qui concerne la SRMNE, l'OMS apporte un soutien

¹¹ Sauf indication contraire, les données présentées à l'annexe 7 sont extraites de l'Observatoire mondial de la santé (2).

important sous forme d'orientations normatives, d'assistance technique, de formation et d'approvisionnement en fournitures pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Les répondants du Ministère de la santé et des partenaires de la santé ont souligné que ce soutien avait contribué de manière décisive à élargir l'offre de services de santé maternelle et néonatale dans les régions. Grâce à l'amélioration de la disponibilité des services de SRMNE, les efforts de l'OMS ont probablement contribué à faire passer de 47 % à 49 % la proportion de femmes (de 15 à 49 ans) dont les besoins en matière de planification familiale ont été satisfaits par des méthodes modernes entre 2019 et 2020. Aucune donnée récente sur le recours aux soins prénatals n'est disponible dans la base de données de l'Observatoire mondial de la santé. Si elle reste élevée, la mortalité maternelle affiche une tendance à la baisse, puisqu'elle est passée de 257 à 234 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2018 et 2020.

En ce qui concerne le traitement de la tuberculose, l'OMS a soutenu l'élaboration d'une stratégie de dépistage, évalué les lacunes des laboratoires en matière de diagnostic de la tuberculose multirésistante et renforcé les capacités des systèmes d'information et de gestion des médicaments. Ces efforts ont probablement joué un rôle important dans l'obtention de bons résultats en matière de couverture du traitement de la tuberculose à Djibouti. Si la tuberculose demeure un problème majeur dans le pays, son incidence étant passée de 212 à 240 pour 100 000 habitants entre 2019 et 2022, Djibouti obtient des résultats supérieurs à la moyenne régionale en ce qui concerne la disponibilité des traitements antituberculeux. En 2021, la Région de la Méditerranée orientale affichait un taux de couverture moyen de 58 %, contre environ 80 % à Djibouti, et ce taux est resté stable sur la période 2019-2022.

L'OMS a largement contribué à la riposte à la COVID-19 à Djibouti. Les vaccins contre la COVID-19 ont été déployés avec succès par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX, une coalition dirigée par l'OMS, l'Alliance Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, avec le soutien de l'UNICEF. En 2023, 41 % de la population avait reçu au moins une première dose du vaccin à Djibouti, contre 52 % dans la région. En outre, l'OMS a probablement contribué à limiter le nombre de décès en appuyant le déploiement d'un protocole de traitement standardisé pour les cas graves. Selon le tableau de bord de l'OMS sur la COVID-19, Djibouti a notifié 15 690 cas et 189 décès liés à cette maladie.

Enfin, l'OMS a soutenu la mise en œuvre de la plateforme DHIS2, en s'appuyant sur le travail d'autres partenaires concernant la formation du personnel chargé de recueillir des données dans les établissements de santé et en fournissant une assistance technique à la Direction de l'information sanitaire du Ministère de la santé. Cela a probablement contribué à améliorer l'exhaustivité des données de surveillance. Bien que le taux de disponibilité des données primaires pour l'indice de couverture des services en vue de la CSU reste faible (41 % en 2019, contre une valeur médiane de 65 % dans la Région de la Méditerranée orientale), l'exhaustivité des données DHIS2 est passée de 60 % en 2022 à 80 % en 2023.

En ce qui concerne le PEV, la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, bien que les efforts accrus de l'OMS pendant l'exercice biennal en cours soient prometteurs, aucune contribution significative aux indicateurs de résultats du système de santé n'a été constatée. Pendant l'exercice biennal en cours, l'OMS apporte un appui direct aux campagnes de vaccination et au PEV, en collaboration avec l'UNICEF, et aide activement le pays à détecter les flambées épidémiques de rougeole et à y faire face. Grâce aux travaux de préparation à la poliomyélite menés par l'OMS en collaboration avec le Ministère de la santé, Djibouti a pu détecter rapidement la circulation du virus de la poliomyélite dans l'environnement, intervenir et déclarer une urgence sanitaire de type 2. Djibouti a été le deuxième pays de la région, après l'Égypte, à répondre à une épidémie de poliomyélite à l'aide du nouveau vaccin (noPV2). Malgré les efforts déployés dans le cadre des campagnes de vaccination et des actions de prévention, de détection des épidémies et de riposte à celles-ci, les résultats au niveau du système de santé restent insatisfaisants, d'après les données disponibles jusqu'en 2021. La couverture vaccinale du DTC3 est passée de 85 % à 59 % au cours de la période 2019-2021, et la couverture de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole est passée de 81 % à 48 % entre 2019 et 2021, un niveau bien en deçà de la moyenne régionale de 77 % en 2021. De même, la couverture vaccinale systématique contre la poliomyélite chez les enfants d'un an est restée très faible et est passée de 85 % à 59 % entre 2019 et 2021, contre 83 % en 2021 dans la Région de la Méditerranée orientale. Les répondants des partenaires de santé qui

soutiennent les programmes de vaccination à Djibouti ont estimé que, en raison de la faiblesse structurelle du système de santé publique et des services de santé communautaires, l'impact des investissements sur la couverture vaccinale restait limité.

En ce qui concerne aussi bien l'indice de couverture des services en vue de la CSU que l'indice RSI, les interventions de l'OMS ont été limitées, n'ont pas entraîné d'effet notable, et les résultats au niveau du système de santé restent insuffisants. L'OMS a mené peu d'interventions sur le renforcement de la CSU par une approche des soins de santé primaires, et ces interventions n'ont pas donné de résultats tangibles. Il s'agissait notamment d'apporter un soutien à l'élaboration de l'actuel PNDS et à l'organisation du symposium national sur la santé. Ces deux activités ont eu une incidence limitée sur les ressources et les plans opérationnels. En collaboration avec le Ministère de la santé, l'OMS a entrepris un projet ambitieux visant à élaborer une carte sanitaire de Djibouti, qui servira de base au renforcement du système de santé. Cependant, aujourd'hui encore, des freins à l'amélioration de la couverture des services subsistent, et la contribution de l'OMS à ces problèmes structurels n'a pas permis d'améliorer la couverture globale des services. L'indice de couverture des services en vue de la CSU à Djibouti est passé de 45 en 2020 à 44 en 2021, contre 57 dans l'ensemble de la Région de la Méditerranée orientale en 2021.

L'OMS n'a pas non plus mené d'interventions majeures sur la préparation aux situations d'urgence à Djibouti. L'indice RSI, qui est une moyenne des scores obtenus pour 13 capacités principales, rend compte de la dimension Préparation. Les résultats de Djibouti pour cet indicateur sont faibles et en baisse, puisqu'il est passé de 37 en 2018 à 31 en 2020. Ce chiffre est l'un des plus faibles enregistrés, et il est nettement inférieur à la moyenne mondiale, qui se situe à 65.

3.6.1 Facteurs influençant l'efficacité de l'OMS

Confirmant les données présentées ci-dessus, plusieurs répondants du Ministère de la santé ont fait remarquer que la plupart des activités prévues dans la JPRM n'avaient pas été mises en œuvre. Plusieurs facteurs externes peuvent y avoir contribué. Tout d'abord, la collaboration entre le Ministère de la santé et l'OMS à Djibouti a parfois été difficile. La représentante de l'OMS et le Ministre de la santé actuel ont toutefois établi des relations solides, et de nombreuses activités ont été menées pendant l'exercice biennal en cours. L'amélioration du partage des données a également permis à l'OMS d'apporter un soutien plus efficace. Ensuite, le Ministère affiche un taux de rotation élevé du personnel, ce qui a entravé les efforts de renforcement des capacités de l'OMS. De plus, ces dernières années, Djibouti a connu plusieurs situations d'urgence et épidémies, notamment des épidémies de COVID-19, de chikungunya, de diarrhée aqueuse aiguë, de paludisme et de rougeole, ainsi que des inondations, qui ont obligé l'OMS à réaffecter rapidement des ressources pour soutenir la riposte à ces urgences. Enfin, l'absence de planification opérationnelle au Ministère n'a pas permis à l'OMS de fournir un appui efficace. Bien que l'Organisation et ses interlocuteurs du Ministère aient tenté de combler cette lacune grâce à la JPRM, l'absence d'activités prévues et mises en œuvre par le Ministère a limité la capacité de l'OMS à concrétiser ses plans de travail.

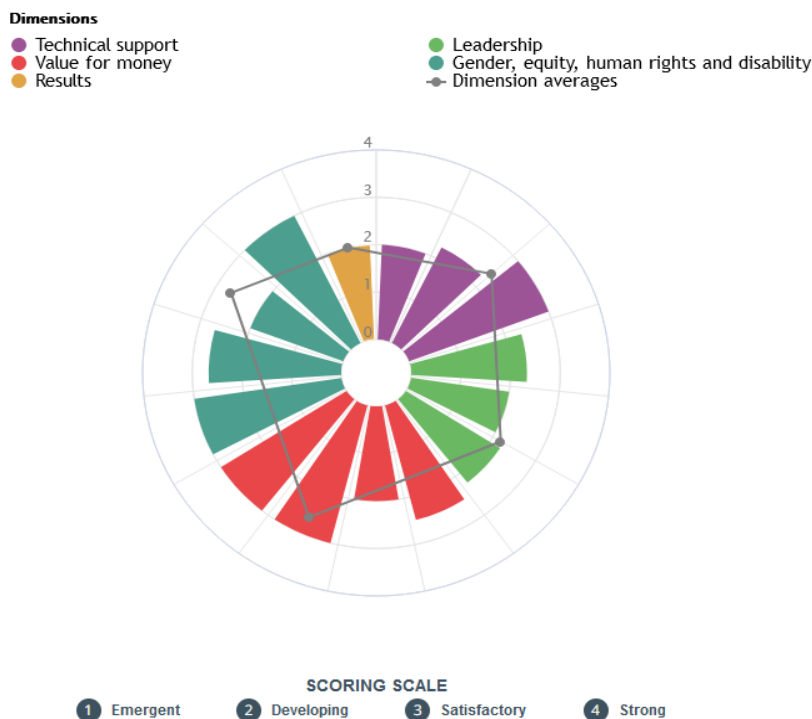
3.6.2 Dans quelle mesure les interventions de l'OMS contribuent-elles à la lutte contre les inégalités et l'exclusion liées aux déterminants socioéconomiques et environnementaux de la santé ?

Les données recueillies dans le cadre de l'évaluation indiquent que **les interventions de l'OMS ne sont pas axées sur la lutte contre les inégalités et l'exclusion, alors qu'une note élevée a été attribuée à la dimension genre, équité, droits humains et handicap dans le tableau de bord technique des produits, qui fait partie du système de suivi de l'Organisation.** Parmi les six dimensions, la note autoattribuée à la dimension genre, équité, droits humains et handicap est la plus élevée (2,67 sur 4) (22)¹² (voir figure 5 ci-dessous). Cette dimension reçoit souvent la note la plus élevée (4 sur 4) dans les rapports individuels sur les produits. Aucune explication n'étant donnée quant aux notes attribuées dans les rapports sur les produits, il est difficile d'interpréter ce résultat. Cependant, comme indiqué dans la section correspondant à la première question d'évaluation portant sur la pertinence, l'OMS à Djibouti n'a que très peu analysé les inégalités en santé et les inégalités de genre en matière de santé.

¹² On trouvera plus de précisions sur les dimensions du tableau de bord des produits dans l'introduction du présent rapport.

Peu d'interventions ciblent des groupes marginalisés, tels que les populations clés. Par conséquent, les données disponibles ne corroborent pas l'idée selon laquelle le score de cette dimension se situerait entre 2 (« en cours de développement ») et 3 (« satisfaisant ») sur 4.

Figure 5. Tableau de bord technique des produits pour Djibouti en 2020



Source : Rapport de résultats, budget programme 2020-2021

Bien que l'intégration du genre, de l'équité, des droits humains et du handicap fasse l'objet d'une attention limitée, certaines interventions de l'OMS contribuent à améliorer l'équité en santé, car elles permettent d'améliorer la couverture des services pour les populations flottantes et les communautés isolées vivant en dehors de la ville de Djibouti. Ainsi, l'OMS a indiqué que les activités entreprises pour mobiliser les communautés en faveur de la vaccination contre la COVID-19 avaient contribué efficacement à réduire l'écart de couverture entre la ville de Djibouti et les régions. Une personne de l'OMS a expliqué :

Nous nous sommes efforcés de mobiliser les communautés pour la planification de la riposte à la COVID-19 et des campagnes de vaccination. Au début, les activités étaient concentrées dans la ville de Djibouti, nous avons donc choisi d'intensifier la campagne dans les régions, où la couverture vaccinale était de 1 % à 10 %. Nous avons réuni les communautés dans les cinq régions pour les mobiliser au sujet de la vaccination : les préfectures, les élus locaux, les imams, les associations de femmes et les dirigeants communautaires. Nous les avons invités à participer à des dialogues communautaires, à des activités de mobilisation et à des exercices de microplanification en collaboration avec les établissements de santé. Ainsi, après trois mois de campagne, la région affichant le moins bon résultat est passée à une couverture vaccinale de 15 %, et la région de Tadjourah est actuellement en train de rattraper le niveau de la ville de Djibouti.

L'OMS a également contribué à une initiative visant à étendre la prestation de services de santé communautaires grâce à un programme intégré de proximité pour la vaccination, la nutrition et les soins prénatals en collaboration avec l'Alliance Gavi, l'UNICEF et le Ministère de la santé. L'encadré 3 présente en détail cette intervention, qui a constitué une innovation à Djibouti.

Encadré 3. Activités intégrées pour la survie maternelle et infantile (vaccination, soins nutritionnels et soins prénatals)

Mené par le Ministère de la santé en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et l'Alliance Gavi, le PEV a permis de mettre en œuvre une stratégie intégrée d'accélération de la vaccination dans la ville de Djibouti. Il s'agissait notamment de proposer des services de vaccination et de nutrition ainsi que des consultations prénatales. La phase pilote de ce projet a débuté en juin 2023 dans cinq centres de santé publique et a duré deux semaines, puis le projet a été étendu à 15 autres centres de santé. Au total, 208 agents de santé, étudiants en soins infirmiers et agents de mobilisation ont été formés à ces services. Les agents de mobilisation étaient chargés de sensibiliser les dirigeants communautaires, d'organiser des visites en porte-à-porte et d'orienter vers des centres de santé les enfants qui n'étaient pas à jour dans le calendrier de vaccination, les enfants souffrant de malnutrition et les femmes enceintes. Pour les familles vivant loin d'un centre de santé, les services étaient fournis par l'intermédiaire d'un site de proximité.

À la fin de l'intervention, 14 923 enfants avaient été vaccinés (soit 55 % du nombre attendu dans la zone desservie), 662 premières visites pour des soins prénatals ont été effectuées (soit 44 % du nombre attendu) et 1 514 enfants souffrant de malnutrition ont été repérés grâce au dépistage (soit 8,5 % du nombre attendu). Une personne ayant participé à ce projet a estimé que, dans le contexte de la COVID-19, cet ensemble d'interventions avait permis à la population de faire de nouveau confiance au système de santé.

Les répondants de l'OMS et du Ministère de la santé ont indiqué que plusieurs difficultés devaient être prises en compte pour transposer à plus grande échelle cette intervention fructueuse, notamment : les coûts élevés liés à la mobilisation d'un grand nombre d'agents ; le fait que les activités s'appuient sur des mesures incitatives ; la nécessité de confier la responsabilité de la gestion des agents de mobilisation aux médecins-chefs des régions, et non à la Direction centrale de promotion de la santé ; l'absence de plan clair visant à institutionnaliser la fonction d'agent de santé communautaire et l'absence de système d'orientation entre les services de santé communautaires et les établissements de santé.

3.7 Quelle est la valeur ajoutée des contributions du bureau régional et du Siège de l'OMS à l'obtention de résultats à Djibouti ?

Les effectifs du bureau de pays étant limités, le soutien apporté par le bureau régional est déterminant pour répondre aux demandes d'assistance technique émanant du Ministère de la santé. Ce soutien prend la forme de missions techniques menées par le personnel du bureau régional, et visant à fournir une documentation technique, à recruter et à financer des consultants internationaux et nationaux, et à mobiliser des fonds pour soutenir les activités, en particulier dans les situations d'urgence. **Les points focaux techniques du bureau régional fournissent aussi régulièrement des services de mentorat et de supervision en ligne au personnel du bureau de pays.** Ces services sont les suivants :

- Communication de modes opératoires normalisés, de directives relatives à la vaccination contre la COVID-19 et de matériel de formation pour la campagne de vaccination contre la COVID-19 ; encadrement du bureau de pays concernant son rôle de coordination et du Ministère de la santé sur ses activités de riposte, dans le cadre de réunions hebdomadaires ; adaptation des modes opératoires normalisés et mise en place d'un comité stratégique au niveau du Premier Ministre. Le bureau régional a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la planification opérationnelle et

de la microplanification, notamment au niveau local, selon un calendrier semestriel. Le bureau régional a également mobilisé des fonds supplémentaires de l'Alliance Gavi pour soutenir l'intégration d'autres services de soins de santé primaires dans le cadre des campagnes de vaccination contre la COVID-19.

- Élaboration de la première stratégie pour la santé maternelle et néonatale de Djibouti.
- Octroi d'un appui technique à la composante Maladies non transmissibles du symposium national de la santé et d'un appui au bureau de pays pour l'adaptation de l'ensemble d'interventions essentielles de l'OMS pour lutter contre les maladies non transmissibles et du guide technique « HEARTS ».
- Élaboration d'un projet de stratégie nationale sur la santé mentale, contribution à l'adaptation de mhGAP au contexte de Djibouti et octroi d'un appui au Ministère de la santé pour l'élaboration d'un plan de formation des agents de santé sur la santé mentale et le soutien psychosocial (en collaboration avec le Siège de l'OMS).
- S'agissant de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, le bureau régional a apporté son soutien à Djibouti en organisant des missions dans le pays sur la surveillance environnementale et la vaccination de la population avec le nouveau vaccin (noPV2) après la détection du virus de la poliomyélite dans l'environnement. Le bureau régional a également mobilisé des fonds pour enquêter sur les cas suspects, assurer une supervision sur le terrain et organiser des visites des points focaux nationaux dans les établissements de santé.
- Le bureau régional a apporté un appui à la mise en œuvre de la plateforme DHIS2 à Djibouti au moyen d'une évaluation et de quatre missions menées par des consultants internationaux en 2023, dont deux du bureau régional, a fourni un soutien continu et permis un renforcement des capacités en vue du déploiement de la plateforme DHIS2, et a organisé un atelier sur le suivi des indicateurs de référence, auquel ont participé trois membres du Ministère de la santé de Djibouti.
- Mobilisation de fonds pour la lutte contre la rougeole par l'intermédiaire de l'alliance mondiale contre la rougeole.

Cependant, certaines demandes de participation à des événements internationaux formulées par le bureau régional ne sont pas en phase avec les priorités locales ou n'ont pas été intégrées aux plans de travail, ce qui peut amener le personnel du bureau de pays et du Ministère à négliger certaines des activités planifiées. Ainsi, le bureau régional a organisé plusieurs ateliers, manifestations et conférences auxquels ont été conviés des membres du personnel du bureau de pays ou des parties prenantes du Ministère de la santé. Parmi les exemples, on peut citer un atelier annuel organisé à Doubaï en 2019 sur la couverture en vue de la CSU, une demande visant à ce que la représentante de l'OMS accompagne le Ministre de la santé lors d'une visite au Bureau régional de la Méditerranée orientale la même année, et le soutien à la participation du personnel du Ministère de la santé à une séance de formation sur les indicateurs de suivi DHIS2 à Lomé en 2022. La contribution de ces activités aux priorités de l'OMS à Djibouti se révèle limitée, selon les répondants du Ministère de la santé et du bureau de pays.

Lorsque le Siège de l'OMS apporte son soutien, celui-ci s'avère pertinent et en phase avec les priorités du pays. Il est particulièrement bénéfique lorsque les compétences du bureau régional ne sont pas suffisantes. L'appui technique du Siège est obtenu sur demande lorsque les capacités du bureau régional ne sont pas suffisantes. Le Programme spécial sur les soins de santé primaires (PHC) a apporté un appui technique en vue de l'organisation du symposium et de la préparation de la carte sanitaire nationale. Une étude sur l'efficacité thérapeutique du traitement contre le paludisme a également été menée régulièrement avec le soutien du Siège de l'OMS et du bureau régional. Les interventions d'urgence ont également bénéficié des fonds mobilisés par le Siège de l'OMS.

Efficiency. Dans quelle mesure les interventions de l'OMS ont-elles produit ou sont-elles susceptibles de produire des résultats de manière efficiente et rapide ?

La présente partie évalue dans quelle mesure les interventions de l'OMS permettent une utilisation économique et opérationnelle efficiente des ressources, y compris pour répondre aux besoins de santé nouveaux et émergents. Elle examine également dans quelle mesure les systèmes de gestion axée sur les résultats constituent des outils adéquats pour assurer une affectation efficiente et en temps opportun des ressources opérationnelles, ainsi qu'une évaluation adéquate des résultats.

Principales observations

Efficience : La capacité de l'OMS à produire des résultats de manière économique et dans les délais impartis est inégale.

Observation 17 : L'OMS utilise les ressources à Djibouti de manière efficiente et optimise sa valeur ajoutée en recherchant des synergies et des partenariats et en réorientant rapidement ses ressources pour répondre aux urgences sanitaires, telles que la pandémie de COVID-19.

Observation 18 : Parfois, les interventions de l'OMS n'ont pas été menées de manière efficiente. L'OMS a souvent participé au financement de la mise en œuvre directe des projets à Djibouti, en rupture avec son mandat habituel dans les contextes non urgents.

Observation 19 : Les ressources humaines du bureau de pays ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Organisation d'atteindre ses objectifs dans des domaines techniques tels que le renforcement des systèmes de santé dans le contexte du développement des soins de santé primaires, le financement de la santé, la réduction des obstacles aux soins de santé pour parvenir à la CSU et les fonctions d'appui, telles que le suivi et l'évaluation.

Observation 20 : Le recours excessif à des services de consultants temporaires a des répercussions sur l'efficience de l'OMS, car cela nuit à la stabilité de l'assistance technique apportée au Ministère de la santé et au suivi de la mise en œuvre de la JPRM.

Observation 21 : En l'absence de stratégie de coopération avec le pays, le processus de planification à Djibouti est axé sur les aspects opérationnels plutôt que sur l'obtention de résultats. En outre, puisqu'il n'existe pas de plan d'appui au pays, la contribution des trois niveaux de l'Organisation n'est pas clairement définie.

Observation 22 : En ce qui concerne les systèmes de gestion axée sur les résultats, le suivi des produits et des résultats de l'OMS à Djibouti est insuffisant. Peu d'informations sont notamment communiquées en lien avec le système de tableau de bord des produits institutionnels, qui repose sur une autoévaluation du bureau de pays de l'OMS. Si les indicateurs clés de performance du bureau régional fournissent plus de détails sur les programmes, ils sont axés davantage sur les domaines techniques et moins sur les domaines transversaux de renforcement du système de santé. L'utilisation de données de suivi permettant d'éclairer les décisions programmatiques est limitée.

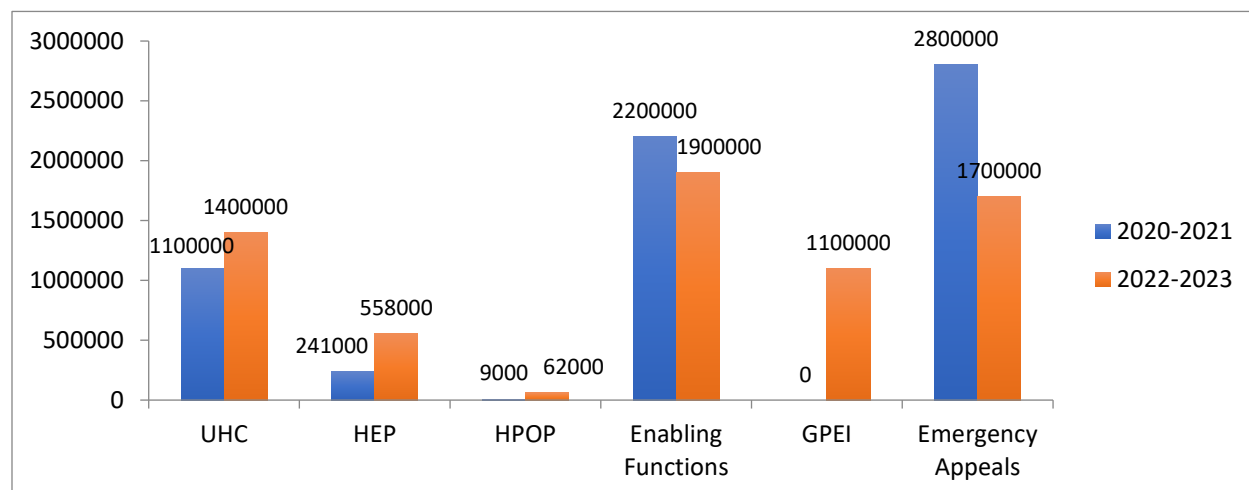
Observation 23 : Même si les programmes sont bien intégrés au niveau du bureau de pays, le cloisonnement des programmes à l'échelle du bureau régional et les demandes émanant de celui-ci empêchent parfois le bureau de pays de mettre l'accent sur les priorités définies dans le pays. Ce type de problème n'a pas été signalé en ce qui concerne l'appui fourni par le Siège de l'OMS.

3.8 Dans quelle mesure les interventions de l'OMS reflètent-elles une utilisation économique et opérationnelle efficiente des ressources, y compris pour répondre aux besoins de santé nouveaux et émergents qui nécessitent un ajustement ou une nouvelle hiérarchisation des interventions ?

3.8.1 Efficience dans l'utilisation des ressources

Dans la droite ligne des constatations correspondant à la question d'évaluation 3 concernant l'efficacité, la répartition des dépenses du bureau de pays par objectif stratégique au cours des deux derniers exercices biennaux montre que, **parmi les piliers relatifs aux objectifs du triple milliard, celui consacré à la CSU a concentré la majorité des ressources pendant les exercices biennaux 2020-2021 et 2022-2023, tandis que peu de dépenses ont été consacrées au pilier Amélioration de la santé des populations.** Outre les activités de base relatives aux objectifs du triple milliard, **les dépenses liées aux appels d'urgence, en particulier la riposte à la COVID-19, constituent une part importante des dépenses.** Pendant l'exercice biennal en cours, les dépenses relatives aux objectifs du triple milliard ont augmenté, et les activités d'éradication de la poliomyélite se sont intensifiées. La figure 6 montre l'évolution des dépenses du bureau de pays pour les différents objectifs stratégiques du treizième PGT, à savoir : le pilier CSU ; le pilier Préparation aux situations d'urgence ; le pilier Amélioration de la santé des populations ; le pilier Une OMS plus efficace et efficiente ; l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP) et les appels d'urgence.

Figure 6. Dépenses en USD par objectif stratégique du Bureau de l'OMS à Djibouti au cours des deux derniers exercices biennaux



Source : Portail Web du budget programme de l'OMS [\(23\)](#) ¹³

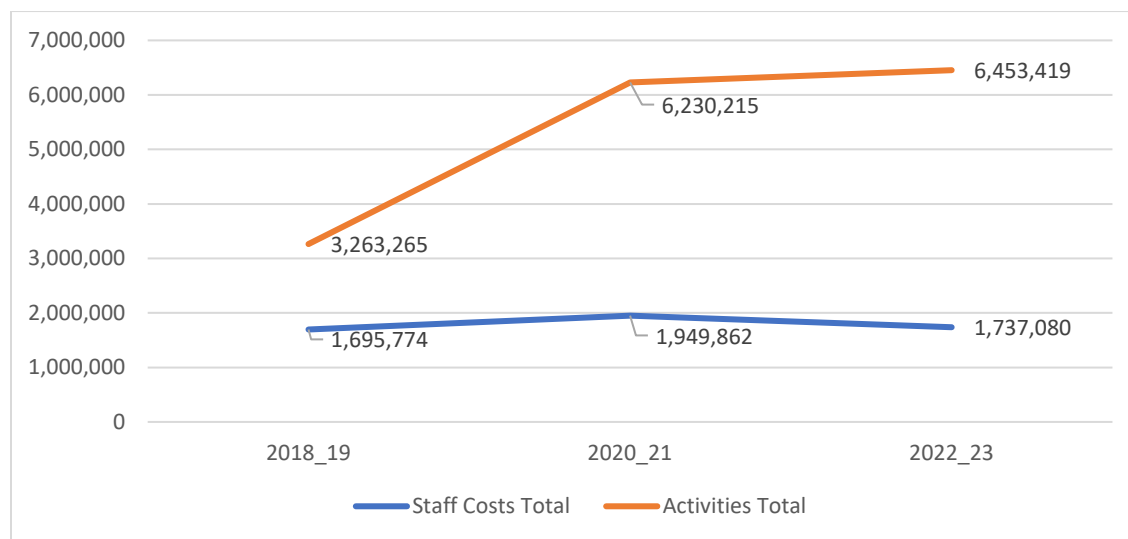
L'unité d'appui aux pays du Siège de l'OMS a établi une classification des pays de l'OMS en fonction du type d'appui dont ils ont besoin, en tenant compte de facteurs contextuels tels que la catégorie de revenu à laquelle le pays appartient et la présence ou non d'une réponse humanitaire. Cette classification va de A à E, A correspondant au plus faible niveau d'appui et E au niveau le

¹³ Dans la figure 7, au moment de l'évaluation (octobre 2023), les dépenses pour l'exercice biennal 2022-2023 avaient atteint un taux de 70 %, tandis que les dépenses pour 2020-2021 s'établissaient à 100 %. Les données de l'exercice biennal précédent n'ont pas été présentées dans le cadre du treizième PGT, de sorte qu'il n'a pas été possible de fournir une analyse des tendances pour les trois exercices biennaux à l'étude, dont fait partie l'exercice biennal 2018-2019.

plus élevé de mobilisation de l'OMS. Djibouti se trouve dans la catégorie D, qui regroupe les pays ayant besoin d'un appui technique complet sans opérations sur le terrain, ce qui signifie que le contexte ne nécessite pas de mise en œuvre directe d'ampleur.

L'analyse budgétaire (figure 7) montre que, **malgré une augmentation constante des coûts des activités, qui ont doublé au cours des trois derniers exercices biennaux (passant de 3,2 millions USD en 2018-2019 à 6,4 millions USD en 2022-2023), les dépenses liées au personnel restent largement stables, se situant autour de 1,7 million USD.** La part des dépenses liées au personnel est ainsi passée de 34 % à 21 % du budget total. Si cette évolution peut traduire des gains d'efficacité qui montrent que l'OMS est capable de faire plus avec moins de ressources humaines, elle nous renseigne également sur plusieurs autres aspects. Tout d'abord, comme indiqué ci-dessus, l'OMS étant un organisme technique, elle ne participe généralement pas à la mise en œuvre directe des activités, ce qui justifierait des coûts d'activité élevés. Ensuite, c'est l'assistance technique fournie par son personnel qui devrait représenter l'essentiel de la valeur ajoutée de l'OMS. Le fait que les activités soient menées avec peu de personnel peut donc s'expliquer par le fait que l'OMS a largement recours à des ressources externes à Djibouti, notamment à des consultants.

Figure 7. Évolution des budgets du bureau de l'OMS à Djibouti consacrés au personnel et aux activités sur la période 2018-2023 (en USD)



Source : Système mondial de gestion de l'OMS¹⁴

3.8.2 Efficience dans l'obtention de résultats grâce à l'établissement de partenariats

L'OMS à Djibouti s'efforce d'optimiser sa valeur ajoutée par rapport aux autres partenaires de la santé pour obtenir des résultats. Les répondants des organismes des Nations Unies et des organismes donateurs ont salué cette approche complémentaire de l'OMS. Parmi les exemples de contributions économes en ressources, on peut citer l'adoption par le Fonds mondial des orientations normatives mondiales de l'OMS sur le traitement du paludisme, du VIH et de la tuberculose et leur adaptation au contexte de Djibouti pour faciliter la formation des agents de santé. L'OMS a parfois utilisé ses ressources de

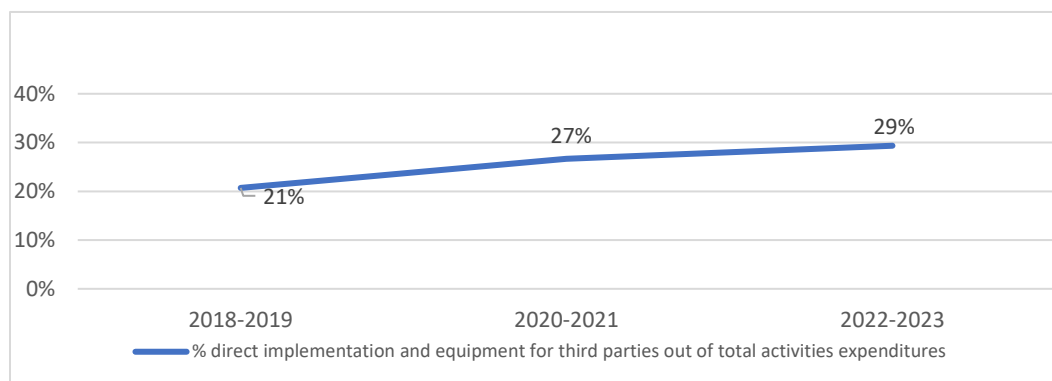
¹⁴ L'analyse des données financières se fonde exclusivement sur des informations concernant le bureau de pays, car aucune donnée n'a été fournie dans le cadre de l'évaluation sur les dépenses du Siège et du bureau régional liées au programme à Djibouti.

façon à compléter les interventions d'autres organismes pour obtenir des résultats, par exemple en partageant avec l'UNICEF les activités relatives à la lutte contre la malnutrition de l'enfant. L'OMS a ainsi soutenu la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère présentant des complications médicales, tandis que l'UNICEF s'est occupé des cas simples de malnutrition sévère. Dans certains cas, l'OMS a également mis en commun des fonds avec d'autres organismes pour mener à bien des activités, par exemple l'organisation de campagnes intégrées de proximité pour la vaccination, la nutrition et les soins prénatals avec l'UNICEF.

3.8.3 Efficience et rapidité de l'allocation des ressources financières pour répondre aux besoins émergents

L'OMS est attentive aux problèmes de santé émergents, et mobilise et réoriente les ressources vers les domaines où elles sont nécessaires. Par exemple, l'OMS a pu mobiliser et réorienter rapidement des ressources dans le cadre de la riposte à la COVID-19. La figure 6 ci-dessus montre l'augmentation des dépenses liées aux interventions d'urgence au cours de l'exercice biennal 2020-2021, correspondant à la riposte à la COVID-19. **Toutefois, le choix des interventions à mettre en œuvre pour obtenir les résultats escomptés n'est pas toujours efficient.** C'est le cas, par exemple, du financement de la mise en œuvre directe, de l'achat de fournitures médicales et de MII et du soutien logistique apporté au Ministère de la santé lors de missions sur le terrain autres que celles menées dans le cadre des interventions d'urgence. Une personne du Ministère de la santé a ainsi expliqué que l'OMS avait financé l'extension des soins mobiles essentiels, l'achat de véhicules pour les régions et le carburant pour les déplacements à l'échelle locale. Si la riposte à la COVID-19 justifiait un soutien opérationnel direct de l'OMS, celle-ci ne fournit généralement pas d'assistance directe à la mise en œuvre en dehors des situations d'urgence. Les répondants du bureau de pays ont justifié cette situation par le fait que, pendant un certain temps, le financement des donateurs ne passait pas directement par le Ministère de la santé. Cependant, ils ont admis que la participation à la mise en œuvre directe ne constituait pas une utilisation efficiente des ressources de l'OMS à long terme. Les ressources allouées à la mise en œuvre directe et à la distribution d'équipements à des tiers ont néanmoins augmenté au cours des trois derniers exercices biennaux et représentent 29 % du budget des activités du bureau de pays en 2022-2023, comme l'illustre la figure 8. Ce chiffre ne tient pas compte des ressources consacrées aux fournitures médicales, qui ont représenté une part importante des dépenses liées à la COVID-19.

Figure 8. Pourcentage des dépenses directes de mise en œuvre et d'équipement pour des tiers par rapport aux dépenses totales des activités



Source : *Système mondial de gestion de l'OMS*¹⁵

¹⁵ L'analyse des données financières se fonde exclusivement sur des informations concernant le bureau de pays, car aucune donnée n'a été fournie dans le cadre de l'évaluation sur les dépenses du Siège et du bureau régional liées au programme à Djibouti.

3.8.4 Efficience dans l'affectation des ressources humaines

L'OMS ne possède pas les ressources humaines nécessaires lui permettant de réaliser ses ambitions et d'offrir un soutien stable au Ministère de la santé, et est en grande partie tributaire des services de consultants engagés sur une courte durée à des postes clés. Cela peut nuire à la continuité de ses travaux, ainsi qu'à l'efficience de la planification et de la surveillance des activités. Selon une personne du Ministère de la santé, le problème réside dans le changement d'interlocuteur à l'OMS, et l'absence de suivi régulier au long cours. D'autres répondants du Ministère de la santé ont noté que la capacité de suivi et de surveillance des activités planifiées de l'OMS était limitée, et qu'après la signature de la JPRM par les deux parties, aucun suivi de sa mise en œuvre n'avait été effectué par les différentes directions du Ministère ou par l'OMS. Cette situation a été accentuée par les demandes fluctuantes du Ministère, qui n'ont pas permis à l'OMS de mener à bien les activités planifiées.

Malgré les compétences et l'expérience des consultants engagés à court terme, le recours à ce type de contrat a également une incidence sur le type de travail que l'OMS est en mesure d'effectuer. Des répondants du Ministère de la santé ont ainsi noté que **l'appui technique fourni par l'OMS avait souvent pris la forme de consultations à court terme.** Ceux-ci ont appelé l'OMS à réorienter ses ressources de manière à apporter un soutien technique à long terme pour l'exécution des plans et à renforcer les capacités du personnel. Une personne du Ministère de la santé a affirmé qu'il fallait améliorer le suivi et la mise en œuvre des activités, car 95 % des activités prévues dans la JPRM n'avaient pas été mises en œuvre. Elle estime que planifier et organiser toute une série de réunions préparatoires est une perte de temps si les activités prévues ne reçoivent pas le financement nécessaire.

Bien que le rôle de l'OMS ne soit pas de « financer » la mise en œuvre des activités, des ressources humaines et financières sont nécessaires au suivi des activités prévues. Cela permettrait notamment aux pouvoirs publics et au Ministère de la santé de disposer de moyens leur permettant de déterminer, de planifier et de défendre au plus haut niveau gouvernemental l'attribution des ressources adéquates, le cas échéant.

La représentante actuelle de l'OMS à Djibouti a préféré recruter du personnel technique sur le plan national pour compenser la réduction du nombre de postes internationaux. Cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer les capacités au niveau national, et à améliorer l'efficacité des activités de l'OMS en faisant appel à des professionnels compétents ayant une bonne connaissance du contexte ainsi que des contacts utiles.

L'OMS a établi un organigramme de base pour les bureaux de pays dans chacune des catégories (A à D). Pour les bureaux de la catégorie D, comme celui de Djibouti, le nombre total de membres du personnel devrait passer de huit à environ 15 à 20. En augmentant ses effectifs, le bureau de pays pourrait assumer davantage de responsabilités, notamment en jouant son rôle fédérateur, en assurant sa mission de gestion du renforcement du système de santé et en participant aux initiatives régionales. À cette fin, la représentante de l'OMS a établi un nouvel organigramme, qui a été approuvé par le Directeur régional et qui tient compte des changements à apporter aux effectifs du bureau de l'OMS. Ce nouvel organigramme comprend notamment un poste de responsable de la santé publique dont le ou la titulaire apporterait un soutien stratégique au renforcement du système de santé au-delà des programmes techniques spécifiques. À ce jour, cependant, les postes prévus dans le nouvel organigramme n'ont pas encore été pourvus en raison de la lenteur des processus de gestion des ressources humaines au sein du bureau régional. En plus des postes essentiels, le bureau de pays ou le bureau régional pourraient également mobiliser des fonds leur permettant de recruter du personnel supplémentaire dans de nouveaux domaines. Par exemple, le Programme spécial sur les soins de santé primaires du Siège de l'OMS a appuyé la création d'un poste de conseiller en politiques de soins de santé primaires dans certains bureaux de pays.

3.9. Dans quelle mesure les systèmes de gestion axée sur les résultats sont-ils adéquats pour assurer une affectation efficiente et en temps opportun des ressources et une évaluation adéquate des résultats, y compris lorsque les circonstances évoluent ?

3.9.1 Planification

Le processus de planification à Djibouti est axé sur les activités, ainsi que sur les aspects opérationnels plutôt que sur l'obtention de résultats et les indicateurs contextuels de résultats en matière de santé. Une personne de l'OMS à Djibouti a déclaré :

Nous devons progressivement réduire la mise en œuvre d'activités et ne plus nous contenter d'utiliser les fonds, car cela ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble de nos objectifs. Notre programme stratégique n'est pas toujours bien compris, et cela diminue notre responsabilisation au regard des améliorations dans le domaine de la santé.

En l'absence de stratégie de coopération avec le pays, le principal cadre de résultats utilisé à Djibouti est le treizième PGT. Cela a conduit le bureau de pays à adapter rétrospectivement les activités planifiées pour les faire correspondre au treizième PGT plutôt qu'à transposer les résultats et les produits escomptés globaux au contexte djiboutien. La Division Données, analyse et résultologie (DDI) de l'OMS a préconisé l'adoption d'une approche de la planification fondée sur les données grâce à une analyse approfondie des indicateurs de résultats en matière de santé au niveau du pays. Ce travail est essentiel, car il permettra de s'assurer que des priorités sont fixées pour l'accélération des progrès quant aux indicateurs de santé pour lesquels un retard est constaté, et de définir des cibles spécifiques au pays concernant l'impact et les résultats escomptés de façon à ce que le cadre du treizième PGT soit adapté au contexte de Djibouti.

Le problème des processus de planification menés en parallèle est aggravé par le manque de coordination et la fragmentation des activités au niveau du bureau régional. Le bureau de pays reçoit de nombreuses demandes ponctuelles de participation à des manifestations internationales et des demandes d'informations de la part du bureau régional, qui ne sont ni intégrées aux plans nationaux existants ni en phase avec ceux-ci. Les répondants ont indiqué que certaines de ces initiatives pouvaient empiéter sur les activités planifiées compte tenu du manque de personnel disponible dans le bureau de pays et au niveau des pouvoirs publics. En effet, dans un petit bureau de pays comme celui de Djibouti, une même personne peut être le point focal pour plusieurs domaines thématiques, par exemple les MNT, la sécurité routière et la santé mentale, alors qu'au sein du bureau régional, des départements distincts se consacrent à chacun de ces domaines, et sont eux-mêmes divisés en sous-spécialités (démence, usage de substances psychoactives, nutrition, etc.). Le manque de coordination entre les différents domaines peut créer une surcharge de travail lorsque des demandes émanant de différents départements parviennent aux pays ou lorsque l'on décide d'inclure dans les plans de travail des domaines qui n'étaient pas considérés comme prioritaires au niveau des pays, par exemple la lutte antitabac. Une personne du bureau de pays a affirmé :

Au niveau du bureau de pays, nous travaillons de manière transversale et polyvalente et nous portons différentes casquettes, mais au niveau régional, il existe des sous-divisions. Par exemple, la dengue relève des maladies tropicales négligées (MTN) et du Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire. C'est parfois redondant, donc nous devons réunir ces sous-divisions pour en discuter. Elles doivent d'abord collaborer entre elles avant de pouvoir collaborer avec nous.

D'une manière générale, le cloisonnement des activités par maladie au niveau du bureau régional est susceptible de faire obstacle à la mise en place d'une approche systémique de la santé visant à traiter les problématiques communes à tous les programmes. C'est le cas, par exemple, des services de santé communautaires, qui reçoivent actuellement un appui dans le cadre du programme de vaccination plutôt que dans le cadre d'une stratégie menée au niveau du système de santé. Ce type de

problème n'a pas été mentionné en ce qui concerne le Siège de l'OMS, qui a principalement apporté un soutien technique au bureau de pays lorsque celui-ci en avait fait la demande par l'intermédiaire du bureau régional.

3.9.2 Suivi et communication de l'information

Le suivi des produits et des résultats de l'OMS à Djibouti est limité, et les données de suivi ne sont pas utilisées dans une large mesure pour orienter les activités et l'allocation des ressources, mais plutôt comme un mécanisme permettant de rendre des comptes aux niveaux supérieurs.

Le système d'établissement de rapports institutionnels, à savoir le tableau de bord des produits, ne rend pas suffisamment compte de la contribution de l'OMS dans le pays. Les rapports établis grâce au tableau de bord des produits qui ont été examinés dans le cadre de l'évaluation ne contenaient que peu de détails sur les interventions et leurs résultats, à la différence des informations recueillies lors des entretiens avec le personnel de l'OMS et du Ministère de la santé. Les informations fournies par les répondants de l'OMS à Djibouti révèlent que le système du tableau de bord des produits n'a pas été véritablement mis en œuvre, en raison notamment du peu de temps consacré par le personnel à l'établissement des rapports. Les rapports établis grâce au tableau de bord des produits ne fournissent aucune justification quant aux notes attribuées, et certaines de ces notes ne semblent pas crédibles au vu des résultats obtenus. Par exemple, la dimension « genre, équité et droits » a reçu une note très élevée pour la plupart des produits, alors que la contribution de l'OMS et l'accent mis sur ces domaines semblaient limités. Le tableau de bord des produits présente une autre limite : son utilité dans l'orientation des travaux du bureau de pays reste incertaine, et il a été conçu principalement comme un processus permettant de rendre des comptes aux niveaux supérieurs, et non comme un moyen de susciter une réflexion et d'améliorer les interventions au niveau du pays.

Comme indiqué dans la partie correspondant à la question d'évaluation 3 relative aux critères d'efficacité, si les indicateurs clés de performance régionaux ont été mieux réalisés que les indicateurs du tableau de bord des produits, il s'agit en grande partie d'indicateurs relatifs à des maladies ou à des sujets spécifiques, qui rendent principalement compte des interventions de l'OMS en matière d'assistance technique, mais ne disent rien des fonctions de mobilisation et de leadership de l'OMS. Une personne de l'OMS a fait remarquer que les programmes stratégiques et les activités de plaidoyer n'étaient pas bien documentés, et qu'il fallait intégrer ces éléments aux indicateurs de performance. Les fonctions de l'OMS en matière de mobilisation, de promotion des collaborations et des partenariats, de plaidoyer et de renforcement des capacités ne sont pas bien restituées, alors qu'elles sont essentielles pour faire progresser les programmes stratégiques de l'OMS, tels que la promotion d'une approche des soins de santé primaires et la mobilisation de ressources adéquates en faveur de la CSU. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus concernant le tableau de bord des produits, les résultats des indicateurs clés de performance du bureau régional ne semblent pas être utilisés comme source principale d'information dans le système de gestion axée sur les résultats de l'OMS à Djibouti.

Durabilité : Dans quelle mesure l'OMS contribue-t-elle au renforcement des capacités et de l'appropriation nationales nécessaires pour répondre aux besoins et aux priorités sanitaires de Djibouti dans le cadre de l'aide humanitaire et du développement ?

Cette partie évalue dans quelle mesure l'OMS contribue à la réalisation des objectifs nationaux à long terme de Djibouti et à la mise en place d'un système de santé résilient. Elle analyse également dans quelle mesure les interventions de l'OMS contribuent à l'appropriation nationale du renforcement des systèmes de santé ainsi qu'au renforcement de la capacité du pays à obtenir les résultats escomptés de manière durable.

Principales observations

Durabilité : La contribution de l'OMS à la résilience du système de santé et à la capacité à réagir aux chocs extérieurs est limitée, ce qui nuit à la pérennité des efforts de l'OMS en matière de renforcement du système de santé

Observation 24 : Les interventions de l'OMS visant à renforcer le système de santé sont fortement susceptibles d'entraîner des changements durables. Toutefois, elles ne permettent pas de faire évoluer clairement les capacités du système de santé, à l'exception des activités visant à améliorer la surveillance et la gestion des données, dont les résultats commencent à se faire sentir.

Observation 25 : Malgré les bonnes pratiques et les enseignements tirés de la riposte à la COVID-19, la contribution de l'OMS à la résilience du système de santé et à la capacité à réagir aux chocs extérieurs s'avère, dans l'ensemble, limitée.

Observation 26 : Le secteur de la santé est fragmenté et mal réglementé, le secteur de la santé publique est fortement tributaire du financement des donateurs, et le financement des principaux donateurs devrait diminuer à Djibouti au cours des prochaines années. Tous ces aspects constituent des obstacles à la pérennité des interventions visant à soutenir le secteur de la santé.

Observation 27 : Les organismes de financement cherchent de plus en plus à favoriser l'appropriation nationale et le financement national du système de santé. Les partenaires financiers et les pouvoirs publics espèrent que l'OMS mettra davantage l'accent sur le financement durable du secteur de la santé.

3.10 Dans quelle mesure l'OMS contribue-t-elle à la réalisation des objectifs à long terme de Djibouti et à la mise en place d'un système de santé résilient et capable de réagir aux chocs, notamment en renforçant la capacité du pays à répondre aux besoins actuels et futurs en matière de santé ?

3.10.1 Appui aux objectifs à long terme de Djibouti

L'OMS a contribué à des changements durables pour ce qui concerne les cinq priorités stratégiques du PNDS décrites dans le tableau 5. Les contraintes structurelles au niveau national et les capacités restreintes du bureau de pays et du Ministère de la santé font toutefois obstacle à la pérennité de ces efforts. Dans l'ensemble, le modèle opérationnel de l'OMS, qui repose sur le renforcement des capacités nationales pour améliorer les résultats en matière de santé, est par nature susceptible

d'apporter des changements durables. Les répondants du Ministère de la santé ont souligné la différence entre l'OMS et les autres partenaires de la santé à cet égard, considérant que l'OMS était avant tout un organisme technique et un proche collaborateur du Ministère de la santé. Les points forts de l'OMS concernaient notamment le matériel et les fournitures, les réunions du personnel de santé et les systèmes de surveillance. En ce qui concerne la disponibilité des médicaments essentiels, l'OMS s'est efforcée de renforcer les capacités de la CAMME et a apporté son concours à l'élaboration d'une liste nationale de médicaments essentiels pendant l'exercice biennal en cours. On ne sait pas encore dans quelle mesure ces efforts sont susceptibles d'améliorer durablement la disponibilité des médicaments essentiels, compte tenu des difficultés liées à la réglementation et au financement du secteur de la santé. En ce qui concerne la qualification des ressources humaines, l'OMS a apporté son soutien à la formation en cascade du personnel de santé dans différents domaines, tels que le diagnostic et le traitement des maladies tropicales négligées, la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère ou la vaccination. Ces efforts pourraient se poursuivre, mais l'obtention de résultats à long terme dépendra fortement de la capacité du Ministère de la santé à superviser efficacement le personnel. L'OMS a également contribué à la mise en œuvre de la plateforme DHIS2 à Djibouti ainsi qu'au renforcement de la capacité du pays à détecter rapidement les épidémies et à y faire face, notamment à détecter la poliomyélite au moyen de la surveillance de l'environnement et des cas, ou encore la rougeole par la reprise des investigations cliniques pour les cas de fièvre éruptive. Les résultats obtenus dans ce domaine devraient permettre d'améliorer durablement les capacités de surveillance à Djibouti.

Les difficultés rencontrées concernent notamment la fragmentation du secteur de la santé, le financement insuffisant du système de santé, la gouvernance limitée et le taux de rotation élevé du personnel du Ministère de la santé. L'un des facteurs empêchant l'OMS de contribuer durablement aux résultats sanitaires de Djibouti est la rotation importante du personnel au sein du Ministère de la santé. En effet, les efforts de renforcement des capacités se heurtent au départ des interlocuteurs du Ministère affectés à d'autres postes. Dans certains domaines d'activité récemment développés, tels que les MNT et la santé mentale, il est probable que les changements observés ne soient pas encore durables, car ces programmes sont largement tributaires du soutien technique de l'OMS. Une personne interrogée à Djibouti a ainsi déclaré que sans le soutien de l'OMS, les activités relatives à la santé mentale étaient vouées à disparaître. Dans d'autres domaines tels que le paludisme, la tuberculose et le VIH, il est probable que l'adoption de protocoles améliorés de détection, de diagnostic et de traitement constitue une solution durable puisque d'autres partenaires du secteur de la santé, tels que le Fonds mondial, orientent leur soutien vers des programmes respectant les directives de l'OMS. La fragmentation du secteur de la santé et l'absence de réglementation s'appliquant aux différents mécanismes de prestation de services, au sein du Ministère de la santé et en dehors, représentent également un problème important pour la gouvernance du système de santé. Les répondants de l'OMS et du Ministère de la santé ont indiqué que le Ministère disposait d'un pouvoir de surveillance et de réglementation limité vis-à-vis d'autres acteurs majeurs du système de santé, tels que la CNSS, qui dépend du Ministère du travail, et les prestataires de services parapublics, comme la police, la gendarmerie, les garde-côtes et l'armée, qui dépendent du Ministère de l'intérieur. Jusqu'à présent, ces questions n'ont pas occupé une place prépondérante dans les interventions de l'OMS.

3.10.2 Contribution à un système de santé résilient et capable de réagir aux chocs

Les répondants du Ministère de la santé et des partenaires de la santé, qui ont commenté la riposte à la COVID-19, ont unanimement salué le rôle de leadership et les bonnes pratiques de l'OMS dans la riposte à la pandémie. Toutefois, peu d'éléments prouvent que les interventions de l'OMS ont contribué à renforcer la résilience du système de santé et sa capacité à réagir aux chocs extérieurs. Le score obtenu par Djibouti pour l'indice relatif aux principales capacités du RSI est faible et en baisse, et cela concerne particulièrement les indicateurs relatifs à la dimension Préparation. Selon la JPRM et les rapports sur les indicateurs clés de performance du bureau régional, les activités visant l'élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgence et les exercices planifiés n'ont pas été réalisés, pas plus que l'évaluation extérieure conjointe du RSI qui était prévue, laquelle aurait permis de formuler des recommandations sur l'amélioration de la préparation aux situations d'urgence. Les répondants de l'OMS ont estimé que la riposte à la COVID-19 à Djibouti avait donné lieu à la mise en œuvre de bonnes pratiques dont on pouvait s'inspirer pour répondre à d'autres situations d'urgence, notamment le mécanisme de coordination de la riposte

et la participation des communautés à la microplanification de la vaccination. L'OMS pourrait échanger avec ses interlocuteurs du Ministère de la santé afin de déterminer comment mettre à profit ces expériences et en tirer les enseignements qui guideront les futures interventions d'urgence.

3.11. Dans quelle mesure les interventions de l'OMS favorisent-elles l'appropriation nationale des efforts de renforcement du système de santé, ainsi que la capacité du pays à obtenir les résultats prévus dans les politiques et stratégies nationales de santé pertinentes ? Existe-t-il des données montrant que les bénéfices perdureront ?

À Djibouti, l'investissement public en faveur du système de santé est faible, et les répondants de toutes les catégories ont indiqué que le pays devait s'approprier les priorités en matière de santé afin d'accélérer les progrès dans la réalisation des ODD relatifs à la santé accusant un retard au niveau national.

Le Gouvernement djiboutien s'est fermement engagé à lutter contre les inégalités en matière de santé et à faire progresser la réalisation des objectifs relatifs à l'instauration de la couverture sanitaire universelle. Lors du Sommet mondial pour le développement social qui s'est tenu à Copenhague en 1995, le Gouvernement djiboutien s'est engagé à consacrer 20 % de son budget national à la santé. La forte croissance économique enregistrée par Djibouti ces dernières années offre de nouvelles possibilités d'investissement public en faveur de la santé, et le financement extérieur a plus que doublé au cours de la période : le montant total net de l'aide publique au développement reçue pour les secteurs de la recherche médicale et des soins de santé de base est passé de 4 millions USD en 2011 à 8,9 millions USD en 2021 [\(24\)](#). Pourtant, les dépenses des administrations publiques nationales en santé ne représentaient que 4,3 % des dépenses publiques générales en 2020, contre 8,5 % en 2011 [\(25\)](#).¹⁶

Les programmes de santé nationaux sont fortement tributaires du financement des donateurs, et certains programmes du Ministère ne disposent pas d'un budget spécifique consacré aux activités telles que les programmes de lutte contre les MNT et les programmes relatifs à la santé mentale. De même, alors que le Gouvernement a accordé aux migrants un droit d'accès gratuit aux services de santé, le coût de cette politique est entièrement assumé par les partenaires, et sa pérennité est incertaine compte tenu de la fragilité et de la fragmentation du système de santé. Le PEV dépend du financement de l'Alliance Gavi, de l'UNICEF et de l'OMS. L'UNICEF finance entièrement les vaccins traditionnels systématiques, et l'OMS finance la distribution de moustiquaires, deux activités inhabituelles en dehors des contextes d'urgence.

Les principaux donateurs ont fait part de leur intention de réduire progressivement leurs investissements. L'Alliance Gavi a entamé une phase de transition accélérée depuis fin 2023, et prévoit de réduire progressivement son financement à partir de 2029. Alors qu'en 2023, cette organisation prenait en charge la presque totalité des coûts du PEV, elle réduira son financement à 80 % du budget du programme de vaccination en 2024. Le Fonds mondial a également indiqué qu'il comptait réduire progressivement la part de son financement à l'avenir, et a encouragé le Gouvernement à affecter davantage de ressources nationales en compensation, dans le cadre d'un cofinancement.

Si Djibouti accède à la catégorie des pays à revenu intermédiaire, la dépendance de son système de santé à l'égard du financement extérieur risque d'être de plus en plus difficile à justifier. Les principaux donateurs souhaitent unir leurs forces pour accompagner la transition du financement du secteur de la santé vers un accroissement de l'investissement public dans ce domaine. À cet égard, il est encourageant de constater que l'État djiboutien a accepté d'assumer la gestion des financements du

¹⁶ Ces chiffres ne tiennent sans doute pas compte des investissements publics dans la santé qui ne passent pas par le Ministère de la santé, tels que les financements de la Caisse nationale de sécurité sociale et des prestataires de services parapublics.

Fonds mondial en 2023, qui était jusqu'à présent assurée principalement par le PNUD à Djibouti. Dans ce contexte, le Fonds mondial et ses partenaires se sont attachés à renforcer la capacité des pouvoirs publics à gérer ces fonds et à faciliter la transition vers un financement national de la santé.

Les répondants ont souligné que **l'OMS était bien placée pour faciliter le dialogue avec le Gouvernement djiboutien sur le thème du financement de la santé**. Les domaines dans lesquels le Ministère de la santé pourrait bénéficier de l'assistance technique de l'OMS sont le suivi des dépenses publiques et des dépenses des donateurs en matière de santé, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de financement du secteur de la santé. Une personne du Ministère de la santé a expliqué qu'il n'existait pas de document définissant une stratégie de financement de la santé. La Banque mondiale avait réalisé une évaluation du financement du système de santé, mais les comptes nationaux de la santé doivent être établis chaque année, tâche à laquelle l'OMS apportait auparavant un appui. La prochaine étape, après cette étude de la Banque mondiale, consisterait à élaborer une stratégie de financement en collaboration avec l'OMS.

4. Conclusions

Conclusion 1

Pertinence : De manière générale, les interventions de l'OMS se révèlent très pertinentes au regard des besoins du pays en matière de santé. Cependant, les priorités ne sont pas toujours établies à partir de données probantes sur le système de santé et les résultats en matière de santé. Les interventions de l'OMS ne sont pas guidées par une analyse de la situation des groupes vulnérables dans le pays. L'accent mis sur l'octroi d'une assistance technique aux programmes axés sur les maladies, au détriment d'une approche orientée sur les soins de santé primaires, ne permet pas à l'Organisation de réaliser le plein potentiel de sa contribution aux objectifs relatifs à la CSU. La période actuelle offre à l'OMS à Djibouti une occasion unique de redéfinir son rôle et de recentrer ses efforts de manière stratégique, compte tenu de l'ambition croissante affichée par Djibouti de rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure selon la classification de la Banque mondiale. Le bureau de pays a également la possibilité de renforcer son rôle au niveau régional et dans plusieurs processus de planification stratégique en cours dans le pays. L'évaluation a permis de recenser plusieurs domaines dans lesquels l'OMS peut apporter une valeur ajoutée et mettre son rôle à profit pour renforcer le système de santé.

Conclusion 2

Cohérence : L'OMS est en phase avec les autres partenaires de la santé à Djibouti et joue un rôle complémentaire du leur ; cependant, la cohérence interne et externe des activités de l'OMS est entravée par l'absence de stratégie valide de coopération avec le pays, de plans opérationnels et de budgets permettant de mettre en œuvre le PNDS, ainsi que par l'absence de plateforme de coordination pour les acteurs de la santé à Djibouti. L'absence de stratégie valide de coopération avec le pays et de plan biennal connexe d'appui au pays, dans lesquels serait décrite la contribution des trois niveaux de l'OMS, ne permet pas à l'Organisation de hiérarchiser efficacement ses interventions. La future stratégie de l'OMS doit impérativement s'attaquer aux freins qui entravent la mise en œuvre efficace du PNDS. Il existe des exemples de collaborations fructueuses pour l'OMS au sein de l'équipe de pays des Nations Unies ; toutefois, la coordination avec les principaux partenaires de la santé en dehors de l'équipe de pays est limitée, faute de plateforme fonctionnelle et officielle pilotée par le Ministère de la santé. Pour que l'OMS se positionne différemment sur ces questions, il faudrait qu'elle modifie le type d'activités mises en œuvre. En effet, l'Organisation ne remplit pas pleinement sa mission de chef de file et son rôle fédérateur, qui font partie de son mandat. Il faudrait également changer la perception que certains partenaires ont de l'OMS, celle d'un petit organisme donateur. Malgré ses efforts, l'OMS ne parvient pas à promouvoir une approche de la gouvernance du secteur de la santé mobilisant l'ensemble de la société et des pouvoirs publics ni à obtenir la participation de toutes les parties prenantes multisectorielles.

Conclusion 3

Efficacité : Si l'OMS a clairement contribué à améliorer les résultats du système de santé en matière de services de santé maternelle et néonatale, de traitement de la tuberculose et de disponibilité des informations sanitaires, dans l'ensemble, la mise en œuvre des interventions prévues s'avère insuffisante. Entre 2018 et 2021, les interventions prévues par l'OMS ont été retardées, car les ressources humaines et financières étaient pour l'essentiel réaffectées à la riposte aux situations d'urgence et aux flambées épidémiques. En outre, l'efficacité des contributions de l'OMS à Djibouti a été restreinte par le changement de représentants de l'OMS, ainsi que par l'instabilité de sa relation avec le Ministère de la santé. Néanmoins, l'OMS a apporté un soutien efficace à la riposte d'urgence des autorités publiques nationales à la COVID-19. Au regard de ce que prévoyait la JPRM, peu d'interventions ont porté sur la préparation aux situations d'urgence et sur le pilier Amélioration de la santé des populations. En dehors des interventions visant à pallier l'absence de services de santé communautaires pour réduire les obstacles à l'accès aux soins de santé, l'action menée par l'OMS à Djibouti n'intègre pas systématiquement l'analyse de l'égalité des genres et de l'équité en santé ou encore les droits des différents groupes marginalisés.

Conclusion 4

Efficience : Dans l'ensemble, une grande partie des ressources ont été consacrées à la mise en œuvre directe, ce qui ne constitue sans doute pas l'utilisation la plus efficace des ressources dans le contexte de Djibouti. De plus, les ressources octroyées sont insuffisantes pour permettre à l'OMS d'atteindre ses objectifs. Si la capacité de l'OMS à répondre aux besoins du Ministère de la santé et aux différentes demandes s'avère satisfaisante, en particulier dans les situations d'urgence sanitaire, l'Organisation doit trouver l'équilibre entre la souplesse nécessaire et le maintien d'une position stratégique quant aux priorités définies. Compte tenu de la lenteur des processus de recrutement, les ressources humaines du bureau de pays ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Organisation de concrétiser ses ambitions. En augmentant ses effectifs, le bureau de pays pourrait assumer davantage de responsabilités, notamment remplir son rôle fédérateur et sa fonction de chef de file dans le secteur de la santé, renforcer le système de santé et participer aux initiatives régionales. À ce jour, les données de suivi ne permettent pas de rendre compte des activités menées par le bureau de pays et ne sont pas suffisamment utilisées pour orienter la programmation. Bien que crucial dans de nombreux domaines techniques, le soutien du bureau régional n'est pas toujours apporté en temps utile et ne correspond pas toujours aux priorités nationales.

Conclusion 5

Durabilité : La contribution de l'OMS à un système de santé plus résilient s'avère limitée et la préparation aux situations d'urgence reste insuffisante. Dans l'ensemble, l'investissement des pouvoirs publics dans le système de santé public est fragmenté entre différents mécanismes de prestation de services. Les programmes gérés par le Ministère de la santé ayant fait l'objet de peu d'investissements, ils sont particulièrement vulnérables en cas de réduction de l'aide extérieure. Il est donc nécessaire de mettre en place des réformes et d'adopter de nouvelles réglementations permettant de réduire la fragmentation, et de soutenir le financement pérenne du secteur de la santé, tout en préparant une transition vers une augmentation des financements nationaux et une meilleure appropriation nationale des programmes de santé.

5. Recommandations

Les recommandations ci-dessous ont été élaborées conjointement avec les membres du Groupe de référence pour l'évaluation, composé de membres du Ministère de la santé, des organismes des Nations Unies à Djibouti et du personnel de l'OMS aux niveaux national et régional, lors d'un atelier en ligne organisé le 23 novembre 2023.

Les recommandations sont classées comme suit : priorité élevée – recommandations qu'il conviendrait d'intégrer au prochain cycle de planification et qui doivent être traitées pendant l'exercice biennal en cours ; priorité moyenne – recommandations qu'il conviendrait de mettre en œuvre au cours du prochain cycle de planification (2 ans).

Les recommandations en italique sont urgentes.

Recommandation	Entité principale et entités d'appui	Niveau de priorité/d'urgence
Recommandation 1. Au cours des cinq prochaines années, le bureau de pays et le bureau régional de l'OMS doivent accorder la priorité aux interventions de renforcement du système de santé et élaborer une approche des soins de santé primaires servant de cadre général à la mise en œuvre des activités spécifiques aux programmes.		
a. Veiller à ce que les domaines d'intervention prioritaires de l'OMS soient définis sur la base d'une analyse de l'évolution des indicateurs de santé dans le cadre de la JPRM et de la stratégie de coopération avec le pays	Bureau de pays /Soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et de la DDI	Élevée
b. <i>Promouvoir une approche des soins de santé primaires grâce à l'élaboration d'une carte sanitaire associée à d'autres processus qui permettront d'optimiser son utilité (par exemple, les règlements sanitaires) et de mettre à disposition un ensemble de services de base au niveau des soins de santé primaires</i>	Bureau de pays /Soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et du Programme spécial sur les soins de santé primaires du Siège	Élevée
c. Soutenir l'institutionnalisation des services de santé communautaires, en s'appuyant sur la stratégie élaborée actuellement en collaboration avec l'UNICEF et avec la contribution technique de l'OMS	Bureau de pays /Soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et du Programme spécial sur les soins de santé primaires du Siège/équipe de pays des Nations Unies	Moyenne
d. <i>Promouvoir la mise en œuvre de la CSU, en particulier en consignant, en analysant et en éliminant les obstacles aux soins de santé pour les différents groupes marginalisés. Il s'agira notamment de fournir une assistance technique à la production et à l'utilisation de données ventilées dans les activités de planification, de suivi et d'enquête, de faire réaliser des études qui serviront à concevoir des interventions en faveur des groupes marginalisés et de renforcer les réseaux de groupes marginalisés et les organisations de la société civile.</i>	Bureau de pays /soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et de	Élevée

	l'Unité Déterminants sociaux de la santé	
Recommandation 2. Les futures interventions de l'OMS doivent systématiquement s'attaquer aux obstacles à l'accès aux soins de santé et agir sur les déterminants de la santé.		
a. Éliminer les obstacles à l'accès aux soins, en soutenant l'institutionnalisation de la fonction d'agent de santé communautaire, notamment en tirant des enseignements de l'expérience du projet intégré de services de proximité pour la vaccination, les soins prénatals et la nutrition dans le cadre de l'élaboration de la stratégie relative aux agents de santé communautaires	Bureau de pays /Équipe de pays des Nations Unies, UNICEF	Moyenne
b. Appuyer l'examen des mesures de préparation aux situations d'urgence, notamment en soutenant l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan opérationnel détaillant les rôles et les responsabilités des différents acteurs publics et parapublics. Il peut s'agir, par exemple, de négocier la possibilité d'utiliser les installations hospitalières des bases militaires étrangères en cas de catastrophe majeure.	Bureau de pays /Soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et du Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire	Moyenne
c. <i>Agir sur les déterminants de la santé, en consignait et en analysant les différents facteurs d'inégalités en matière de santé et en renforçant la capacité du système de santé à y faire face. Les inégalités en matière de santé, les dynamiques de genre particulières et les besoins des populations marginalisées doivent être pris en compte dans toutes les activités d'assistance technique menées par l'OMS auprès des programmes, notamment dans le PEV, les interventions liées à la SRMNE, et la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose.</i>	Bureau de pays /soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale /du Département Déterminants sociaux de la santé	Élevée
d. Augmenter les ressources allouées par le bureau de pays à la mise en œuvre des interventions relevant du pilier Amélioration de la santé des populations. Les stratégies relatives aux facteurs de risque des MNT doivent être soutenues sur la base des résultats de l'enquête STEPwise, une fois que celle-ci aura été réalisée.	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale /unité Maladies non transmissibles	Moyenne
Recommandation 3. D'ici à mars 2024, affiner la théorie du changement reconstituée, qui servira de base à l'élaboration d'une stratégie de coopération avec le pays et du plan connexe d'appui au pays fondés sur des données probantes.		
a. <i>Fonder la stratégie de coopération avec le pays sur une analyse des résultats sanitaires nationaux ainsi que sur des indicateurs du système de santé, et l'élaborer avec le soutien de la DDI du Siège de l'OMS et en collaboration avec les parties prenantes du Ministère de la santé, dans le cadre d'un exercice de renforcement des capacités.</i>	Bureau de pays /Soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et de la DDI	Élevée
b. <i>Fonder l'élaboration de la stratégie de coopération avec le pays sur un processus de théorie du changement permettant de définir clairement les changements auxquels l'OMS contribuera au niveau du système de santé, et traduire les résultats et les produits du treizième PGT en cibles pertinentes dans le contexte djiboutien. Les changements intermédiaires (au niveau des politiques et des programmes) ainsi que les interventions de l'OMS permettant de favoriser ces changements doivent être recensés.</i>	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale /Unité d'appui aux pays	Élevée
c. Utiliser la stratégie de coopération avec le pays comme base pour mieux faire connaître le rôle de l'OMS aux autres partenaires du secteur de la santé, et corriger l'image d'organisme donateur ou d'ONG que peut avoir l'OMS. Envisager d'élaborer un document de deux pages sur la nouvelle stratégie de coopération avec le pays.	Bureau de pays	Moyenne
d. <i>Élaborer un plan biennal d'appui au pays doit être élaboré dans le respect de la structure de l'Organisation. Il définira la contribution des trois niveaux de l'Organisation à Djibouti.</i>	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale /Unité d'appui aux pays du Siège	Élevée

Recommandation 4. Aux niveaux national et régional, l'OMS doit aider le Ministère de la santé à renforcer son rôle de leadership et de coordination.		
a. <i>S'attaquer aux freins qui entravent la mise en œuvre du PNDS au niveau de la planification des opérations, de la budgétisation et du suivi.</i> L'OMS doit aider le Ministère à mettre en place cette planification et ce suivi à tous les niveaux du système de santé et apporter un appui technique à long terme permettant d'assurer la pérennité de ces processus.	Bureau de pays/Ministère de la santé et partenaires du secteur de la santé	Moyenne
b. <i>Apporter un appui à la révision du PNDS actuel et à l'élaboration du nouveau PNDS.</i> Aider le Ministère de la santé à engager un vaste processus de dialogue avec les principaux acteurs du secteur de la santé ainsi qu'avec d'autres ministères, le but étant de favoriser l'adoption d'une approche multisectorielle, de mettre en place des stratégies visant à améliorer la réglementation sanitaire et d'accroître l'harmonisation et la cohérence des prestataires de services de santé, sous la direction du Ministère.	Bureau de pays/Ministère de la santé et partenaires du secteur de la santé	Élevée
c. Recommander au Gouvernement djiboutien d'affecter des ressources à ce rôle de coordination au sein du Ministère	Bureau de pays/Gouvernement djiboutien	Moyenne
d. <i>Promouvoir la reprise des travaux du Groupe des partenaires santé et réfléchir, en concertation avec le Ministère de la santé, à la manière de tirer le meilleur parti de cette plateforme</i>	Bureau de pays/Ministère de la santé	Élevée
e. Dialoguer avec des donateurs au sein de plateformes mondiales pouvant être activées au niveau national, telles que le Plan d'action mondial pour la réalisation de l'ODD 3 et le Partenariat international pour la santé (IHP+). Le Bureau régional de la Méditerranée orientale pourrait assurer la liaison avec d'autres membres de ces plateformes au niveau régional afin d'étudier des partenariats potentiels au niveau national.	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale /Siège (par exemple, Secrétariat du Plan d'action mondial pour la réalisation de l'ODD 3).	Moyenne
f. Au sein de l'équipe de pays des Nations Unies, soutenir les travaux des organismes non résidents dans le domaine de la santé. L'OMS peut, par exemple, contribuer à mobiliser le soutien des organismes des Nations Unies non résidents tels que l'ONUSIDA, l'OIT et l'AIEA pour aider Djibouti à réaliser ses objectifs prioritaires dans le domaine de la santé.	Bureau de pays/Équipe de pays des Nations Unies	Moyenne
Recommandation 5. L'OMS doit améliorer son efficacité en favorisant une approche mobilisant l'ensemble de la société et des pouvoirs publics.		
a. Rechercher des moyens d'élargir la participation de la société civile et des acteurs communautaires à la gouvernance du secteur de la santé, à la mobilisation communautaire et à la prestation de services	Bureau de pays/Programme sur les soins de santé primaires du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	Moyenne
b. Permettre une action multisectorielle dans des domaines nécessitant une collaboration entre différents ministères, tels que la lutte antivectorielle, la nutrition et la gestion des crises. L'OMS doit aider le Ministère de la santé à consolider et à réorganiser les nombreuses commissions et organes de coordination existant à Djibouti afin d'améliorer leur efficacité.	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et unités et départements correspondants au Siège (Maladies non transmissibles, RAM et Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire).	Moyenne

Recommandation 6. Renforcer l'efficacité de l'OMS en améliorant l'allocation des ressources financières, en renforçant les ressources humaines et en faisant progresser les systèmes de gestion.		
a. Instaurer un dialogue entre le Ministère et le bureau régional pour définir la voie à suivre quant au choix entre la mise en œuvre des activités planifiées ou la réponse à des demandes à court terme.	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	Moyenne
b. <i>Faciliter dès que possible, pour le Bureau régional de la Méditerranée, la mise en œuvre d'un nouvel organigramme, conformément aux recommandations formulées à l'issue de l'examen administratif du Bureau, afin que celui-ci dispose des capacités techniques et administratives suffisantes pour obtenir les résultats escomptés.</i> Il convient de renforcer les capacités du bureau de pays de toute urgence afin d'améliorer ses performances dans les domaines répertoriés (soutenir la réforme de la santé fondée sur une approche des soins de santé primaires, fournir une assistance technique à long terme au Ministère de la santé en vue de la mise en œuvre du PNDS, renforcer la fonction de suivi et d'évaluation, intégrer les questions de genre, l'équité et les droits de manière transversale, accroître la participation de la société civile).	Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	Élevée
c. Pour le Bureau de l'OMS à Djibouti, continuer d'accorder la priorité au recrutement de personnel au niveau national dans le cadre du nouvel organigramme.	Bureau de pays/soutien du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	Moyenne
d. Pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale, mettre en œuvre une approche rationalisée et centrée sur le pays afin de répondre aux besoins techniques et opérationnels du bureau de l'OMS à Djibouti, en inscrivant sa contribution dans un plan intégré à trois niveaux (plan d'appui au pays). Il s'agit, par exemple, d'organiser des réunions de coordination de tous les responsables concernés par le cas de Djibouti et d'examiner chaque année les activités prévues afin de s'assurer qu'elles sont conformes au plan d'appui au pays et rationalisées avant que des demandes ne soient adressées au bureau de pays ; ou de désigner un point focal au sein du bureau régional pour qu'il coordonne les contributions des collègues du bureau régional concernant Djibouti et qu'il assure le suivi de la mise en œuvre des interventions du bureau régional dans le plan d'appui au pays.	Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	Moyenne
Recommandation 7. L'OMS doit veiller à ce que la stratégie de coopération avec le pays soit accompagnée d'un cadre de suivi définissant des valeurs de référence et des valeurs cibles pour les indicateurs de Djibouti, conformément au cadre de résultats mondial et au cadre régional des indicateurs clés de performance.		
a. Élaborer un cadre de suivi définissant des valeurs de référence et des valeurs cibles pour les indicateurs de Djibouti, conformément au cadre de résultats mondial et au cadre régional des indicateurs clés de performance	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale /Département Planification, coordination des ressources et suivi des résultats et Unité d'appui aux pays	Élevée
b. Améliorer la qualité des données et des rapports en affectant suffisamment de personnel à ces tâches ; et améliorer l'utilisation des données de suivi, en analysant régulièrement les progrès accomplis au regard des produits prévus et la contribution aux résultats escomptés afin d'orienter la planification	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale	Moyenne
c. Considérer les rapports établis grâce au tableau de bord des produits comme une occasion de mener une réflexion critique sur la contribution du bureau de pays à des questions transversales telles que l'égalité des genres, l'équité en santé, l'approche fondée sur les droits humains et l'inclusion du handicap. Le processus annuel d'établissement du tableau de bord des produits pourrait être réalisé dans le cadre d'un atelier auquel participerait l'ensemble du personnel du bureau de pays (personnel technique et administratif) et être directement rattaché à l'examen de la planification pour l'année suivante.	Bureau de pays/Département Planification, coordination des ressources et suivi des résultats.	Moyenne
Recommandation 8. En collaboration avec d'autres partenaires de développement, l'OMS doit aider activement le Gouvernement à mener une réforme du secteur de la santé.		
a. Aider le Gouvernement à coordonner l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan multisectoriel de préparation aux urgences sanitaires	Bureau de pays/ Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et Programme de	Moyenne

	gestion des situations d'urgence sanitaire	
b. Encourager les pouvoirs publics à entreprendre les réformes nécessaires pour renforcer le leadership, le rôle de coordination et le pouvoir réglementaire du Ministère de la santé vis-à-vis de tous les acteurs participant à la prestation de services de santé, en collaboration avec d'autres acteurs clés, tels que le Fonds mondial et la Banque mondiale	Bureau de pays/Ministère de la santé et partenaires du secteur de la santé	Moyenne
c. Apporter un appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de financement du secteur de la santé, en s'appuyant sur l'analyse de la situation existante menée récemment par la Banque mondiale sur cette question	Bureau de pays/unité responsable du financement de la santé dans le cadre de la CSU ; Ministère de la santé et partenaires du secteur de la santé	Élevée

6. Enseignements à prendre en compte pour d'autres pays à revenu faible ou intermédiaire

- L'accent mis sur l'octroi d'une assistance technique et d'un soutien opérationnel aux programmes axés sur les maladies, au détriment d'une approche centrée sur le renforcement du système de santé, ne permet pas à l'Organisation d'apporter pleinement sa contribution à Djibouti, en particulier de tirer profit de l'ensemble de ses fonctions en matière de mobilisation, de promotion de la collaboration et des partenariats, de plaider et de renforcement des capacités nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
- Le Gouvernement et le Ministère de la santé ont besoin d'une assistance technique à plus long terme de l'OMS, axée sur le renforcement des capacités. Or, l'OMS a surtout effectué des missions de consultation à court terme de portée limitée.
- La participation de l'OMS à des services de proximité intégrés associant vaccination, soins prénatals et services de nutrition est un bon exemple d'intervention stratégique. Menée en partenariat avec l'UNICEF, cette intervention a donné des résultats positifs et a proposé un modèle de services permettant de répondre aux problèmes de disponibilité et d'accessibilité des services de santé. La mise en commun de ressources avec d'autres organismes dans le cadre de démarches innovantes, l'Organisation mettant l'accent sur son rôle technique au sein du partenariat, est un bon moyen pour l'OMS d'optimiser les résultats de ses activités et d'utiliser ses ressources de manière efficiente.
- L'absence de budgets annuels et de plans opérationnels destinés à la mise en œuvre du plan national de santé, qui est par ailleurs obsolète et devrait être révisé afin d'inclure la réglementation du secteur de la santé dans son ensemble, constitue un problème majeur qui ralentit les progrès dans le domaine de la santé à Djibouti. Cette situation conduit le Ministère de la santé à adopter une approche parant au plus pressé et à planifier à court terme, ce qui affecte la capacité de l'OMS à mettre en œuvre les priorités convenues tout en répondant aux demandes fluctuantes du Ministère.
- Le manque de coordination entre les partenaires de la santé et les organismes de financement constitue un autre obstacle à la mise en œuvre efficace d'une approche axée sur la CSU et les soins de santé primaires à Djibouti, et explique les progrès minimes réalisés dans la mise en œuvre des objectifs relatifs à la CSU. Toutes les catégories de parties prenantes à Djibouti attendent de l'OMS qu'elle joue un rôle de premier plan et aide le Gouvernement et le Ministère à traiter ces questions.
- Alors que les ressources publiques nationales et l'aide publique au développement dans le domaine de la santé ont augmenté au cours de la décennie écoulée, le faible niveau d'investissement public dans le secteur de la santé compromet la pérennité des progrès accomplis en matière de santé à Djibouti, d'autant que les principaux donateurs prévoient de réduire leurs contributions dans le pays. L'OMS doit contribuer à mettre en avant les questions de santé aux niveaux national et régional afin d'accroître le financement durable de la santé, en particulier celui provenant de sources nationales. Le bureau de pays doit se doter de ressources humaines supplémentaires pour pouvoir assumer ce rôle de mobilisation et de leadership.
- Il est difficile de renforcer la participation de tous les groupes sociaux grâce à une approche mobilisant l'ensemble de la société et des pouvoirs publics, et les efforts en ce sens se heurtent à des réticences malgré les efforts déployés par l'OMS. En dépit des difficultés rencontrées, l'OMS doit à l'avenir trouver les moyens de promouvoir une plus large participation de la société civile et des actions multisectorielles dans le domaine de la santé, et encourager les efforts visant à analyser et à traiter les questions d'équité et de droits en matière de santé.

- La stratégie visant à recruter et à fidéliser le personnel dans le bureau de pays pour des postes nationaux a donné des résultats positifs, en ce sens qu'elle a facilité les relations avec les interlocuteurs nationaux et a permis de tirer parti de la connaissance du contexte et du réseau de ces personnes.
- Le manque de coordination entre les différents départements au niveau régional peut avoir un impact négatif sur la capacité du bureau de pays à atteindre les objectifs prévus. Le bureau régional doit modifier sa façon de procéder et adopter une approche centrée sur le pays, visant à répondre aux besoins techniques et opérationnels du bureau de pays de manière coordonnée et dans le souci de créer des synergies.

Références¹⁷

1. Djibouti [site web]. Banque Mondiale; 2024 ([Djibouti | Groupe de la Banque mondiale](#))
2. Observatoire mondial de la santé [site web]. Organisation Mondiale de la Santé (<https://www.who.int/data/gho>)
3. Rapport sur l'état de la population mondiale. New York: UNFPA; 2023. ([SWP Report 2023: 8 Billion Strong | Fonds des Nations Unies pour la population](#))
4. Djibouti [site web]. Bureau de pays du HCR; 2024 (<https://www.unhcr.org/countries/djibouti>)
5. Tableau de bord de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur les tendances migratoires [dashboard]. OIM; 2022 (https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbd1461/files/reports/12.%20DJI_FM_Dec22_Dashboard_FR.pdf)
6. Résultats de la quatrième enquête djiboutienne auprès des ménages pour les indicateurs sociaux (EDAM4-IS). Banque mondiale; 2017 ([Résultats de l'enquête EDAM4-IS 2018 | PDF | Pauvreté | Pauvreté et sans-abri](#))
7. AIDSInfo [site web]. ONUSIDA, UNICEF, OMS (<https://aidsinfo.unaids.org/>)
8. Output scorecard – scoring dimensions, attributes, criteria [Tableau de bord des résultats – Dimensions, attributs et critères d'évaluation]. Genève: Organisation Mondiale de la Santé; 2021 ([Output scorecard–Scoring dimensions, attributes, criteria](#))
9. The Triple Billion targets. A visual summary of methods to deliver impact [Les objectifs « Triple Billion ». Un résumé visuel des méthodes permettant d'avoir un impact]. [site web]. Genève: Organisation Mondiale de la Santé (<https://www.who.int/data/stories/the-triple-billion-targets-a-visual-summary-of-methods-to-deliver-impact>)
10. Guidance on Integrating Human Rights and Gender Equality in evaluations [Recommandations pour l'intégration des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les évaluations]. GNUE; 2014 ([UNEG Guidance on Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations | UNEG](#))
11. Guidance on Integrating Disability Inclusion in Evaluations [Recommandations pour l'intégration de la prise en compte du handicap dans les évaluations]. GNUE; 2022 ([Guidance on \(Integrating Disability Inclusion in Evaluations and Reporting on the UNDIS Entity Accountability Framework Evaluation Indicator | UNEG\)](#))
12. WHO policy on disability [Politique de l'OMS en matière de handicap]. Genève: Organisation Mondiale de la Santé; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/341079>) Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

¹⁷ Toutes ces références ont été consultées le 5 mai 2026

13. Note d'orientation sur l'intégration de l'équité en santé, de l'égalité des genres, de l'inclusion du handicap et des droits humains dans les évaluations de l'OMS. Genève: Organisation Mondiale de la Santé; 2023
(<https://iris.who.int/handle/10665/373677>)
14. Evaluation Practice Handbook [Guide pratique d'évaluation]. Genève: Organisation Mondiale de la Santé; 2013 (<https://iris.who.int/handle/10665/96311>)
15. UNEG Ethical Guidelines for Evaluation [Lignes directrices éthiques pour l'évaluation]. GNUE; 2020 ([UNEG Ethical Guidelines for Evaluation | UNEG](https://www.uneg.org/ethical-guidelines-for-evaluation))
16. Règlement sanitaire international (2005), 2nd ed. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2012 (<https://iris.who.int/handle/10665/43982>).
17. Rapport national volontaire : examen de la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières à Djibouti, République de Djibouti; 2022 (<https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/imrf-djibouti.pdf>)
18. Plan national de développement Djibouti ICI (2020–2024) [communiqué de presse]. République de Djibouti; 2020
(<https://www.undp.org/fr/djibouti/actualites/lancement-officiel-du-plan-national-de-developpement-djibouti-ici>)
19. Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services: second regular session 2022, 29 August to 1 September 2022: Extensions of country programmes [Prolongation du Plan-cadre de coopération]. New York: UNFPA; 2022 (DP/FPA/2022/11; https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/DP.FPA_2022.11%20-%20CPEExt%20for%202022%20SRS%20-%20FINAL%20-%2014Jul22%20_7.pdf)
20. Rapport annuel Djibouti. Nations Unies Djibouti; 2022
(https://djibouti.un.org/sites/default/files/2023-05/UNCT%20Annual%20Report%202022_final_0.pdf)
21. Food Security and Nutrition Monitoring Survey [Enquête de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition]. Djibouti: PAM; 2022)
(<https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000139124/download/>)
22. Rapport de résultats, [budget programme] 2020-2021, Organisation mondiale de la Santé ; 2021 (<https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-2021/country-profile/2021/djibouti>)
23. The WHO programme budget portal [le portail du budget-programme de l'OMS] [site web]. Geneva: World Health Organization; (<https://open.who.int/2022-23/home>)
24. SDG country profile [Profil national des ODD]: Djibouti. [site web]. UNDESA (<https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/dji#goal-3>)
25. Domestic general government health expenditure (% of general government expenditure) – [Dépenses de santé des administrations publiques nationales (en % des dépenses des administrations publiques)] - Djibouti [base de données]. Banque mondiale (<https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.GE.ZS?locations=DJ>)

Pour plus d'informations concernant l'évaluation, veuillez contacter :
le Bureau de l'évaluation de l'Organisation mondiale de la Santé
Email : evaluation@who.int
site Web consacré à l'évaluation (who.int).